BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 60.72.07.01

HÀ NỘI – 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 60.72.07.01

TS Lã Ngọc Quang

HÀ NỘI – 2014

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, đồng nghiệp, gia đình và bè bạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo sau Đại học, cùng các thầy cô giáo trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp đã tạo mọi điều kiện để lớp Cao học Quản lý Bệnh viện khóa 5 - Đồng tháp thuận lợi hoàn thành.

Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Lã Ngọc Quang, người thầy đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm của mình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu để tôi hoàn thành luận văn một cách tốt nhất.

Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tới Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo của 10 khoa lâm sàng và 213 điều dưỡng viên, tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian thu thập số liệu và hoàn thành luận văn.

Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới gia đình, bạn bè, các đồng nghiệp - những người đã luôn động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Bến Tre, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Nguyễn Thị Thùy Trâm

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC BẢNG v
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
1. 1. Tổng quan về điều dưỡng và công tác chăm sóc người bệnh 4
1.1.1. Lịch sử ngành điều dưỡng 4
1.1.2. Các định nghĩa về điều dưỡng 4
1.1.3. Khái niệm về công tác chăm sóc người bệnh 5
1.1.4. Chức năng của người điều dưỡng 5
1.1.5. Vai trò và nhiệm vụ của người điều dưỡng 5
1.1.6. Nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng 6
1.2. Các Văn bản pháp lý liên quan đến công tác CSNB trong bệnh viện 7
1.3. Các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam về nhiệm vụ CSNB 8
1.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới về nhiệm vụ CSNB của ĐDV 8
1.3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam về nhiệm vụ CSNB của ĐDV 9
1.4. Thông tin chung về bệnh viện và công tác CSNB tại BVNĐC, Bến Tre 17
1.4.1. Giới thiệu chung về bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 17
1.4.2. Công tác CSNB tại bệnh viện Nguyễn Đình chiểu 17
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
2.1. Đối tượng nghiên cứu 19
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 19
2.3. Thiết kế nghiên cứu: 19
2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 19
2.5. Phương pháp thu thập số liệu: 20

2.6. Các biến số nghiên cứu 23
2.7. Một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu và tiêu chí đánh giá 23
2.8. Phương pháp phân tích số liệu 25
2.9. Đạo đức trong nghiên cứu 25
2.10. Hạn chế của nghiên cứu và hướng khắc phục 26
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28
3.1.Thực trạng về việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV tại BVNĐC 28
3.1.1. Thông tin chung về ĐDV tham gia nghiên cứu 28
3.1.2. Mức độ hoàn thành đối với từng nhiệm vụ CSNB của ĐDV 29
3.1.3. Việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV phân bố theo khoa 36
3.2. Một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV 37
3.2.1. Yếu tố cá nhân liên quan đến thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV 37
3.2.2. Các yếu tố tổ chức liên quan đến thực hiện nhiệm vụ CSNB 41
Chương 4. BÀN LUẬN 43
4.1. Thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV tại BVNĐC, tỉnh Bến Tre năm 2014 43
4.1.1. Các thông tin chung về ĐDV tham gia nghiên cứu 43
4.1.2. Mức độ hoàn thành đối với từng nhiệm vụ CSNB của ĐDV 44
4.2. Một số yếu tố có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV .. 55
4.2.1. Các yếu tố cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB ... 55
4.2.2. Các yếu tố tổ chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB ... 59
KẾT LUẬN 62
KHUYẾN NGHỊ 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
PHỤ LỤC 72

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BHYT	Bảo hiểm Y tế
BVNĐC	Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
BYT	Bộ Y tế
CSNB	Chăm sóc người bệnh
CSNBTD	Chăm sóc người bệnh toàn diện
CTCH	Chấn thương chỉnh hình
DHST	Dấu hiệu sinh tồn
ĐDV/HSV	Điều dưỡng viên/hộ sinh viên
ĐTV	Điều tra viên
ĐTTYC	Điều trị theo yêu cầu
GDSK	Giáo dục sức khỏe
HSBA	Hồ sơ bệnh án
HSTC	Hồi sức tích cực
NTK	Ngoại thần kinh
NTQ	Ngoại tổng quát
NNNB	Người nhà người bệnh
NVYT	Nhân viên y tế
NTK-NT	Nội Thần kinh – Nội tiết
NTH	Nội tổng hợp
PHCN	Phục hồi chức năng
QSV	Quan sát viên
SLTC	Số liệu thứ cấp

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Số ĐDV đồng ý tham gia vào nghiên cứu tại 10 khoa lâm sàng 20
Bảng 3.1. Thông tin chung về ĐDV tham gia nghiên cứu 28
Bảng 3.2. Đánh giá chung việc thực hiện 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV 35
Bảng 3.3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV phân bố theo khoa.... 36
Bảng 3.4. Mối liên quan giữa các yếu tố cá nhân với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV 37
Bảng 3.5. Mối liên quan giữa tuổi, trình độ chuyên môn của ĐDV với các nhiệm vụ CSNB 38
Bảng 3.6. Mối liên quan giữa giới tính của ĐDV với mức độ hoàn thành các nhiệm vụ CSNB..... 39
Bảng 3.7. Mối liên quan giữa thâm niên công tác và vị trí được phân công với mức độ hoàn thành các nhiệm vụ CSNB 40
Bảng 3.8. Mối liên quan giữa số nhân lực điều dưỡng và thời gian trực tiếp CSNB với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB..... 41
Bảng 3.9. Mối liên quan giữa số người bệnh trung bình/ĐDV trực tiếp chăm sóc tại các chuyên khoa với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB 42

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tư vấn GDSK.....29
Biểu đồ 3.2. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc về tinh thần.....30
Biểu đồ 3.3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc vệ sinh cá nhân 30
Biểu đồ 3.4. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc về dinh dưỡng.....31
Biểu đồ 3.5. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc phục hồi chức năng.....31
Biểu đồ 3.6. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB có phẫu thuật/thủ thuật 32
Biểu đồ 3.7. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc .32
Biểu đồ 3.8. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong....33
Biểu đồ 3.9. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng..33
Biểu đồ 3.10. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo dõi, đánh giá người bệnh.....34
Biểu đồ 3.11. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm người bệnh an toàn.....34
Biểu đồ 3.12. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ ghi chép hồ sơ bệnh án 35

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

Chăm sóc người bệnh là nhiệm vụ chuyên môn của điều dưỡng viên (ĐDV) nhằm đáp ứng các nhu cầu của người bệnh và góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện. Để có cơ sở đánh giá chất lượng bệnh viện trong lĩnh vực CSNB, chúng tôi tiến hành nghiên cứu *"Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2014",* với mục tiêu: *Mô tả thực trạng việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên.*

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 10 khoa lâm sàng của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2014 bằng phương pháp quan sát để đánh giá việc thực hiện 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV và phát vấn ĐDV để xác định một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB.

Kết quả khảo sát 213 ĐDV cho thấy, có 7/12 nhiệm vụ CSNB được ĐDV thực hiện hoàn thành đạt từ 71,4% đến 89,2%. Chiếm tỷ lệ thấp là nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK và chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh (20,2% và 27,2%); đánh giá chung về mức độ hoàn thành 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV là 60,6%. Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV với một số yếu tố: độ tuổi, thâm niên công tác và vị trí được phân công CSNB.

Khuyến nghị cơ bản của nghiên cứu là bệnh viện cần cập nhật kiến thức, kỹ năng tư vấn, hướng dẫn GDSK cho ĐDV, chú trọng đến đội ngũ ĐDV trẻ, có ít thâm niên công tác, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động CSNB của ĐDV.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăm sóc điều dưỡng là một hoạt động nghề nghiệp, đòi hỏi điều dưỡng viên (ĐDV) cần phải làm việc chủ động, sáng tạo, phải có cả kiến thức lẫn kỹ năng để là người cộng sự không thể thiếu được của bác sĩ. Nhiệm vụ chuyên môn của ĐDV là chủ động trong chăm sóc nhằm đáp ứng các nhu cầu của người bệnh và phối hợp với các nhân viên y tế khác để bảo đảm người bệnh nhận được dịch vụ chăm sóc với chất lượng cao nhất, an toàn nhất và tiện nghi nhất.

Trong chiến lược phát triển công tác điều dưỡng, hộ sinh năm 2002-2008, Tổ chức Y tế thế giới đã khẳng định: dịch vụ do điều dưỡng viên, hộ sinh viên cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống dịch vụ y tế. Kinh tế ngày càng phát triển, nhận thức và thái độ về sức khỏe của người dân thay đổi, đòi hỏi phải tăng cường chuẩn mực chăm sóc của ĐDV [11]. Những năm gần đây, trình độ của ĐDV được nâng cao nên chất lượng chăm sóc người bệnh ngày càng tăng. Tuy nhiên, công tác điều dưỡng hiện nay còn một số bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và sự hài lòng của người bệnh. Tình trạng quá tải, thiếu nhân lực nên ở một số nơi điều dưỡng đã giao phó những công việc chăm sóc cơ bản như vệ sinh cá nhân, hỗ trợ ăn uống và vận động đi lại cho người nhà người bệnh và thậm chí là cả những nhiệm vụ chuyên môn như thay chai truyền dịch, bóp bóng oxy, cho người bệnh ăn qua sonde dạ dày [43].

Thông tư số 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, được ban hành ngày 26/01/2011 với nguyên tắc: Người bệnh là trung tâm của công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, bảo đảm hài lòng, chất lượng và an toàn. Các hoạt động chăm sóc của ĐDV phải dựa trên cơ sở các yêu cầu chuyên môn và sự đánh giá nhu cầu của mỗi người bệnh [9]. Thông tư cũng đã quy định cụ thể về 12 nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh của ĐDV. Điều này sẽ từng bước cải thiện công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng 2. Năm 2013, số giường bệnh kế hoạch là 1000 giường bệnh, số giường bệnh thực kê là 1.094, với 06 phòng chức năng, 18 khoa lâm sàng và 09 khoa cận lâm

sàng. Số lượt khám chữa bệnh là 536.717 lượt; số lượt người bệnh được điều trị nội trú là 46.288, công suất sử dụng giường bệnh đạt 90,91% [14]. Bệnh viện bắt đầu áp dụng mô hình CSNB toàn diện từ năm 2003, chất lượng CSNB ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu nhân lực bác sĩ và sự quá tải cục bộ tại một số khoa lâm sàng đã làm tăng áp lực công việc cho đội ngũ điều dưỡng [16].

Từ khi Thông tư 07/2011/TT-BYT được ban hành, bệnh viện đã nhanh chóng triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; cân đối nhân lực điều dưỡng, hộ sinh về số lượng, trình độ và phân công hợp lý; tăng cường các phương tiện phục vụ nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu CSNB. Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng vừa ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, quan điểm chủ đạo để xây dựng bộ tiêu chí *"Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị"*[12]. Do đó, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cần có kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng hiện tại của bệnh viện, trong đó có hoạt động CSNB. Vậy, thực trạng hoạt động CSNB tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu như thế nào? việc thực hiện 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV đạt mức độ nào? Những yếu tố nào liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV? Để tìm hiểu rõ vấn đề này và có cơ sở đánh giá chất lượng bệnh viện trong lĩnh vực CSNB, chúng tôi tiến hành nghiên cứu *"Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2014"*.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1. Mô tả thực trạng việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2014.

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2014.

Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1. 1. Tổng quan về điều dưỡng và công tác chăm sóc người bệnh

1.1.1. Lịch sử ngành điều dưỡng

Hy lạp - năm 60, Bà Phoebe đã đến từng gia đình có người bệnh để chăm sóc và được ngưỡng mộ suy tôn là người nữ điều dưỡng tại gia đầu tiên của thế giới. Đến giữa thế kỷ thứ 18 đầu thế kỷ thứ 19, bà Florence Nightingale (1820 - 1910) một phụ nữ người Anh đã được thế giới tôn kính và suy tôn là người sáng lập ra ngành điều dưỡng. Ngày nay, ngành điều dưỡng của th ế giới đã được xếp là một ngành riêng biệt, ngang hàng với các ngàn h nghề khác và c ó nhiều trường đào tạo điều dưỡng với nhiều trình độ khác nhau [7], [8], [44].

Cũng như thế giới, tại Việt Nam, sự du nhập của nền Y học phương tây bắt đầu từ thời kỳ Pháp thuộc đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, các lớp điều dưỡng sơ học được mở nhằm đáp ứng nhu cầu cho kháng chiến. Năm 1975, Bộ Y tế đã thống nhất chỉ đạo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong cả nước. Đến nay, nghề điều dưỡng đã có hệ thống tổ chức, đào tạo nghề ở các bậc từ sơ học đến đại học và sau đại học; có luật hành nghề và đạo đức hành nghề [8], [44].

1.1.2. Các định nghĩa về điều dưỡng

Năm 1965, Hội điều dưỡng Mỹ đưa ra định nghĩa *"Điều dưỡng là một nghề hỗ trợ cung cấp các dịch vụ chăm sóc đóng góp vào việc phục hồi và nâng cao sức khỏe"* [5].

Tại Việt Nam, theo từ điển tiếng Việt, nhà xuất bản Khoa học xã hội 1999 định nghĩa *"Y tá là người có trình độ trung cấp trở xuống và chăm sóc người bệnh theo y lệnh bác sĩ"*. Định nghĩa này chưa phản ánh đầy đủ vị trí và vai trò của người điều dưỡng cũng như nghề điều dưỡng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe hiện nay [5]. Ngày nay, người điều dưỡng đã được công nhận là một nghề nghiệp độc lập, cùng với các bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên và các thành phần trong hệ thống y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, người làm điều dưỡng gọi là điều dưỡng viên [21].

Điều dưỡng viên (bao gồm cả nam và nữ) là những người có nền tảng khoa

học cơ bản về điều dưỡng, đáp ứng các tiêu chuẩn được kê toa tùy theo sự giáo dục và sự hoàn thiện lâm sàng [21].

Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV, ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ Nội vụ, quy định chức trách của điều dưỡng là viên chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, thực hiện, tổ chức thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại các cơ sở y tế [2].

1.1.3. Khái niệm về công tác chăm sóc người bệnh

Chăm sóc điều dưỡng là những chăm sóc chuyên môn của người điều dưỡng đối với người bệnh từ khi vào viện đến lúc ra viện. Nội dung chính bao gồm: chăm sóc thể chất, tinh thần, dinh dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc, theo dõi, phục hồi chức năng, giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Chăm sóc điều dưỡng bắt đầu từ lúc người bệnh đến khám, vào viện và cho đến khi người bệnh ra viện hoặc tử vong [24].

Chăm sóc người bệnh trong bệnh viện bao gồm hỗ trợ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mỗi người bệnh nhằm duy trì hô hấp , tuần hoàn, thân nhiệt, ăn uống, bài tiết, tư thế, vận động, vệ sinh cá nhân, ngủ, nghỉ; chăm sóc tâm lý; hỗ trợ điều trị và tránh các nguy cơ từ môi trường bệnh viện cho người bệnh [9].

Nguyên tắc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện là đảm bảo "Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị" dựa trên đánh giá các nhu cầu của người bệnh và hướng tới người bệnh để phục vụ [9], [12].

1.1.4. Chức năng của người điều dưỡng

Chức năng của người điều dưỡng theo Tổ chức Y tế thế giới, được thể hiện ở ba chức năng chính (1) c*hức năng phụ thuộc*: là các hoạt động thực hiện theo y lệnh của bác sĩ; (2) c*hức năng phối hợp*: là phối hợp với các thành viên trong nhóm chăm sóc, nhân viên chuyên ngành khác, phối hợp với người bệnh để hoàn thành kế hoạch CSNB đạt hiệu quả cao; (3) c*hức năng độc lập*: là các hoạt động trong phạm vi kiến thức được đào tạo để thực hành, chẩn đoán điều dưỡng và xử trí không cần bác sĩ ra y lệnh như đáp ứng 14 nhu cầu cơ bản của người bệnh [46].

1.1.5. Vai trò và nhiệm vụ của người điều dưỡng

Vai trò người chăm sóc là thuộc tính cơ bản của người điều dưỡng, đây là nền tảng của mọi can thiệp điều dưỡng. Jen Watson cho rằng "Thực hành chăm sóc là

hạt nhân của nghề điều dưỡng" [6]. Chăm sóc thể hiện ở việc sử dụng quy trình kỹ thuật để thực hiện chăm sóc người bệnh; Theo dõi diễn tiến bệnh và báo ngay với bác sĩ những dấu hiệu bất thường; thực hiện các y lệnh điều trị, chăm sóc; thực hiện các kỹ thuật thực hành điều dưỡng theo đúng quy trình, và đảm bảo vô khuẩn, hạn chế nhiễm trùng bệnh viện [46].

Ngày 26/01/2011 Bộ Y tế đã có quy định mới nhất về nhiệm vụ của điều dưỡng viên, hộ sinh viên về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện với 12 nhiệm vụ cụ thể là: (1) Tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe; (2) Chăm sóc về tinh thần; (3) Chăm sóc vệ sinh cá nhân; (4) Chăm sóc dinh dưỡng; (5) Chăm sóc phục hồi chức năng; (6) Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật; (7) Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh; (8) Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và người bệnh tử vong; (9) Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng; (10) Theo dõi, đánh giá người bệnh; (11) Bảo đảm an toàn phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh; (12) Ghi chép hồ sơ bệnh án [9].

1.1.6. Nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng

Người điều dưỡng có bốn trách nhiệm cơ bản: Nâng cao sức khỏe; phòng bệnh và tật; phục hồi sức khỏe và làm giảm bớt đau đớn cho người bệnh. Trách nhiệm về đạo đức nghề nghiệp của người điều dưỡng bao gồm:

- Người điều dưỡng với người bệnh: đảm bảo cho mọi cá thể nhận được thông tin cần thiết làm cơ sở để họ đồng ý chấp nhận các phương pháp điều trị [45].
- Người điều dưỡng với nghề nghiệp: luôn gắn liền trách nhiệm và nghĩa vụ cá nhân đối với việc thực hành và thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn thông qua học tập liên tục. Trong khi sử dụng các kỹ thuật và khoa học hiện đại vào việc chăm sóc cần đảm bảo sự an toàn, nhân phẩm và quyền của con người [45].
- Người điều dưỡng với phát triển nghề nghiệp: phải đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong việc xác định và thực hiện những chuẩn mực về thực hành chăm sóc lâm sàng, quản lý, nghiên cứu và đào tạo [45].
- Điều dưỡng với đồng nghiệp: cộng tác giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, phê bình có thiện chí và truyền thụ kinh nghiệm [45].

1.2. Các Văn bản pháp lý liên quan đến công tác CSNB trong bệnh viện

Trước đây, chức năng nhiệm vụ của người điều dưỡng là thực hiện y lệnh, phụ thuộc vào chỉ định của bác sĩ nên công tác chăm sóc của điều dưỡng chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người bệnh. Hầu hết công tác chăm sóc cơ bản cho người bệnh được người nhà đảm nhiệm. Để khắc phục tình trạng này, năm 1993 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 526/QĐ-BYT ban hành chế độ trách nhiệm của y tá trong việc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện và công văn số 3722/BYT-ĐTr hướng dẫn triển khai Quyết định trên [3]. Năm 1996, Thông tư 11/1996/TT-BYT về hướng dẫn tổ chức thực hiện CSNBTD và củng cố hệ thống điều dưỡng trưởng được ra đời. Công tác CSNBTD được thể chế hoá thành Quy chế CSNBTD trong Quy chế bệnh viện [4]. Đến năm 2003, Chỉ thị 05/2003/BYT-CT của Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu mọi cán bộ y tế đều có trách nhiệm thực hiện CSNBTD, các bệnh viện phải tăng cường công tác CSNBTD [26].

Năm 2011, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về c hăm sóc người bệnh trong bệnh viện và có h iệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011, thay thế Quy chế CSNBTD trong Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997, nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng chăm sóc ngày càng cao hơn [9]. Thông tư này là sự cập nhật phù hợp giữa các văn bản pháp luật, tình hình thực tế, nâng cao vị thế nghề nghiệp, đặt công tác điều dưỡng trong mối quan hệ mang tính hệ thống, trao quyền cho các đơn vị vận dụng linh hoạt trong tổ chức quản lý điều dưỡng, quy định cụ thể về nhiệm vụ chăm sóc. Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định số 4858/QĐ-BYT về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Đây chính là cơ sở để chúng tôi tiến hành nghiên cứu *"Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre, năm 2014"*. Khung lý thuyết và các biến số của nghiên cứu này được xây dựng dựa trên tham khảo thông tin của Thông tư 07/2011/TT-BYT, Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và Hướng dẫn đánh giá chất lượng CSNB trong các bệnh viện của Hội điều dưỡng Việt Nam [12], [18], [24].

1.3. Các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam về nhiệm vụ CSNB

1.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới về nhiệm vụ CSNB của điều dưỡng

Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh là một khía cạnh cơ bản của CSNB, giáo dục nhưng nghèo thông tin là vấn đề phổ biến nhất của các khiếu nại của người bệnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo Aghakhani và các cộng sự (2012), nghiên cứu về thừng rào cản quan trọng nhất của GDSK người bệnh là tình hình làm việc của điều dưỡng, là kiến thức thấp của điều dưỡng và không thấy tầm quan trọng của GDSK. Về cơ sở bệnh viện, là thiếu các nguồn tài nguyên để thực hiện GDSK [51]. Nghiên cứu này cho thấy, sự tương tác giữa người bệnh, bác sĩ, điều dưỡng và các yếu tố hệ thống có ý nghĩa đối với việc thực hiện GDSK cho người bệnh.

Chăm sóc răng miệng là một khía cạnh thiết yếu quan trọng của chăm sóc điều dưỡng. Một nghiên cứu cắt ngang của Hajbaghery và Ansari (2013), được tiến hành trên 130 điều dưỡng từ 6 đơn vị chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện trường Đại học ở Iran. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những rào cản quan trọng nhất để chăm sóc răng miệng cho người bệnh là: quá nhiều nhiệm vụ ghi chép, tiếp theo là thiếu thời gian, thiếu nhân viên, thiếu kiến thức và sự nhận thức rằng chăm sóc răng miệng không là nhiệm vụ ưu tiên. Đây là những rào cản chính trong thực hiện chăm sóc răng miệng cho người bệnh nặng [50]. Tuy nhiên, cần có một nghiên cứu quan sát tiền cứu để có thể phản ánh chính xác hơn thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc răng miệng cho người bệnh.

Các yếu tố liên quan đến việc thực hiện CSNB của ĐDV có thể nói đến là giới tính. Theo Ozdemir (2008), nghiên cứu về giới và nghề nghiệp, nhận thức của sinh viên điều dưỡng về vai trò của ĐDV nam ở Thổ Nhĩ Kỳ, kết quả chỉ ra rằng nghề điều dưỡng vẫn được coi là nghề phù hợp cho phái nữ, nhưng trong một vài hoạt động CSNB vẫn cần có điều dưỡng nam. 47,8% sinh viên điều dưỡng nam tin rằng nam giới sẽ cải thiện chất lượng CSNB vì sức mạnh thể chất của họ, đặc biệt là ở các khu vực ICU, phòng mổ, khoa cấp cứu là nơi thích hợp cho nam giới làm việc, còn khoa Nhi là nơi làm việc thích hợp cho giới nữ. Vì vậy, nam giới sẽ gặp khó khăn ở vài hoạt động chăm sóc được cho là vai trò truyền thống của nữ giới [61].

Ngoài ra, các yếu tố về thời gian trung bình điều dưỡng trực tiếp CSNB, số nhân lực điều dưỡng tham gia chăm sóc, khối lượng công việc cũng liên quan đến chất lượng CSNB và sự an toàn của người bệnh [53], [55], [56], [60]. Tuy nhiên, trong khuôn khổ nghiên cứu này chúng tôi không đề cập đến khối lượng công việc của điều dưỡng.

Theo nghiên cứu của J.Needleman và các cộng sự (2002), tiến hành bằng phương pháp sử dụng dữ liệu hành chính từ năm 1997 cho 799 bệnh viện tại 11 tiểu bang (bao gồm 5.075.969 bệnh nhân nội khoa và 1.104.659 bệnh nhân phẫu thuật) để kiểm tra mối liên quan giữa thời gian chăm sóc của điều dưỡng với kết quả điều trị của bệnh nhân. Kết quả cho thấy, số giờ trung bình mỗi người bệnh được điều dưỡng chăm sóc mỗi ngày là 7,8 giờ, thời gian trung bình mỗi người bệnh được điều dưỡng chăm sóc mỗi ngày cao có liên quan đến chất lượng CSNB tốt và thời gian nằm viện của người bệnh ngắn hơn [60]. Tuy nhiên, nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp nên có thể chưa phản ánh đầy đủ về các hoạt động chăm sóc so với thực tế, vì vậy cần có một nghiên cứu quan sát thực tế để có đánh giá khách quan hơn.

1.3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam về nhiệm vụ CSNB của ĐDV

GDSK là một nhiệm vụ quan trọng của điều dưỡng nhằm giúp người bệnh và gia đình người bệnh hiểu biết về tình hình sức khỏe để hợp tác trong điều trị, duy trì và cải thiện sức khỏe. Thông tư 07/2011/TT-BYT đã đặt nhiệm vụ này đầu tiên trong 12 nhiệm vụ của ĐDV, HSV và Bộ Y tế cũng đặt nhiệm vụ này trong tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Vì vậy, người điều dưỡng cần phải có kỹ năng và kiến thức tốt để thực hiện tư vấn GDSK cho người bệnh và NNNB trong phạm vi chuyên môn của mình.

Hiện nay, việc GDSK hầu như chưa được điều dưỡng quan tâm và thực hiện thường xuyên, cụ thể: theo kết quả nghiên cứu của Bùi Thị Bích Ngà (2011), đánh giá của 266 người bệnh về thực trạng công tác chăm sóc của điều dưỡng tại bệnh viện Y học Cổ truyền trung ương, tỷ lệ người bệnh được GDSK chỉ đạt 49,6% [32]; Nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh (2012), đánh giá thực trạng công tác CSNB tại các khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị, khảo sát 216 người bệnh thì tỷ lệ người bệnh được GDSK chỉ đạt 66,2% [28]; Nghiên cứu của Trần Ngọc Trung (2012),

đánh giá hoạt động CSNB của ĐDV tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, khảo sát 400 người bệnh. Kết quả, tỷ lệ người bệnh được ĐDV tư vấn, hướng dẫn GDSK chỉ đạt 24,7% [47]. Riêng đối với nghiên cứu của Châu Thi Hoa (2010) tại Trung tâm ung bướu bệnh viện trung ương Huế, khảo sát 75 người bệnh ung thư hạ họng - thực quản, kết quả cho thấy tỷ lệ người bệnh được chăm sóc GDSK chiếm khá cao (76%) [22]. Nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn (2011) tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, đánh giá hoạt động CSNB của ĐDV qua người bệnh, NNNB, tỷ lệ người bệnh được tư vấn, GDSK là 83,3% [48]. Nghiên cứu tương tự của Trần Thị Thảo tại bệnh viện này năm 2013, kết quả đánh giá chung về việc thực hiện tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh và NNNB của ĐDV cũng đạt tỷ lệ 74,1% [42], Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu này được tiến hành từ lấy ý kiến của người bệnh và NNNB, vì vậy cần thực hiện đánh giá thêm bằng quan sát trực tiếp để có số liệu khách quan hơn.

Chăm sóc về tinh thần là nhiệm vụ không thể thiếu của người điều dưỡng. Nghiên cứu của Nguyễn Trường Sơn (2007), tìm hiểu cảm xúc và nhu cầu chăm sóc về mặt tinh thần của người bệnh ở bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 230 người bệnh, trong đó 98 người bệnh điều trị nội trú và 132 người bệnh ngoại trú. Kết quả cho thấy, đa số người bệnh vào khám và chữa bệnh đều có nhu cầu chăm sóc về mặt tinh thần (86,5%), đối tượng mà người bệnh chọn để chia sẻ và tư vấn là điều dưỡng chiếm tỷ lệ lần lượt là 28,7% và 27,2%. Tâm lý người bệnh sợ khi vào viện khám, chữa bệnh chiếm tỷ lệ 53,5%. Điều đáng lưu ý là có đến 15,4% người bệnh cho rằng sợ nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý) [37]. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc tinh thần cho người bệnh của ĐDV đạt ở mức độ nào.

Nghiên cứu của Châu Thị Hoa và Nguyễn Thị Diệu Trang (2010), về thực trạng công tác CSNB ung thư hạ họng - thanh quản tại Trung tâm Ung bướu bệnh viện Trung Ương Huế. Kết quả phỏng vấn người bệnh và lấy số liệu từ 75 HSBA của người bệnh ung thư hạ họng - Thanh quản cho thấy, có 90,7% người bệnh được chăm sóc hỗ trợ tinh thần, 80% người bệnh được giao tiếp trước, trong và sau thực hiện các thủ thuật [22]. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xác định được các yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc tinh thần cho người bệnh của ĐDV.

Mục tiêu của điều dưỡng là giúp người bệnh đạt được tính độc lập càng sớm càng tốt. Chính vì vậy, người điều dưỡng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản để người bệnh chóng hồi phục sức khỏe.

Nghiên cứu của Phạm Lê Hưng tiến hành tại 7 bệnh viện ở thành phố Hà Nội, bằng phiếu phỏng vấn 350 điều dưỡng để đánh giá thực hành chăm sóc răng miệng cho người bệnh hồi sức cấp cứu, kết quả cho thấy, chỉ có 31,7% điều dưỡng thực hành tốt chăm sóc răng miệng [25]. Nghiên cứu cũng tìm thấy các yếu tố liên quan chặc chẽ đến thực hành chăm sóc răng miệng cho người bệnh là công tác đào tạo ở trường Trung cấp Y tế, sự giám sát, hướng dẫn của điều dưỡng trưởng khoa và các bác sĩ điều trị. Mặc dù nghiên cứu thực hiện trên phạm vị rộng, nhưng dừng lại ở phỏng vấn điều dưỡng chứ chưa thực hiện quan sát trực tiếp để có kết quả khách quan hơn.

Nghiên cứu của Trần Thị Thảo (2013), tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, việc chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh như: hỗ trợ đại tiểu tiện, vệ sinh cá nhân, ăn uống, thay đồ vải, tỷ lệ NNNB đảm nhiệm giảm dần từ 78,1% xuống 63,6%, thay vào đó là do sự hỗ trợ của NVYT, sự phối hợp giữa NVYT và NNNB, tỷ lệ này tăng dần từ 10,5% đến 22,2%. Về nhu cầu tập luyện phục hồi chức năng được NVYT trực tiếp thực hiện là 30,6%. Kết quả thể hiện, ĐDV tại bệnh viện này đã có chuyển biến tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu chăm sóc cơ bản cho người bệnh [42].

Nghiên cứu của Trần Ngọc Trung (2012), tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, điều dưỡng thực hiện chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh chiếm tỷ lệ thấp: vệ sinh răng miệng (5,0%), hỗ trợ đại tiểu tiện (15%), thay đồ vải (13,7%), cho người bệnh ăn qua thông dạ dày (18,3%) và đáp ứng nhu cầu phục hồi chức năng cho người bệnh đạt từ 15% đến 38,3%. Hướng dẫn người bệnh về chế độ dinh dưỡng, thực hiện thuốc và theo dõi dùng thuốc tỷ lệ lần lượt là 86,7%, 96,7% và 91,7%, có 98,3% người bệnh được công khai thuốc hàng ngày. Các yếu tố tác động và cản trở nhiều nhất đến hoạt động CSNB theo ý kiến của ĐDV là thiếu phương tiện (52,7%), thiếu nhân lực (48,3%); thiếu thời gian (21,8%); thiếu trình độ chuyên môn và lớn tuổi (10%) và thiếu sự quan tâm của lãnh đạo (6,7%) [47]. Tuy nhiên,

nghiên cứu chưa xác định mối liên quan giữa các yếu tố tác động và cản trở nêu trên với việc thực hiện các nhiệm vụ CSNB của ĐDV.

Nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh (2012) tại bệnh viện Hữu Nghị, tỷ lệ ĐDV trực tiếp giúp người bệnh nặng trong chăm sóc vệ sinh cá nhân chỉ chiếm 11,5%, còn người bệnh đánh giá được điều dưỡng hướng dẫn, giải thích chế độ ăn theo bệnh tật thì đạt tỷ lệ cao (90,7%). Công tác chăm sóc, hỗ trợ về tâm lý, tinh thần được người bệnh đánh giá cũng chiếm tỷ lệ cao (94,9%). Đối với nhiệm vụ theo dõi và đánh giá người bệnh, ĐDV thực hiện rất tốt (94%), thực hiện thuốc, theo dõi dùng thuốc và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cũng được người bệnh đánh giá cao trên 90% [28]. Tuy nhiên, các yếu tố liên quan đến hoạt động CSNB của ĐDV chỉ được xác định bằng phương pháp nghiên cứu định tính, vì vậy cần thực hiện thêm nghiên cứu định lượng để có tính khách quan hơn.

Chăm sóc dinh dưỡng góp phần quan trọng trong điều trị và đặc biệt quan trọng hơn đối với người bệnh nuôi ăn qua sonde dạ dày. Qua khảo sát 102 người bệnh được nuôi ăn qua sonde dạ dày tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre của Võ Thị Trang Đài (2010), kết quả cho thấy chỉ có 8,8% gia đình người bệnh được NVYT tư vấn về dinh dưỡng. Điều đáng ghi nhận là có đến 43,1% NNNB tự cho người bệnh ăn qua sonde dạ dày [19]. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa xác định các yếu tố liên quan đến việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh của ĐDV.

Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật là nhiệm vụ của điều dưỡng nhằm giúp người bệnh ổn định tâm lý và an tâm khi trải qua cuộc phẫu thuật, thủ thuật. Một nghiên cứu của Trần Thị Tuyết Nga (2010), khảo sát 150 người bệnh có chỉ định phẫu thuật chương trình về tâm lý trước phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Kết quả cho thấy, chỉ có 47,3% người bệnh được tư vấn trước phẫu thuật, trong đó có đến 60,0 % người bệnh chưa hài lòng về việc tư vấn trước phẫu thuật [33]. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xác định yếu tố liên quan đến việc tư vấn GDSK cho người bệnh trước phẫu thuật của ĐDV.

Điều dưỡng là người trực tiếp dùng thuốc hoặc hướng dẫn người bệnh dùng thuốc, hiểu biết của người điều dưỡng trong quá trình chăm sóc bằng thuốc sẽ giúp việc sử dụng thuốc cho người bệnh vừa hiệu quả vừa an toàn. Nghiên cứu của

Nguyễn Thị Hồng Nương về hiệu quả các giải pháp nâng cao kỹ năng chăm sóc bằng thuốc của điều dưỡng bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2012 qua khảo sát 94 điều dưỡng tại 5 khoa lâm sàng trước và sau khi can thiệp bằng tập huấn và kiểm tra giám sát. Kết quả cho thấy, có 30,9% điều dưỡng chưa biết tính chất dược lý của thuốc, 51,1% không giải thích, hướng dẫn người bệnh cách dùng thuốc phù hợp [35]. Nhưng nghiên cứu chưa xác định các yếu tố liên quan đến những hạn chế của điều dưỡng trong thực hiện nhiệm vụ này.

Trong thực hành các kỹ thuật điều dưỡng, ngoài việc phải tuân thủ quy trình kỹ thuật chuyên môn thì việc tuân thủ quy trình vô khuẩn cũng rất quan trọng đối với nhiệm vụ CSNB của ĐDV, góp phần kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện. Nghiên cứu của Võ Văn Tân (2010), liên quan giữa kiến thức và hành vi của điều dưỡng về kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện. Kết quả phỏng vấn và quan sát trực tiếp 200 điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho thấy việc tuân thủ về quy trình rửa tay thường quy là rất thấp (5%). Đặc biệt, trong tuân thủ quy trình chuyên môn liên quan đến nguyên tắc vô trùng chiếm tỷ lệ rất thấp như: tiêm tĩnh mạch (9,1%) và thông tiểu (10,6%) [39]. Mặc dù, nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên quan giữa kiến thức và hành vi của điều dưỡng trong thực hành rửa tay, nhưng chưa đề cập đến các yếu tố liên quan giữa thực hành rửa tay của điều dưỡng với việc thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn.

Nghiên cứu của Lê Thị Bình (2013), khảo sát kỹ năng thực hành của 450 ĐDV đang trực tiếp làm công tác CSNB tại 9 bệnh viện trong cả nước vào giữa năm 2006 đến 2007 và các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy thực trạng kỹ năng của điều dưỡng còn yếu và có qui luật ở các bệnh viện tuyến trung ương tốt hơn các bệnh viện tuyến tỉnh/thành, việc thực hiện kỹ thuật, thủ thuật theo bảng kiểm chỉ đạt mức trung bình, hầu hết ở các bệnh viện điều dưỡng chỉ thực hiện các kỹ thuật với những bước cơ bản không thể nào thiếu được (ví dụ: tiêm thuốc cho người bệnh chỉ cần rút thuốc vào bơm tiêm sau đó sát khuẩn và tiêm) còn toàn bộ các bước khác kể cả vô khuẩn thì làm ẩu hoặc bỏ để đáp ứng với khối lượng công việc vì sự quá tải người bệnh. Các yếu tố liên quan đến kỹ năng thực hành của điều dưỡng là thâm niên công tác, trình độ chuyên môn, sự đào tạo liên tục và sự hỗ trợ của đồng

nghiệp [1]. Nghiên cứu này thực hiện trên phạm vi rộng và đã nêu lên tương đối đầy đủ thực trạng về những hạn chế trong kỹ năng thực hành CSNB của điều dưỡng tại các bệnh viện tỉnh/thành và tuyến trung ương trong cả nước.

Giữ cho người bệnh được an toàn trong quá trình điều trị và chăm sóc tại bệnh viện cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được quy định đối với ĐDV. Chính vì vậy, Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam đã đặt tiêu chuẩn "Đảm bảo an toàn cho người bệnh" ở Điều đầu tiên trong 8 Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên [31].

Nghiên cứu của Cao Thị Thẩm (2007), đánh giá công tác an toàn trong y tế trước và sau tập huấn chăm sóc toàn diện tại bệnh viện Trung Ương Huế, kết quả khảo sát bằng phiếu thăm dò 400 người bệnh và 400 điều dưỡng cho thấy, điều dưỡng thực hiện an toàn trước và sau tập huấn có sự thay đổi đáng kể: an toàn về chế độ ăn, thuốc từ 91% lên 95,6%, an toàn về thực hiện các quy trình kỹ thuật từ 92% lên 98%, an toàn về quy chế chuyên môn từ 91% lên 98%, an toàn trong vận chuyển người bệnh từ 92% lên 96% [40]. Mặc dù, ĐDV tại bệnh viện đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ này trước đó, nhưng qua đây cũng thể hiện rất rõ sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện đối với công tác CSNB qua việc tổ chức tập huấn và đánh giá lại nhằm đảm bảo chất lượng CSNB của bệnh viện.

Ghi phiếu chăm sóc là quy định của Bộ Y tế, chất lượng ghi chép hồ sơ của điều dưỡng có thể phản ánh tiêu chuẩn chăm sóc tốt hoặc xấu mà chúng ta cung cấp đến người bệnh, sự ghi chép kém có thể dẫn đến những nghi ngờ về chất lượng công tác chăm sóc của người điều dưỡng. Tuy nhiên, với nhiệm vụ này điều dưỡng thường thực hiện chưa tốt.

Kết quả nghiên cứu của Ngô Thị Hoa và cộng sự (2007) qua khảo sát đánh giá thực trạng việc ghi phiếu chăm sóc tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu cắt ngang trên 88 bác sĩ và 89 điều dưỡng đã chỉ ra rằng, nhận xét của bác sĩ về nội dung phiếu chăm sóc do điều dưỡng ghi đầy đủ, chính xác chỉ đạt 59%, còn điều dưỡng tự đánh giá thì đạt tới 78,7%. Việc ghi phiếu chăm sóc không đầy đủ và thiếu chính xác là do thời điểm ghi tập trung vào cuối giờ làm việc (đánh giá của 34,0% bác sĩ và 21,3% điều dưỡng), cách ghi chép dàn trải tốn nhiều thời

gian, mỗi người bệnh được ghi phiếu chăm sóc phải mất trung bình từ 3 - 5 phút (49,4% nhận xét của điều dưỡng) [23]. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xác định các yếu tố liên quan đến việc ghi phiếu chăm sóc của điều dưỡng.

Một nghiên cứu của Trần Văn Minh và cộng sự (2010), mô tả hồi cứu trên 136 HSBA của người bệnh tử vong từ năm 2001 đến năm 2010 để đánh giá công tác điều dưỡng tại bệnh viện Vạn Ninh. Kết quả cho thấy, có 12,5% HSBA ghi thông tin người bệnh chưa chính xác, 25,7% ghi trùng lặp thông tin, 20,6% ghi diễn biến bệnh không thống nhất với bác sĩ và thiếu kiểm tra đối chiếu, 5,1% ghi thực hiện y lệnh chăm sóc không đầy đủ [29]. Còn đối với nhiệm vụ CSNB tử vong thì hầu như chưa được điều dưỡng chú trọng, có đến 58% NNNB không được động viên, an ủi, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ làm các thủ tục cần thiết [29]. Kết quả nghiên cứu này nói lên vai trò nhiệm vụ của điều dưỡng trong công tác CSNB không chỉ thể hiện qua thực hành chăm sóc mà còn thể hiện trên HSBA, một văn bản pháp lý để đánh giá chất lượng chăm sóc của điều dưỡng. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến việc ghi chép HSBA của ĐDV.

Nghiên cứu của Phan Cảnh Chương (2012), báo cáo kết quả đánh giá thực trạng ghi chép biểu mẫu, hồ sơ của ĐDV, HSV tại bệnh viện Trung Ương Huế bằng việc lấy ý kiến 84 NVYT (bác sĩ, điều dưỡng trưởng khoa, ĐDV) và rút kiểm tra ngẫu nhiên 60 HSBA của người bệnh ra viện. Kết quả cho thấy, tỷ lệ phiếu chăm sóc điều dưỡng được ghi đầy đủ thông tin cá nhân, hành chính đạt 57%, ghi đầy đủ các can thiệp chăm sóc điều dưỡng đạt 22%, đảm bảo thông tin chính xác giữa bác sĩ và điều dưỡng đạt 70% [17]. Tuy nhiên nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức độ mô tả, chưa xác định các yếu tố liên quan đến ghi chép HSBA.

Nghiên cứu tương tự của Huỳnh Thị Mỹ Thanh (2012) tại bệnh viện An Giang, hồi cứu ngẫu nhiên 30 HSBA để đánh giá việc ghi chép của ĐDV. Kết quả, có 93,3% phiếu chăm sóc điều dưỡng được ghi đầy đủ thông tin cá nhân, hành chính, đảm bảo thông tin chính xác giữa bác sĩ và điều dưỡng đạt 96,7%, nhưng chỉ có 26,7% phiếu chăm sóc được ghi đầy đủ các can thiệp chăm sóc điều dưỡng [41]. Tuy nhiên nghiên cứu này cũng chỉ dừng lại ở mức độ mô tả, chưa xác định các yếu tố liên quan đến ghi chép HSBA.

Một nghiên cứu khác về thực trạng ghi chép HSBA của ĐDV, HSV tại các bệnh viện năm 2012 của tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Bích Lưu và các cộng sự. Nghiên cứu mô tả thông qua đánh giá nhanh ý kiến NVYT và hồi cứu hồ sơ ghi chép điều dưỡng tại 16 bệnh viện thuộc các tuyến huyện, tỉnh, trung ương đa khoa và chuyên khoa, tại mỗi bệnh viện chọn ngẫu nhiên 30 HSBA ra viện và lấy ý kiến 30 NVYT. Kết quả chỉ ra rằng, có 68,5% phiếu chăm sóc điều dưỡng được ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân, hành chính, 36,7% ghi đầy đủ các can thiệp chăm sóc điều dưỡng, 84,1% phiếu chăm sóc đạt tiêu chí thống nhất thông tin giữa bác sĩ và ĐDV. Bên cạnh đó còn có tình trạng chữ viết xấu, viết nội dung không rõ ràng, không cô đọng, một số thông tin trùng lặp [38]. Nghiên cứu này được thực hiện với quy mô rộng hơn các nghiên cứu trên và đã đưa ra các thông tin quan trọng để các nhà quản lý quan tâm hơn nữa đến công tác ghi chép HSBA của điều dưỡng.

Các yếu tố liên quan đến hoạt động CSNB có thể nói đến là độ tuổi của ĐDV, giới tính và thâm niên công tác. Ngoài ra còn có yếu tố về số nhân lực điều dưỡng tham gia trực tiếp CSNB, số người bệnh do ĐDV trực tiếp chăm sóc và thời gian ĐDV trực tiếp CSNB.

Nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn (2011) tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, đã phát hiện rằng, Độ tuổi và thâm niên công tác của ĐDV có liên quan đến nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh (OR = 6,71, 95% CI: 1,49 - 30,25 và OR = 4,02, 95% CI: 1,29 - 12,2, $p < 0,05$), giới tính có liên quan đến nhiệm vụ chăm sóc vệ sinh cá nhân (OR = 0,13, 95% CI: 0,02 - 1,11, $p < 0,05$). Tuy nhiên, các mối liên quan này có khoảng tin cậy 95% rộng, có thể do cỡ mẫu chưa đủ lớn.

Nghiên cứu của Nguyễn Bích Lưu (2011), khảo sát tổ chức chăm sóc và nhân lực điều dưỡng trong một ngày làm việc từ 30 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, đã phát hiện rằng, trung bình 1 điều dưỡng phải trực tiếp chăm sóc từ 6 - 7 người bệnh ban ngày và tăng lên rất cao về đêm từ 23 - 24 người bệnh, gần gấp 4 lần so với ban ngày. Nhân lực điều dưỡng làm đêm chỉ chiếm 17% so với tổng số nhân lực điều dưỡng và 21% so với nhân lực điều dưỡng làm ngày, vì vậy số người bệnh mà điều dưỡng phải chăm sóc về đêm rất cao. Điều này dẫn đến tình trạng có nhiều nhu cầu

cần chăm sóc điều dưỡng sẽ không được đáp ứng cho người bệnh [27]. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa phân tích mối liên quan giữa số nhân lực điều dưỡng trực tiếp CSNB với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB.

Nghiên cứu của Bùi Ngọc Tuyền (2011), khảo sát thời gian chăm sóc trung bình người bệnh chăm sóc cấp 1 tại khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả cho thấy, thời gian chăm sóc trung bình của người bệnh chăm sóc cấp 1 trong 24 giờ là 7,5 giờ, trong đó thời gian chăm sóc trực tiếp là 5,5 giờ và thời gian chăm sóc gián tiếp là 2 giờ [49]. Tuy nhiên, nghiên cứu thực hiện trên phạm vi nhỏ tại một khoa lâm sàng nên tính đại diện chưa cao, và nghiên cứu cũng chưa xác định mối liên quan giữa thời gian chăm sóc trung bình với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV.

1.4. Thông tin chung về bệnh viện và công tác CSNB tại BVNĐC tỉnh Bến Tre

1.4.1. Giới thiệu chung về bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng 2, với quy mô 1000 giường bệnh (năm 2013), giường bệnh thực kê là 1094, công suất sử dụng giường bệnh là 90.91%. Là tuyến điều trị cao nhất, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Bệnh viện với đội ngũ 969 cán bộ viên chức, cơ cấu tổ chức gồm Ban giám đốc, 06 phòng chức năng, 18 khoa lâm sàng và 09 khoa cận lâm sàng. Bệnh viện đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, trang thiết bị y tế khá đầy đủ và hiện đại. Trong những năm qua bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám chữa bệnh, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng phục vụ.

1.4.2. Công tác chăm sóc người bệnh tại bệnh viện Nguyễn Đình chiểu

BVNĐC có 18 khoa lâm sàng, trong đó có 17 khoa lâm sàng có giường bệnh. Tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh trên bác sĩ tại 17 khoa lâm sàng 455/139 = 3,27. Số ĐDV, HSV/giường bệnh thực kê = 1/2,40. Thuận tiện cho việc triển khai CSNBTD. Bệnh viện đã thực hiện CSNBTD từ năm 2003, với 02 dạng mô hình phân công chăm sóc. Mô hình thứ nhất là mô hình chăm sóc toàn diện (mô hình phân công điều dưỡng chăm sóc chính): gồm 12/17 khoa: HSCC-CĐ, Nội A; Nội Tổng hợp; Nội thần kinh - nội tiết; Tim mạch; ĐTTYC; Ngoại tổng quát; NTK-CTCH-PHCN;

Truyền nhiễm; Y học cổ truyền; Mắt và Răng Hàm Mặt [15]. Mô hình thứ hai là mô hình chăm sóc theo nhóm: gồm 05/17 khoa: Cấp cứu, Khoa PT-GMHS; Tai Mũi Họng; khoa Sản và khoa Nhi [15].

Ngày 26/01/2011, Thông tư số 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện của Bộ Y tế được ban hành. Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện và Ban kiểm tra công tác CSNB được thành lập, đánh giá lại công tác điều dưỡng theo nội dung của Thông tư trước khi thực hiện. Kết quả cho thấy, sự quá tải người bệnh cục bộ tại một số khoa lâm sàng dẫn đến công tác GDSK cho người bệnh chưa được chú trọng; việc ghi chép HSBA còn thiếu sót; người bệnh chăm sóc cấp I chưa được điều dưỡng trực tiếp chăm sóc như: xoay trở phục hồi chức năng, vệ sinh cá nhân; công khai thuốc tại giường bệnh chỉ có một số khoa thực hiện nhưng chưa thường xuyên. Bệnh viện chưa có tiêu chí đánh giá chất lượng chăm sóc điều dưỡng vì vậy công tác đánh giá còn mang tính chung, thiếu chứng cứ [13].

Từ kết quả đánh giá trên, phòng Điều dưỡng đã tổ chức tập huấn lại cho ĐDV, HSV trong toàn bệnh viện về nội dung của Thông tư, đặc biệt nhấn mạnh về 12 nhiệm vụ chuyên môn CSNB, tổ chức tập huấn lại các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng, phổ biến các quy định về GDSK cho người bệnh và vận chuyển người bệnh an toàn. Tổ chức kiểm tra giám sát chéo giữa các khoa lâm sàng về công tác CSNB và báo cáo về Ban Giám đốc hàng tháng. Tuy nhiên, việc kiểm tra đánh giá vẫn còn mang tính chung chung, chưa xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng để có số liệu cụ thể, làm cơ sở củng cố các hoạt động CSNB của ĐDV, HSV. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu *"Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre, năm 2014"*. Nhằm cung cấp số liệu, từ đó khuyến nghị các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng CSNB tại bệnh viện.

Chương 2
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

– ĐDV trực tiếp làm công tác CSNB tại 10 khoa lâm sàng có tính chất công việc gần tương đồng nhau và có mặt tại BVNĐC vào thời gian nghiên cứu.

– Hồ sơ bệnh án (HSBA) của người bệnh đang nằm điều trị nội trú được chăm sóc trực tiếp bởi ĐDV có tham gia vào đối tượng nghiên cứu.

– Các báo cáo thống kê về nhân lực điều dưỡng, lịch phân công công việc điều dưỡng hàng ngày của điều dưỡng trưởng 10 khoa lâm sàng có ĐDV tham gia vào nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ:

– Các ĐDV không trực tiếp làm công tác CSNB.

– Các ĐDV trực tiếp CSNB làm việc tại các khoa lâm sàng có tính chất công việc điều dưỡng đặc thù của chuyên khoa như: Sản, khối chuyên khoa lẻ, khoa Điều trị theo yêu cầu và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

– Các ĐDV không có mặt tại bệnh viện trong thời gian nghiên cứu.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.2.1. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2013 đến tháng 7/2014.

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu

Tại 10 khoa lâm sàng có tính chất công việc của ĐDV gần tương đồng nhau như: Cấp cứu; Hồi sức tích cực và Chống độc; Nội A, Nội tổng hợp; Nội thần kinh - Nội tiết, Tim mạch, Ngoại tổng quát, Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Nhi, Nhiễm.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Áp dụng thiết kế mô tả cắt ngang có phân tích.

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Số liệu sơ cấp:

– *Đối tượng là ĐDV*: Chọn toàn bộ ĐDV trực tiếp làm công tác CSNB, tại 10 khoa lâm sàng nêu trên và không thuộc các tiêu chuẩn loại trừ được mời vào nghiên cứu. Có tất cả 213 ĐDV đã đồng ý tham gia nghiên cứu:

Bảng 2.1. Số ĐDV đồng ý tham gia vào nghiên cứu tại 10 khoa lâm sàng

STT	Khoa	Số ĐDV được chọn vào nghiên cứu
1	Nhi	44
2	Cấp cứu	32
3	Ngoại tổng quát	26
4	Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng (NTK-CTCH và PHCN)	23
5	Hồi sức tích cực và chống độc (HSTC-CĐ)	21
6	Nội Tổng hợp	18
7	Nội A	15
8	Tim mạch	14
9	Nội Thần kinh-Nội tiết	12
10	Nhiễm	8
	Tổng cộng	**213**

– *Đối tượng là HSBA*: Từ số HSBA của người bệnh đang nằm điều trị nội trú do mỗi ĐDV có tham gia nghiên cứu trực tiếp phụ trách trong thời điểm thu thập số liệu, chọn ra ngẫu nhiên 3 HSBA. Có 639 HSBA được chọn nghiên cứu.

Số liệu thứ cấp:

– Danh sách điều dưỡng viên trực tiếp CSNB tại 10 khoa lâm sàng nêu trên.

– Bảng phân công công việc điều dưỡng hàng ngày và bảng phân công trực của điều dưỡng trưởng khoa.

2.5. Phương pháp thu thập số liệu:

– Sử dụng 2 phương pháp thu thập số liệu để đánh giá việc thực hiện 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV và một số yếu tố liên quan, gồm: quan sát và phát vấn.

+ ***Phương pháp quan sát*** được thực hiện với mục đích đánh giá việc thực hiện 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV, gồm: quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp.

+ ***Phương pháp phát vấn*** được thực hiện với mục đích mô tả một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV.

a. Quan sát trực tiếp ĐDV khi đang thực hiện các nhiệm vụ CSNB:

– Sử dụng bảng kiểm được thiết kế dựa vào 12 nhiệm vụ CSNB được quy định

tại Thông tư 07/2011/TT-BYT, chọn ra 8 nhiệm vụ để quan sát trực tiếp (chi tiết được trình bày ở phụ lục 3). Bảng kiểm được quan sát thử nghiệm 10 ĐDV và chỉnh sửa trước khi tiến hành quan sát chính thức, mỗi bảng kiểm sử dụng cho quan sát một ĐDV.

– Quan sát viên (QSV) gồm nghiên cứu viên, 05 cán bộ của phòng Điều dưỡng và 01 điều dưỡng trưởng khoa đã có kinh nghiệm quan sát trong các cuộc kiểm tra hàng ngày về công tác CSNB tại các khoa lâm sàng. Các QSV được tập huấn kỹ về nội dung của bộ công cụ, thống nhất cách quan sát và cách đánh giá mức độ đạt dựa theo bảng hướng dẫn tiêu chí đánh giá được thiết kế sẵn (chi tiết được trình bày ở phụ lục 4) và một số bảng kiểm quy trình kỹ thuật điều dưỡng hiện đang được áp dụng tại bệnh viện [36].

– Các cuộc quan sát được tiến hành công khai và ngẫu nhiên vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, tại các thời điểm diễn ra hoạt động CSNB nhiều nhất trong khoảng thời gian: sáng từ 7giờ30 đến 11giờ, chiều từ 13giờ30 đến 16giờ. Ngoài ra, để quan sát các hoạt động vệ sinh cá nhân cho người bệnh thì QSV tiến hành quan sát vào khoảng thời gian từ 4giờ30 đến 6giờ30 sáng.

– Mỗi hoạt động chăm sóc của ĐDV tương ứng với mỗi tiểu mục trên bảng kiểm được tính 01 lần thực hiện. Mỗi tiểu mục được đánh giá 03 lần tương ứng với 03 lần thực hiện. QSV dựa vào bảng hướng dẫn tiêu chí đánh giá và các bảng kiểm kỹ thuật điều dưỡng để chọn mức độ hoàn thành tương ứng với hoạt động chăm sóc của ĐDV. Nếu hết buổi quan sát, QSV vẫn chưa đánh dấu đủ 03 lần đối với mỗi tiểu mục, QSV trở lại buổi sau để quan sát tiếp, đến khi nào tất cả các tiểu mục trên bảng kiểm được đánh dấu đủ 03 lần thì mới dừng cuộc quan sát đối với ĐDV đó. Đối với tiểu mục nào không thể đánh giá được do ĐDV phụ trách CSNB không có nhu cầu để thực hiện tương ứng với tiểu mục đó, thì QSV bỏ qua tiểu mục đó.

– Nghiên cứu viên là giám sát viên, đồng thời là người kiểm tra thông tin ngay khi nhận phiếu quan sát từ các QSV vừa quan sát xong và bổ sung thông tin khi cần.

b. Quan sát gián tiếp việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV qua HSBA

– Sử dụng bảng kiểm được thiết kế với 4 nhiệm vụ còn lại trong 12 nhiệm vụ được quy định tại Thông tư 07/2011/TT-BYT không thể đánh giá qua quan sát trực

tiếp (chi tiết được trình bày ở phụ lục 5), tiến hành quan sát gián tiếp trên HSBA của người bệnh do 213 ĐDV tham gia vào nghiên cứu trực tiếp phụ trách tại thời điểm thu thập số liệu. Bảng kiểm được thực hiện thử nghiệm 10 HSBA và chỉnh sửa trước khi thực hiện chính thức. Mỗi bảng kiểm sử dụng cho 03 HSBA của một ĐDV trực tiếp phụ trách.

– Điều tra viên là nghiên cứu viên (NCV) để đảm bảo tính thống nhất khi đánh giá về việc thực hiện các nhiệm vụ CSNB của ĐDV qua HSBA.

– NCV tiến hành điều tra công khai và ngẫu nhiên không theo tuần tự các khoa, vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 10 giờ đến 11giờ, chiều từ 15giờ đến 17giờ. Rút ngẫu nhiên 03 HSBA trong số HSBA do mỗi ĐDV trực tiếp phụ trách, dựa vào bảng hướng dẫn tiêu chí đánh giá được thiết kế sẵn để đánh giá các nhiệm vụ CSNB của ĐDV tương ứng với các tiểu mục trên bảng kiểm (chi tiết được trình bày ở phụ lục 6). 03 HSBA tương ứng với đánh dấu 03 lần đối với mỗi tiểu mục. Tiểu mục nào không thể đánh giá do không có thông tin trên HSBA (vì người bệnh không có nhu cầu để ĐDV thực hiện đối với tiểu mục đó) thì không đánh giá tiểu mục đó.

c. Phát vấn cho ĐDV để tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB.

– Sử dụng bộ câu hỏi được xây dựng dựa vào tham khảo từ các tác giả Phạm Anh Tuấn (2011), Dương Thị Bình Minh (2012). Bộ câu hỏi gồm có 5 phần: thông tin cá nhân; các yếu tố tổ chức CSNB; yếu tố điều kiện làm việc; sự quan tâm của lãnh đạo đến công tác điều dưỡng và các chế độ, chính sách điều dưỡng. Bộ câu hỏi được điều tra thử 30 ĐDV và điều chỉnh phù hợp trước khi điều tra chính thức.

– ĐTV là 02 cán bộ của phòng Điều dưỡng đã được phổ biến rõ về nội dung nghiên cứu và thống nhất cách điều tra. Mỗi ĐTV phụ trách 05 khoa để phát phiếu hỏi cho ĐDV (danh sách ĐDV được chọn để phát vấn là danh sách các ĐDV được chọn để quan sát ở phần trên). ĐTV giải thích rõ nội dung nghiên cứu và phát phiếu hỏi cho từng ĐDV tự điền. Sau 01 tuần thu lại phiếu hỏi, ĐTV kiểm tra về sự phù hợp của các câu trả lời và đề nghị điều chỉnh ngay khi cần.

– Nghiên cứu viên làm sạch số liệu ngay khi nhận phiếu điều tra từ ĐTV.

d. Số liệu thứ cấp: Lập bảng sẵn để tổng hợp các thông tin về số nhân lực ĐDV trực tiếp CSNB và bảng phân công nhân lực điều dưỡng tại các vị trí CSNB của 10 khoa lâm sàng. Các thông tin này do nghiên cứu viên trực tiếp thu thập.

2.6. Các biến số nghiên cứu

Các biến số trong nghiên cứu này được xây dựng dựa trên 12 nhiệm vụ chuyên môn CSNB tại Thông tư 07/2011/TT-BYT của Bộ y tế, Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam và Bộ tiêu chuẩn chất lượng CSNB của Hội Điều dưỡng Việt Nam [9], [10], [30]. Các biến số về yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của điều dưỡng được tham khảo từ các tác giả: Phạm Anh Tuấn (2011) - Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí; Dương Thị Bình Minh (2012) - Bệnh viện Hữu Nghị [28], [48].

Các nhóm biến số gồm:

- Các biến số thông tin chung của đối tượng nghiên cứu, gồm 05 biến: từ 1 - 5.
- Các biến số về việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV, gồm 12 nhiệm vụ với 46 tiểu mục tương ứng 46 biến: từ A1 đến M3.
- Các biến số về yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV gồm 4 nhóm với 15 biến: từ N1 đến Q3. (Chi tiết các biến số được trình bày ở phụ lục 2)

2.7. Một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu và tiêu chí đánh giá

2.7.1. Một số khái niệm

Phân cấp chăm sóc người bệnh

- *Người bệnh cần chăm sóc cấp 1* là người bệnh nặng, nguy kịch, hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn, phải nằm bất động và yêu cầu có sự theo dõi, chăm sóc toàn diện và liên tục của ĐDV [9].
- *Người bệnh cần chăm sóc cấp 2* là người bệnh có những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày, cần sự theo dõi, hỗ trợ của ĐDV [9].
- *Người bệnh cần chăm sóc cấp 3* là người bệnh tự thực hiện được các hoạt động hàng ngày và cần sự hướng dẫn chăm sóc của ĐDV [9].

Phiếu chăm sóc : là phiếu ghi diễn biến bệnh của người b ệnh và những can thiệp điều dưỡng do ĐDV, HSV thực hiện [9].

Mô hình phân công chăm sóc:

– *Mô hình phân công điều dưỡng chăm sóc chính*: Một ĐDV hoặc một HSV chịu trách nhiệm chính trong việc nhận định, lập kế hoạch chăm sóc, tổ chức thực hiện có sự trợ giúp của các ĐDV hoặc HSV khác và theo dõi đánh giá cho một số người bệnh trong quá trình nằm viện [9].

– *Mô hình chăm sóc theo nhóm:* Nhóm có từ 2-3 ĐDV hoặc HSV chịu trách nhiệm chăm sóc một số người bệnh ở một đơn nguyên hay một số buồng bệnh [9].

Môi trường làm việc: Là môi trường trong đó điều dưỡng chăm sóc cho người bệnh có thể xác định được chất lượng và sự an toàn cho CSNB [57], [58].

An toàn người bệnh: Đã được xác định bởi Viện Y học (IOM) là "công tác phòng chống tác hại cho người bệnh" [58]. Được đặt trên các hệ thống phân công chăm sóc: (1) phòng ngừa lỗi, (2) rút kinh nghiệm từ các lỗi đã làm xảy ra, và (3) được xây dựng nền văn hóa về an toàn có liên quan đến các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tổ chức và người bệnh [54], [58], [59].

2.7.2. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa vào các tiêu chí đánh giá thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện của Cục Quản lý khám, chữa bệnh; tham khảo từ Hướng dẫn đánh giá chất lượng CSNB trong các bệnh viện của Hội điều dưỡng Việt Nam và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế [12], [18], [24].

Các mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV được đánh giá qua quan sát trực tiếp khi ĐDV thực hiện CSNB và quan sát gián tiếp qua HSBA với 5 mức độ (bảng hướng dẫn đánh giá chi tiết được trình bày ở phụ lục 4 và phụ lục 6):

+ **Mức 1** (M1) = 0 điểm: có người bệnh nhưng không thực hiện chăm sóc.
+ **Mức 2** (M2) = 1 điểm: thực hiện một phần.
+ **Mức 3** (M3) = 2 điểm: thực hiện chưa đầy đủ.
+ **Mức 4** (M4) = 3 điểm: thực hiện đầy đủ.
+ **Mức 5** (M5) = 4 điểm: thực hiện đầy đủ và rất tốt.

– Có 12 nhiệm vụ CSNB với 46 tiểu mục, mỗi tiểu mục được đánh giá 03 lần. Mức độ hoàn thành của mỗi tiểu mục chính là điểm trung bình của 03 lần đánh giá.

Trung bình tổng điểm của các tiểu mục dùng làm ngưỡng cắt để đánh giá mức độ hoàn thành của mỗi nhiệm vụ và mức độ hoàn thành chung của 12 nhiệm vụ (nếu có tiểu mục nào không được đánh giá do ĐDV trực tiếp phụ trách CSNB không có nhu cầu để thực hiện đối với tiểu mục đó thì không tính điểm tiểu mục đó). Mức độ hoàn thành được phân thành 02 nhóm: **"Chưa hoàn thành":** khi điểm trung bình < 2,6 điểm; **"Hoàn thành"**: khi điểm trung bình ≥ 2,6 điểm.

2.7.3. Về các yếu tố liên quan:

Sử dụng thang điểm Likert từ 1 – 5 để xây dựng bộ câu hỏi phát vấn, gồm:

+ 1: Rất không phù hợp/Rất không tốt/Rất không quan tâm
+ 2: Không phù hợp/Không tốt/Không quan tâm
+ 3: Bình thường
+ 4: Phù hợp/Tốt/Quan tâm
+ 5: Rất phù hợp/Rất tốt/Rất quan tâm

Thang điểm 5 được mã hóa thành hai nhóm:

+ Nhóm 1: Chưa phù hợp/Chưa tốt/Chưa quan tâm với điểm từ $1 \rightarrow 3$
+ Nhóm 2: Phù hợp/Tốt/Quan tâm với điểm từ $4 \rightarrow 5$.

2.8. Phương pháp phân tích số liệu

Số liệu sau khi thu thập được làm sạch, nhập vào máy tính bằng phần mềm Epi Data 3.1. Để kiểm tra độ chính xác, việc nhập số liệu được tiến hành 02 lần với 02 bảng số liệu khác nhau rồi đối chiếu sự trùng khớp của số liệu. Sử dụng phần mềm SPSS 18.0 để phân tích số liệu.

– Phần mô tả: Thể hiện tần số, tỷ lệ % và giá trị trung bình của các biến trong nghiên cứu.

– Phần phân tích: Sử dụng các test thống kê kiểm định Khi bình phương và kiểm định t để mô tả các yếu tố liên quan đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

2.9. Đạo đức trong nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu được giải thích về mục đích của nghiên cứu và đồng ý tham gia. Mọi thông tin cá nhân về đối tượng nghiên cứu được giữ kín, các số liệu, thông tin thu thập được chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

– Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức Trường Đại học Y tế Công cộng cho

phép thực hiện theo Giấy chấp thuận Số: 067/2014/YTCC-HD3, ngày 11 tháng 3 năm 2014 về việc chấp thuận các vấn đề đạo đức nghiên cứu y sinh học.

– Nội dung nghiên cứu phù hợp, được Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học kỹ thuật và lãnh đạo các khoa tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đồng ý và ủng hộ.

2.10. Hạn chế của nghiên cứu và hướng khắc phục

2.10.1. Hạn chế

– Việc quan sát trực tiếp và công khai khi ĐDV thực hiện các công việc CSNB có thể gây cho ĐDV sự mất tự nhiên và làm không theo thói quen hàng ngày, có thể dẫn đến việc đánh giá thiếu chính xác.

– Nghiên cứu được thực hiện tại 10 khoa lâm sàng với các nhóm chuyên khoa khác nhau và ĐDV được phân công CSNB tại các vị trí cũng khác nhau (buồng bệnh thường, buồng bệnh nặng/đơn nguyên hồi sức tích cực), nên việc thực hiện các nhiệm vụ CSNB cũng có tính chất khác nhau. Vì vậy, có thể gặp sai số trong đánh giá chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của các ĐDV.

– Số lượng người bệnh do ĐDV được phân công trực tiếp chăm sóc khác nhau. Vì vậy, khó so sánh về mức độ hoàn thành nhiệm vụ giữa các ĐDV với nhau.

– QSV phải quan sát cùng lúc quá nhiều tiểu mục, nên có thể chủ quan trong đánh giá mức độ đạt của các tiểu mục, hoặc giữa các QSV có sự đánh giá khác nhau về mức độ đạt, dễ xảy ra sai số.

– Việc phát vấn ĐDV để tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến thực hiện CSNB, có thể xảy ra sai số do ĐDV tự điền, có khả năng do tình cảm riêng hoặc đọc không kỹ nội dung câu hỏi nên đánh dấu chủ quan hoặc theo quán tính.

2.10.2. Khắc phục

– QSV tiến hành quan sát một cách ngẫu nhiên không theo lịch trình báo trước, cũng không quan sát tuần tự hết khoa này mới chuyển sang khoa khác, quan sát diễn ra trong suốt thời gian 02 tháng thu thập số liệu, nên không làm mất sự tự nhiên và thói quen làm việc của ĐDV.

– Đối với từng chuyên khoa/khu vực chăm sóc, để có sự chính xác trong đánh giá chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV, các tiểu mục nào ĐDV

không thể thực hiện được do phụ trách CSNB không có nhu cầu để thực hiện, thì không đưa tiểu mục đó vào đánh giá chung.

– Để chính xác khi so sánh về mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB giữa các ĐDV với nhau, cần thực hiện so sánh giữa các ĐDV trong cùng nhóm chuyên khoa.

– Để thống nhất cách quan sát và cách lựa chọn "Mức độ đạt" giữa các QSV, nghiên cứu viên phát bảng hướng dẫn tiêu chí đánh giá các "Mức độ đạt" cho QSV đọc kỹ trước khi tập huấn để thảo luận thống nhất nội dung và tiến hành quan sát thử nghiệm.

– ĐTV phát phiếu hỏi cho từng đối tượng nghiên cứu, giải thích rõ mục đích của cuộc điều tra và nội dung bộ câu hỏi. Đồng thời hướng dẫn kỹ ĐDV cách tự đánh giá và tránh sự rập khuôn trong khi đánh giá.

Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1.Thực trạng về việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV tại BVNĐC

3.1.1. Thông tin chung về ĐDV tham gia nghiên cứu

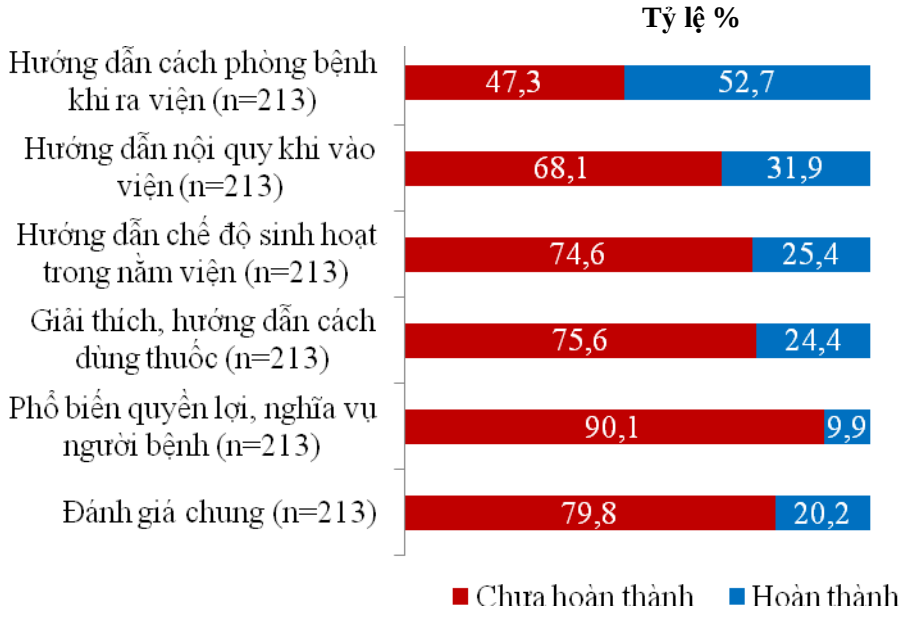
Bảng 3.1. Thông tin chung về ĐDV tham gia nghiên cứu

Đặc điểm		Tần số	Tỷ lệ %
Nhóm chuyên khoa	Cấp cứu	32	15,0
	Hồi sức tích cực	21	9,9
	Nội	59	27,7
	Ngoại	49	23,0
	Nhi	44	20,7
	Nhiễm	8	3,7
	Tổng số	**213**	**100**
Tuổi	< 30	134	62,9
	≥ 30	79	37,1
	Tổng số	**213**	**100**
Giới	Nam	47	22,1
	Nữ	166	77,9
	Tổng số	**213**	**100**
Trình độ chuyên môn	Trung cấp	194	91,1
	Cao đẳng trở lên	19	8,9
	Tổng số	**213**	**100**
Thâm niên công tác	< 10 năm	158	74,2
	≥ 10 năm	55	25,8
	Tổng số	**213**	**100**
Vị trí được phân công CSNB	Buồng bệnh thường	105	49,3
	Buồng bệnh nặng/HSTC	108	50,7
	Tổng số	**213**	**100**
Mô hình chăm sóc	Điều dưỡng chăm sóc chính (CSTD)	138	64,8
	Chăm sóc nhóm	75	35,2
	Tổng số	**213**	**100**

ĐDV tham gia nghiên cứu đa số là nhân lực trẻ dưới 30 tuổi (62,9%); phần lớn là nữ (77,9%); trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên chiếm một phần rất nhỏ trong đội ngũ ĐDV trực tiếp CSNB (8,9%); thâm niên công tác dưới 10 năm chiếm tỷ lệ cao (74,2%). Đa số ĐDV làm việc trong mô hình phân công điều dưỡng chăm sóc chính (64,8%).

3.1.2. Mức độ hoàn thành đối với từng nhiệm vụ CSNB của ĐDV

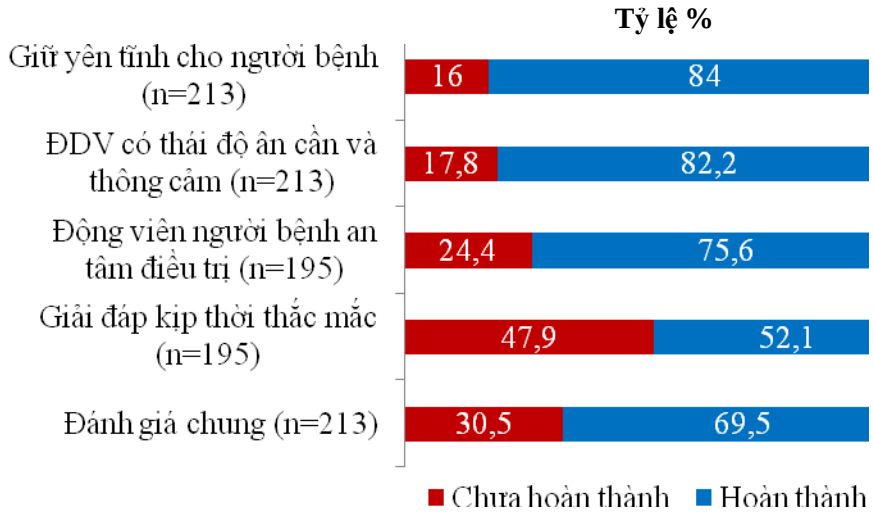
3.1.2.1. Tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh



Biểu đồ 3.1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tư vấn GDSK

Tỷ lệ ĐDV hoàn thành nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh đạt rất thấp (20,2%). Trong đó, chiếm tỷ lệ thấp nhất là hoạt động phổ biến cho người bệnh hoặc NNNB về quyền lợi và nghĩa vụ khi nằm viện (9,9%).

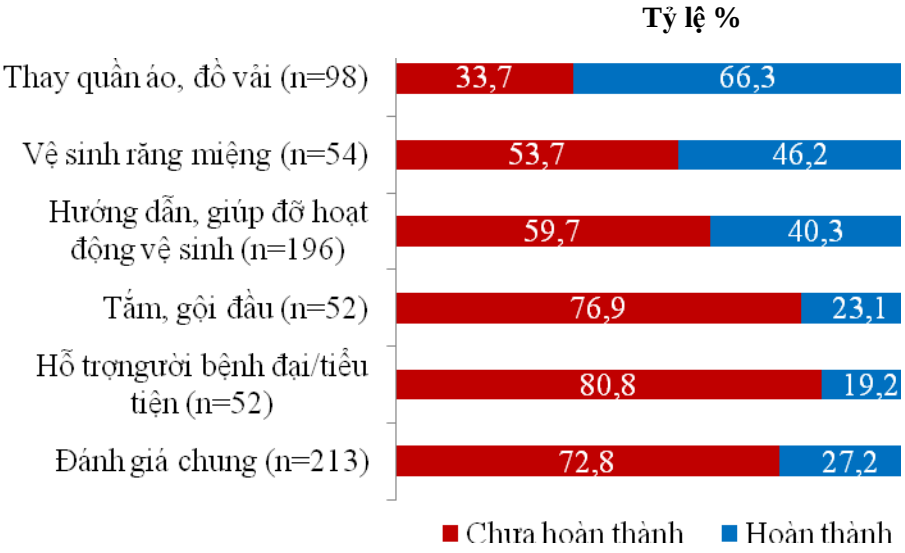
3.1.2.2. Chăm sóc về tinh thần



Biểu đồ 3.2. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc về tinh thần

Đánh giá chung nhiệm vụ CSNB về tinh thần, ĐDV thực hiện hoàn thành chiếm tỷ lệ chưa cao (69,5%). Trong đó, chiếm thấp nhất là hoạt động giải đáp kịp thời những thắc mắc của người bệnh hoặc NNNB trong quá trình điều trị (52,1%), tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với các hoạt động khác trong nhiệm vụ này.

3.1.2.3. Chăm sóc vệ sinh cá nhân

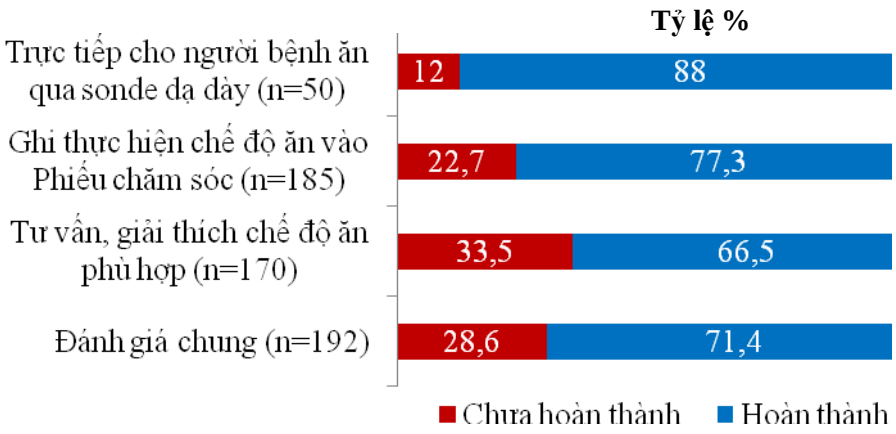


Biểu đồ 3.3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc vệ sinh cá nhân

Biểu đồ 3.3 cho thấy, ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh chiếm tỷ lệ rất thấp (27,2%). Phần lớn các hoạt động vệ sinh

cá nhân cho người bệnh chăm sóc cấp 1 ĐDV hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm tỷ lệ từ 46,2% trở xuống.

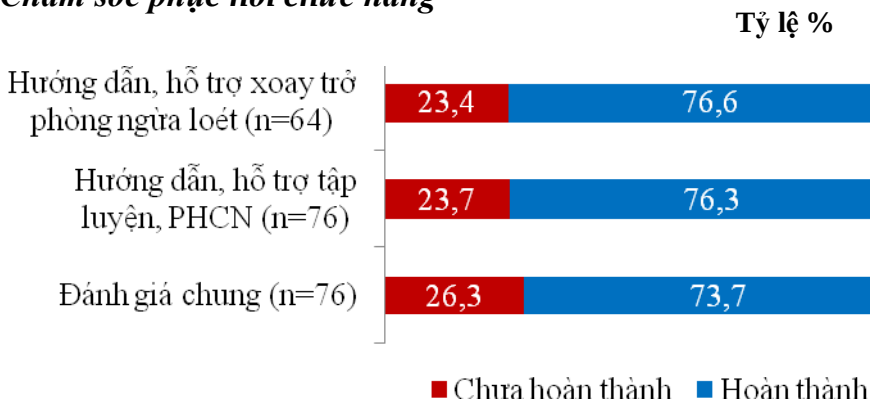
3.1.2.4. Chăm sóc về dinh dưỡng



Biểu đồ 3.4. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc về dinh dưỡng

Đánh giá chung trên 192 ĐDV có thực hiện các hoạt động trong nhiệm vụ chăm sóc về dinh dưỡng cho người bệnh, kết quả cho thấy mức độ hoàn thành chung chiếm tỷ lệ chưa cao (71,4%). Trong đó, còn đến 12% ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp thực hiện cho người bệnh ăn qua sonde dạ dày.

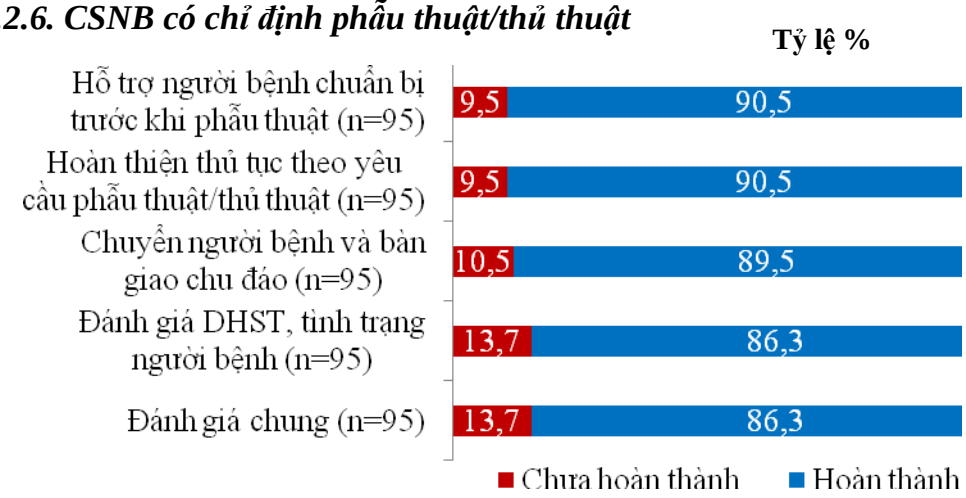
3.1.2.5. Chăm sóc phục hồi chức năng



Biểu đồ 3.5. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc phục hồi chức năng

Kết quả biểu đồ 3.5 cho thấy, tỷ lệ ĐDV thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh đạt khá cao (73,7%).

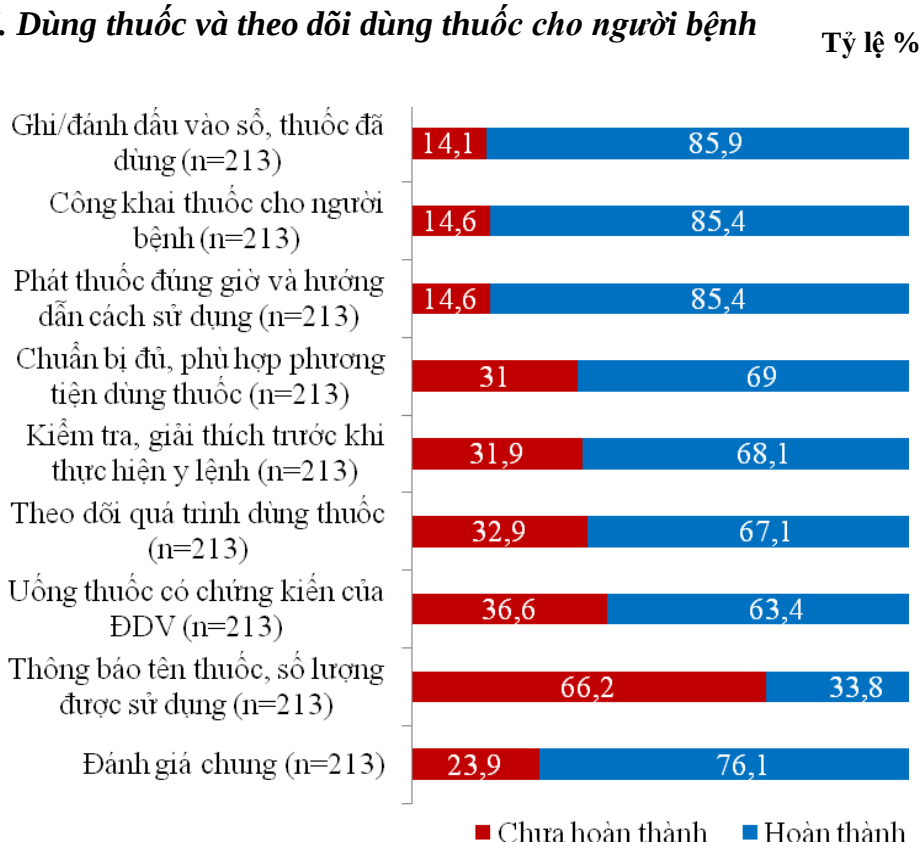
3.1.2.6. CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật



Biểu đồ 3.6. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB có phẫu thuật/thủ thuật

Đánh giá chung về việc hoàn thành nhiệm vụ CSNB có phẫu thuật/thủ thuật, ĐDV thực hiện chiếm tỷ lệ cao (86,3%). Tuy nhiên, còn đến 13,7% ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ đánh giá DHST, tình trạng bệnh trước khi đưa người bệnh đến nơi thực hiện phẫu thuật/thủ thuật.

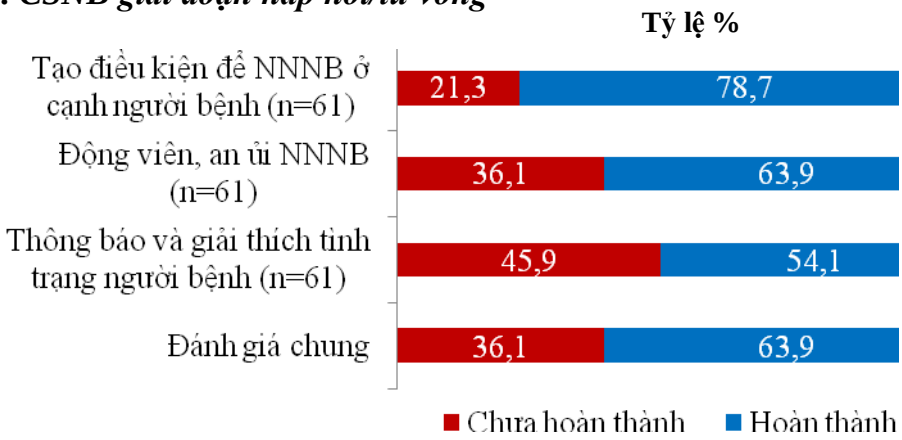
3.1.2.7. Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh



Biểu đồ 3.7. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc

Biểu đồ 3.7 cho thấy, tỷ lệ ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ dùng thuốc và theo dõi người bệnh chiếm 76,1%. Nhưng, vẫn còn đến 66,2% ĐDV thực hiện chưa hoàn thành đối với hoạt động thông báo cho người bệnh về tên thuốc, số lượng thuốc dùng và tác dụng của thuốc.

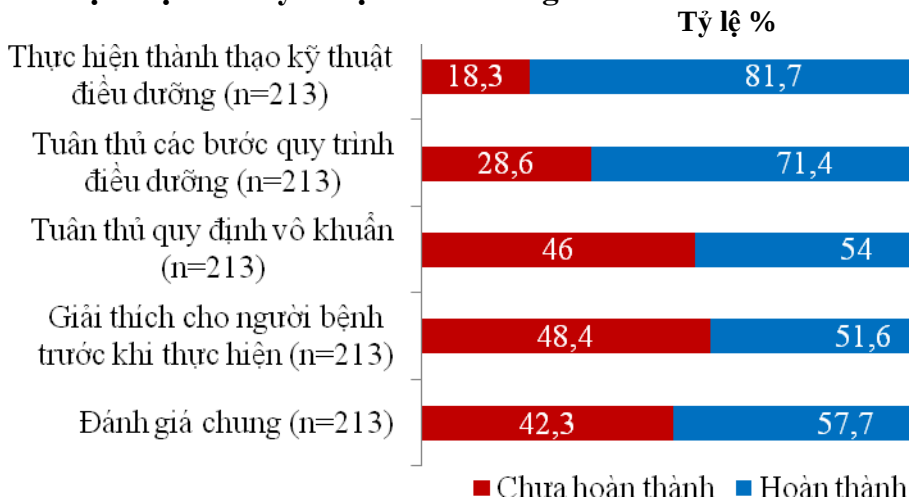
3.1.2.8. CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong



Biểu đồ 3.8. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong

Tỷ lệ ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong là 63,9%. Trong đó, còn đến 45,9% ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ thông báo và giải thích với NNNB về tình trạng của người bệnh.

3.1.2.9. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng

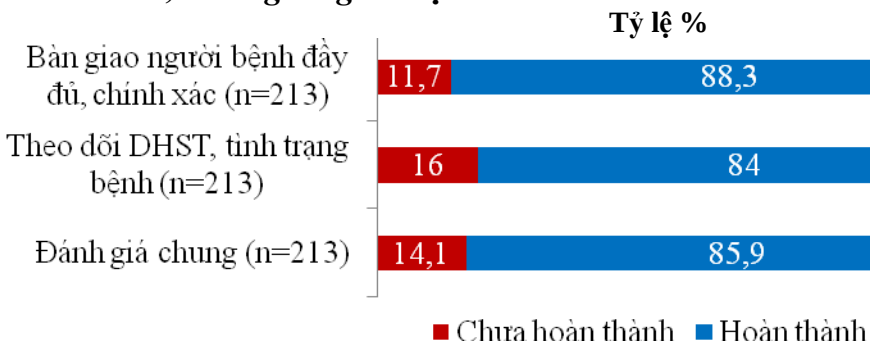


Biểu đồ 3.9. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng

Tỷ lệ ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chỉ ở mức 57,7%. Trong đó, hoạt động giải thích cho người bệnh trước khi thực hiện các can thiệp điều dưỡng và tuân thủ quy định vô khuẩn thì ĐDV chưa hoàn

thành nhiệm vụ còn chiếm tỷ lệ khá cao (46% và 48,4%).

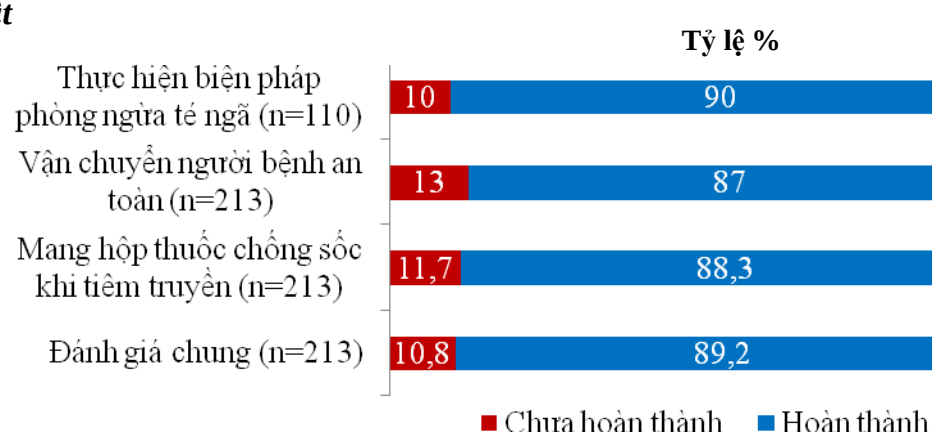
3.1.2.10. Theo dõi, đánh giá người bệnh



Biểu đồ 3.10. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo dõi, đánh giá người bệnh

ĐDV hoàn thành nhiệm vụ theo dõi, đánh giá người bệnh chiếm tỷ lệ khá cao 85,9%. Các hoạt động trong nhiệm vụ này ĐDV thực hiện đều đạt tỷ lệ cao từ 84% trở lên.

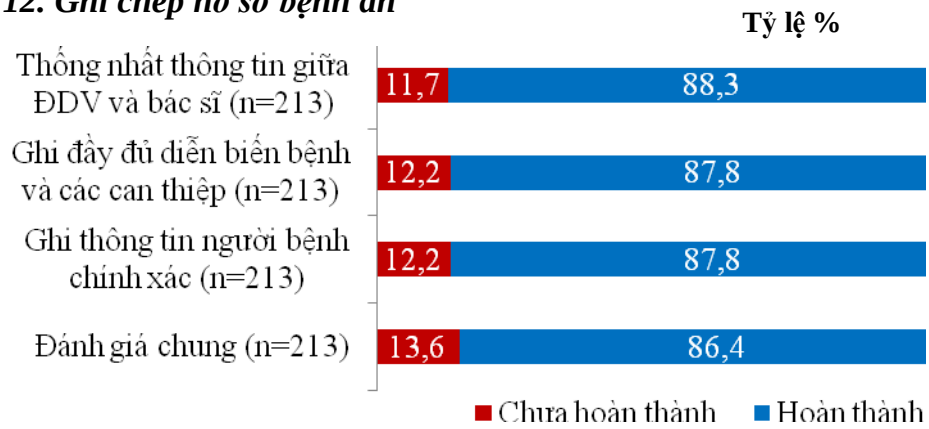
3.1.2.11. Bảo đảm người bệnh an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật



Biểu đồ 3.11. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm người bệnh an toàn

Việc thực hiện các hoạt động bảo đảm người bệnh an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật, ĐDV hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao (89,2%).

3.1.2.12. Ghi chép hồ sơ bệnh án



Biểu đồ 3.12. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ ghi chép hồ sơ bệnh án

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ ghi chép HSBA của ĐDV là 86,4%. Hầu hết các hoạt động trong nhiệm vụ này ĐDV thực hiện hoàn thành chiếm tỷ lệ cao (88%).

Bảng 3.2. Đánh giá chung việc thực hiện 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV

STT	Các nhiệm vụ CSNB của ĐDV	Tần số	Chưa hoàn thành		Hoàn thành	
			Tần số	Tỷ lệ %	Tần số	Tỷ lệ %
1	Tư vấn, hướng dẫn GDSK.	213	170	79,8	43	20,2
2	Chăm sóc về tinh thần	213	65	30,5	148	69,5
3	Chăm sóc vệ sinh cá nhân	213	155	72,8	58	27,2
4	Chăm sóc dinh dưỡng	192	55	28,6	137	71,4
5	Chăm sóc phục hồi chức năng	76	20	26,3	56	73,7
6	CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật	95	13	13,7	82	86,3
7	Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh	213	51	23,9	162	76,1
8	CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong	61	22	36,1	39	63,9
9	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng	213	90	42,3	123	57,7
10	Theo dõi, đánh giá người bệnh	213	30	14,1	183	85,9
11	Bảo đảm an toàn, phòng ngừa sai sót chuyên môn, kỹ thuật trong CSNB	213	23	10,8	190	89,2
12	Ghi chép hồ sơ bệnh án	213	29	13,6	184	86,4
	Hoàn thành chung	**213**	**84**	**39,4**	**129**	**60,6**

Bảng 3.2 cho thấy, ĐDV thực hiện hoàn thành khá tốt ở các nhiệm vụ: CSNB

có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật (86,3%); theo dõi và đánh giá người bệnh (85,9%); bảo đảm an toàn, phòng ngừa sai sót chuyên môn (89,2%) và ghi chép HSBA (86,4%). Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng thì còn đến 42,3% ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK và chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh thì rất ít ĐDV thực hiện hoàn thành 2 nhiệm vụ này, chỉ chiếm tỷ lệ là 20,2% và 27,2%.

3.1.3. Việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV phân bố theo khoa

Bảng 3.3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV phân bố theo khoa

Khoa	Tần số	Chưa hoàn thành		Hoàn thành	
		Tần số	Tỷ lệ %	Tần số	Tỷ lệ %
Nhi	44	21	47,7	23	52,3
Cấp cứu	32	8	25,0	24	75,0
Ngoại tổng quát	26	7	26,9	19	73,1
NTK-CTCH và PHCN	23	9	39,1	14	60,9
Hồi sức tích cực-Chống độc	21	9	42,9	12	57,1
Nội Tổng hợp	18	10	55,6	8	44,4
Nội A	15	6	40,0	9	60,0
Tim mạch	14	8	57,1	6	42,9
Nội Thần kinh-Nội tiết	12	5	41,7	7	58,3
Nhiễm	8	1	12,5	7	87,5
Tổng cộng	**213**	**84**	**39,4**	**129**	**60,6**

Phần lớn các khoa có tỷ lệ hơn 50% ĐDV hoàn thành nhiệm vụ CSNB. Riêng khoa Nội tổng hợp và khoa Tim mạch có ĐDV hoàn thành nhiệm vụ CSNB chiếm tỷ lệ thấp dưới 50%, với tỷ lệ lần lượt là 44,4% và 42,9%.

3.2. Một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV

3.2.1. Yếu tố cá nhân liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa các yếu tố cá nhân với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Các yếu tố		Chưa hoàn thành	Hoàn thành	OR (95% CI)	χ^2	p
Nhóm tuổi	< 30 tuổi	60	74	1,86	4,313	**0,038**
	≥ 30 tuổi	24	55	(1,03-3,35)		
Giới	Nam	22	25	1,476	1,372	0,241
	Nữ	62	104	(0,77-2,84)		
Trình độ chuyên môn						
	Cao đẳng trở lên	8	11	1,13	0,062	0,803
	Trung học	76	118	(0,43-2,94)		
Thâm niên công tác						
	< 10 năm	69	89	2,07	4,593	**0,032**
	≥ 10 năm	15	40	(1,06-4,05)		
Vị trí phân công CSNB						
	Buồng bệnh thường	49	56	1,83	4,532	**0,033**
	Buồng bệnh nặng/HSTC	35	73	(1,05-3,18)		

Kết quả bảng 3.4 cho thấy, các yếu tố cá nhân của ĐDV có liên quan có ý nghĩa thống kê với mức độ hoàn thành chung nhiệm vụ CSNB như: tuổi, thâm niên công tác, vị trí được phân công CSNB (với $p < 0,05$).

Các yếu tố cá nhân khác như giới tính và trình độ chuyên môn thì chưa tìm thấy có mối liên quan với mức độ hoàn thành chung nhiệm vụ CSNB của ĐDV.

Bảng 3.5. Mối liên quan giữa tuổi, trình độ chuyên môn của ĐDV với các nhiệm vụ CSNB

Nhóm tuổi	Chưa hoàn thành	Hoàn thành	OR (95% CI)	χ^2	p
Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho ngư ời bệnh (n = 213)					
< 30 tuổi	38	96	2,01 (1,01-4,06)	3,866	0,049
≥ 30 tuổi	13	66			
Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối/tử vong (n = 61)					
< 30 tuổi	20	23	6,96 (1,42-34,03)	6,896	0,009
≥ 30 tuổi	2	16			
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng (n = 213)					
< 30 tuổi	64	70	1,86 (1,05-3,33)	4,492	0,034
≥ 30 tuổi	26	53			
Tư vấn, hướng dẫn GDSK (n = 213)					
Trình độ chuyên môn					
Trung học	159	35	3,30 (1,24-8,82)	6,219	0,013
Cao đẳng trở lên	11	8			

Bảng 3.5 cho thấy, nhóm tuổi của ĐDV có liên quan ý nghĩa thống kê với mức độ hoàn thành nhiệm vụ dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh, CSNB giai đoạn hấp hối/ tử vong và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng ($p < 0,05$).

Trình độ chuyên môn của ĐDV có liên quan với mức độ hoàn thành nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh ($p < 0,05$).

Bảng 3.6. Mối liên quan giữa giới tính của ĐDV với mức độ hoàn thành các nhiệm vụ CSNB

Giới tính		Chưa hoàn thành	Hoàn thành	OR (95% CI)	χ^2	p
Chăm sóc vệ sinh cá nhân (n = 213)						
	Nam	40	7	2,53	4,632	0.031
	Nữ	115	51	(1,06-6,04)		
Chăm sóc dinh dưỡng (n = 192)						
	Nam	16	21	2,27	4,778	0,029
	Nữ	39	116	(1,08-4,77)		
Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật (n = 95)						
	Nam	8	21	4,65	6,830	0,009
	Nữ	5	61	(1,37-15,78)		
Theo dõi, đánh giá người bệnh (n = 213)						
	Nam	11	36	2,36	4,329	0,037
	Nữ	19	147	(1,03-5,41)		
Ghi chép hồ sơ bệnh án (n = 213)						
	Nam	13	34	3,59	10,114	0,001
	Nữ	16	150	(1,58-8,15)		

Kết quả bảng 3.6 cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ hoàn thành CSNB giữa ĐDV nam và nữ ở các nhiệm vụ như: chăm sóc vệ sinh cá nhân, chăm sóc dinh dưỡng, CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật; theo dõi và đánh giá người bệnh và ghi chép HSBA (p , 0,05).

Bảng 3.7. Mối liên quan giữa thâm niên và vị trí được phân công với mức độ hoàn thành các nhiệm vụ CSNB

Thâm niên công tác	Chưa hoàn thành	Hoàn thành	OR (95% CI)	χ^2	p
Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật (n = 95)					
≥ 10 năm	6	16	3,54	4,476	0,034
< 10 năm	7	66	(1,04-11,97)		
Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối/tử vong (n = 61)					
< 10 năm	20	26	5,0	4,458	0,035
≥ 10 năm	2	13	(1,01-24,74)		
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng (n = 213)					
< 10 năm	76	82	2,71	8,576	0,003
≥ 10 năm	14	41	(1,37-5,37)		
Tư vấn, hướng dẫn GDSK (n = 213)					
Vị trí phân công CSNB					
Buồng bệnh thường	92	13	2,72	7,833	0,005
Buồng bệnh nặng/HSTC	78	30	(1,33-5,58)		

Kết quả cho thấy các nhiệm vụ như: CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật, người bệnh hấp hối, thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và tư vấn giáo dục sức khỏe có liên quan ý nghĩa thống kê với thâm niên công tác và vị trí được phân công CSNB của ĐDV ($p < 0,05$).

3.2.2. Các yếu tố tổ chức liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB

Bảng 3.8. Mối liên quan giữa số nhân lực điều dưỡng và thời gian trực tiếp CSNB với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB

Khoa	Hoàn thành chung	Tần số	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Kiểm định t		
					95% CI		p
Số ĐDV trung bình trực tiếp CSNB/ngày	Chưa hoàn thành	84	9,9	4,45	-0,67	1,95	0,339
	Hoàn thành	129	9,3	4,93			
Thời gian trung bình ĐDV trực tiếp CSNB buổi sáng	Chưa hoàn thành	84	2,5	0,67	-0,47	-0,08	**0,007**
	Hoàn thành	129	2,8	0,75			
Thời gian trung bình ĐDV trực tiếp CSNB buổi chiều	Chưa hoàn thành	84	2,5	0,71	-0,28	0,16	0,588
	Hoàn thành	129	2,5	0,86			

Kết quả bảng 3.8 cho thấy, yếu tố về thời gian trung bình ĐDV trực tiếp CSNB vào buổi sáng liên quan có ý nghĩa thống kê đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ĐDV ($p < 0,05$). Thời gian trung bình CSNB vào buổi sáng của ĐDV hoàn thành nhiệm vụ là 2,8 giờ, dài hơn so với thời gian trung bình CSNB của ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ (2,5 giờ).

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa số người bệnh trung bình/ĐDV trực tiếp chăm sóc tại các chuyên khoa với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB

Khoa	Hoàn thành chung	Tần số	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Kiểm định t 95% CI		p
Cấp cứu	Chưa hoàn thành	8	7,9	2,29	-1,13	2,38	0,473
	Hoàn thành	24	7,3	2,05			
HSTC-CĐ	Chưa hoàn thành	9	5,6	0,53	-0,43	0,71	0,613
	Hoàn thành	12	5,4	0,67			
Nội	Chưa hoàn thành	29	10,1	3,21	-1,01	2,09	0,492
	Hoàn thành	30	9,5	2,73			
Ngoại	Chưa hoàn thành	16	12,4	1,41	0,13	0,30	**0,033**
	Hoàn thành	33	10,9	3,63			
Nhi	Chưa hoàn thành	21	5,4	3,44	-3,95	0,81	0,189
	Hoàn thành	23	7,0	4,35			
Nhiễm	Chưa hoàn thành	1	7,0	0,0	-0,78	4,50	0,942
	Hoàn thành	7	7,1	1,77			

Bảng 3.9 cho thấy, tại khối Ngoại, số người bệnh trung bình do ĐDV hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc ít hơn so với số người bệnh trung bình do ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$).

Chương 4
BÀN LUẬN

4.1. Thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV tại BVNĐC, tỉnh Bến Tre năm 2014

BVNĐC có 18 khoa lâm sàng, nhưng chúng tôi chỉ chọn 10 khoa vào nghiên cứu vì đây là các khoa có tính chất công việc của ĐDV gần tương đồng nhau. Để thuận tiện cho việc so sánh về mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB giữa các ĐDV, chúng tôi phân 10 khoa lâm sàng thành 06 nhóm chuyên khoa, với mỗi nhóm gồm các ĐDV thực hiện số nhiệm vụ CSNB tương tự nhau. Có tổng số 213 ĐDV tham gia vào nghiên cứu, trong đó, số ĐDV ở các khoa thuộc khối Nội, Ngoại, Nhi có tỷ lệ gần tương đương (27,3%, 23,0% và 20,7%) và cao hơn so với các chuyên khoa còn lại, đây cũng là những khoa lớn và có số nhiệm vụ CSNB rất khác nhau do tính đặc thù của chuyên khoa. Vì vậy, chúng tôi không so sánh về mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV giữa các chuyên khoa với nhau.

Nghiên cứu được tiến hành với phương pháp quan sát trực tiếp 213 ĐDV thực hiện CSNB vào giờ hành chính trong các ngày làm việc và quan sát gián tiếp qua 639 HSBA của người bệnh nội trú được chăm sóc bởi 213 ĐDV, để đánh giá tương đối toàn diện về các hoạt động CSNB dựa theo chỉ số đánh giá thực hiện thông tư 07/2011/TT-BYT của Cục quản lý khám chữa bệnh [18]. Khác với một số nghiên cứu trước đây được tiến hành qua phỏng vấn người bệnh và ĐDV hoặc vừa phỏng vấn người bệnh vừa quan sát trực tiếp ĐDV, kết hợp với nghiên cứu định tính [28], [32], [48], nghiên cứu của chúng tôi dựa vào bằng chứng quan sát thực tế. Dù với phương pháp nghiên cứu khác nhau nhưng mục đích vẫn là đánh giá việc thực hiện CSNB của ĐDV, góp phần từng bước củng cố các hoạt động CSNB theo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, nâng cao chất lượng bệnh viện.

4.1.1. Các thông tin chung về ĐDV tham gia nghiên cứu

ĐDV tham gia nghiên cứu đa số là nhân lực trẻ, nhỏ hơn 30 tuổi (62,9%), thâm niên công tác dưới 10 năm chiếm tỷ lệ cao (74,2%), phần lớn là nữ giới (77,9%). Kết quả này cũng khá tương đồng với các nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (2011), Dương Thị Bình Minh tại

bệnh viện Hữu Nghị (2012) và nghiên cứu của Trần Ngọc Trung tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng (2012) [28], [47], [48]. ĐDV tại đa số các bệnh viện là lực lượng trẻ, phần lớn là nữ giới, điều này cũng phù hợp với tính chất nghề nghiệp của người điều dưỡng, đây cũng là đội ngũ có nhiều khả năng nắm bắt nhanh nhạy các kỹ thuật mới, biết nhìn nhận và dễ thay đổi hành vi, thái độ tốt trong thực hiện CSBN (bởi được đào tạo với chương trình mới hơn). Tuy nhiên, còn hạn chế về kinh nghiệm chuyên môn và đặc biệt là kiến thức, kỹ năng về chuyên khoa sâu. Vì vậy, cần phải rèn luyện thêm kỹ năng chuyên môn để có thể đáp ứng các nhu cầu chăm sóc ngày càng cao của người bệnh.

Về trình độ chuyên môn, kết quả cho thấy ĐDV có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm một phần rất nhỏ trong lực lượng ĐDV trực tiếp CSNB (8,9%). Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn (38,7%), nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh (15,5%) và nghiên cứu của Trần Ngọc Trung (11,7%). So với tiêu chuẩn của Bộ y tế, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015 ĐDV, HSV có trình độ từ cao đẳng trở lên phải đạt 30% [11]. Như vậy, tỷ lệ này hiện tại BV NĐC còn rất thấp, để đạt được chỉ tiêu này bệnh viện ngoài việc tạo điều kiện cử ĐDV, HSV học nâng cao trình độ cần đề ra tiêu chí ưu tiên tuyển dụng ĐDV, HSV có trình độ từ cao đẳng trở lên.

4.1.2. Mức độ hoàn thành đối với từng nhiệm vụ CSNB của ĐDV

4.1.2.1. Tư vấn, hướng dẫn GDSK

Đây là một nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện ngay từ khi người bệnh vào viện, trong thời gian nằm viện và trước khi ra viện, nhằm giúp người bệnh và NNNB hiểu được nội quy, quy định của bệnh viện, biết về tình hình sức khỏe để hợp tác trong điều trị, duy trì và cải thiện sức khỏe. Thông tư 07/2011/TT-BYT đặt nhiệm vụ này đầu tiên trong 12 nhiệm vụ của ĐDV và Bộ Y tế cũng đặt nhiệm vụ này trong tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện [9], [12].

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ĐDV hoàn thành chung đối với nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK chiếm tỷ lệ 20,2%. Trong đó, phần lớn các hoạt động trong nhiệm vụ này ĐDV thực hiện hoàn thành đều chiếm tỷ lệ thấp, cao nhất chỉ ở mức 52,7% là hoạt động hướng dẫn người bệnh cách phòng bệnh khi ra viện và chiếm tỷ

lệ thấp nhất là phổ biến cho người bệnh/NNNB về quyền lợi và nghĩa vụ khi nằm viện (9,9%). Điều này cho thấy, ĐDV chưa thật sự quan tâm đến công tác tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh. Theo quy định của Bộ Y tế người bệnh phải được tư vấn, GDSK phù hợp với bệnh khi vào viện, trong quá trình điều trị và lúc ra viện [9], [12]. Nhưng, phần lớn ĐDV chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ này, chỉ thực hiện khi có người bệnh/NNNB hỏi đến. Về phía bệnh viện, mặc dù đã có quy định tư vấn, hướng dẫn GDSK nhưng thiếu kiểm tra giám sát việc thực hiện. Như nghiên cứu của Aghakhani (2012), đã phát hiện rằng hững rào cản quan trọng nhất của tư vấn GDSK cho người bệnh là tình hình làm việc của điều dưỡng, là do điều dưỡng thiếu kiến thức về GDSK. Về cơ sở bệnh viện, là thiếu các nguồn tài liệu, thiếu kiểm tra thực hiện GDSK [51].

Đánh giá chung về nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK thì tỷ lệ ĐDV trong nghiên cứu của chúng tôi thực hiện đạt thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Châu Thị Hoa tại bệnh viện Trung ương Huế năm 2010 (76%) [22], nghiên cứu của Bùi Thị Bích Ngà tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương năm 2011 (49,6%) [32], nghiên cứu của Trần Ngọc Trung tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2012 (24,7%) [47]. Nhưng các nghiên cứu này thực hiện đánh giá qua lấy ý kiến người bệnh, do đó có thể phản ánh chưa đầy đủ so với thực tế vì cảm tính từ phía người bệnh. Riêng nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh tại bệnh viện Hữu Nghị (2012), đánh giá nhiệm vụ này qua ý kiến người bệnh và quan sát ĐDV là 66,2% [28], nhưng người bệnh là cán bộ trung cao, là đối tượng chính sách nên ĐDV có thể ý thức hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Còn nghiên cứu của Trần Thị Thảo tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (2013) đạt tỷ lệ 74,1% [42], được đánh giá trong mô hình chăm sóc theo đội nên ĐDV có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Từ kết quả nghiên cứu này cho thấy, để ĐDV có kỹ năng, kiến thức tốt và chủ động trong việc tư vấn GDSK cho người bệnh/NNNB trong phạm vi chuyên môn của mình, bệnh viện cần tổ chức tập huấn hướng dẫn các quy định, cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng GDSK cho ĐDV.

4.1.2.2. Chăm sóc về tinh thần:

Là nhiệm vụ không thể thiếu của người điều dưỡng, theo nghiên cứu của

Nguyễn Trường Sơn (2007), đa số người bệnh vào khám và chữa bệnh đều có nhu cầu chăm sóc về mặt tinh thần là 86,5%, người bệnh chọn điều dưỡng để chia sẻ và tư vấn chiếm tỷ lệ lần lượt là 28,7% và 27,2% [37]. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của điều dưỡng đối với nhiệm vụ CSNB về mặt tinh thần.

Kết quả của biểu đồ 3.2 cho thấy, ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ chăm sóc về tinh thần chiếm tỷ lệ 69,5%, tương đồng với kết quả trong nghiên cứu của Bùi Thị Bích Ngà (2011) đạt 66,2% [32], nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của Châu Thị Hoa (2010) là 90,7% [22] và nghiên cứu của Trần Thị Thảo (2013) là 97,2% [42]. Lý giải về sự khác biệt này, có thể do phạm vi nghiên cứu của Châu Thị Hoa được giới hạn ở đối tượng là người bệnh ung thư hạ họng – thanh quản nên công tác chăm sóc về tinh thần được ĐDV chú trọng hơn. Còn phạm vi nghiên cứu của Trần Thị Thảo được giới hạn ở các đội chăm sóc, nhiệm vụ này được đánh giá qua lấy ý kiến người bệnh nên có thể có sự gắn bó giữa đội chăm sóc với người bệnh, vì vậy phần lớn người bệnh đánh giá cao ĐDV về thực hiện nhiệm vụ này. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện tại 10 khoa lâm sàng với 02 dạng mô hình chăm sóc khác nhau gồm: mô hình điều dưỡng chăm sóc chính và mô hình chăm sóc theo nhóm, việc đánh giá nhiệm vụ này qua quan sát trực tiếp ĐDV thực hiện, nên kết quả đánh giá chung đạt tỷ lệ thấp hơn.

Động viên khuyến khích người bệnh an tâm điều trị là hoạt động cần thiết giúp người bệnh hợp tác tốt trong quá trình nằm viện, ĐDV đã thực hiện khá tốt hoạt động này (75,6%), tuy nhiên, kết quả này cũng thấp hơn so với nghiên cứu của Trần Thị Thảo [42], nhưng cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Trần Ngọc Trung (39,5%) [47].

Việc giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của người bệnh/NNNB trong quá trình điều trị, kết quả cho thấy chỉ có 52,1% ĐDV hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ này cũng thấp hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Trần Thị Thảo là 96,8%, nhưng cao hơn kết quả trong nghiên cứu của Trần Ngọc Trung (46,9%). Giải đáp thắc mắc cho người bệnh sẽ giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, yên tâm điều trị và tin tưởng vào bệnh viện. Tuy nhiên, ĐDV chưa thực sự chủ động hoặc chưa đủ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ này. Chính vì thế việc tập huấn, hướng dẫn cho điều dưỡng

về vấn đề này là hết sức cần thiết.

4.1.2.3. Chăm sóc vệ sinh cá nhân:

ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh chỉ chiếm tỷ lệ 27,2%. Trong đó, chiếm tỷ lệ thấp là hoạt động vệ sinh răng miệng cho người bệnh chăm sóc cấp 1 (46,2%), tuy nhiên tỷ lệ này cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Phạm Lê Hưng (31,7%).

Mặc dù tỷ lệ ĐDV hoàn thành nhiệm vụ chưa cao ở các hoạt động: tắm gội đầu cho người bệnh (23,1%), hỗ trợ người bệnh đại/tiểu tiện (19,2%). nhưng so với kết quả của các nghiên cứu khác thì các tỷ lệ này cao hơn rất nhiều. Nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn (2011), tỷ lệ người bệnh được ĐDV thay đồ vải (43,9%), vệ sinh thân thể (3,0%), vệ sinh răng miệng (1,5%) [48]. Nghiên cứu của Trần Ngọc Trung (2012), tỷ lệ điều dưỡng thực hiện thay đồ vải (13,7%); chăm sóc vệ sinh răng miệng (6,2%); tắm, gội đầu cho người bệnh (6,2); hỗ trợ đại tiểu tiện (1,6%) [47].

Thực tế các nhiệm vụ này hầu như chỉ được ĐDV tại các đơn nguyên HSTC thực hiện tốt, còn tại các buồng bệnh nặng rải rác ở các khoa lâm sàng thì chưa được ĐDV thực hiện đầy đủ, nhất là đối với nhiệm vụ vệ sinh răng miệng cho người bệnh. Nghiên cứu của Hajbaghery và Ansari (2013) đã chỉ ra rằng những rào cản quan trọng nhất để chăm sóc răng miệng cho người bệnh là điều dưỡng có quá nhiều nhiệm vụ ghi chép và sự nhận thức rằng chăm sóc răng miệng không là nhiệm vụ ưu tiên [50]. Một trong các yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc răng miệng cho người bệnh theo Phạm Lê Hưng là do thiếu sự kiểm tra giám sát của điều dưỡng trưởng khoa và bác sĩ điều trị [25]. Chính vì vậy, trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSNB trong các bệnh viện, Thông tư 07/2011/TT-BYT và Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đều yêu cầu các bệnh viện phải có quy định cụ thể, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ về chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh nội trú, trong đó có chăm sóc vệ sinh răng miệng [9], [12], [30].

4.1.2.4. Chăm sóc dinh dưỡng:

Người bệnh và người chăm sóc nếu được hướng dẫn, tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý sẽ giúp tránh các nguy cơ tai biến hoặc biến chứng nặng thêm; đồng thời giúp tăng hiệu quả sử dụng thuốc cho người bệnh và góp phần nâng cao chất lượng điều trị [12].

Kết quả biểu đồ 3.4 cho thấy, ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh chiếm tỷ lệ 71,4%. Trong đó, hoạt động tư vấn, hướng dẫn về chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng bệnh là 66,5%, tỷ lệ này đạt cao hơn so với nghiên cứu của Trần Ngọc Trung (34,3%) [47], nhưng lại thấp hơn so với nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh (90,7%) [28]. Lý giải điều này là do nghiên cứu của chúng tôi thực hiện qua quan sát trực tiếp nên có thể khi ĐDV thực hiện nhiệm vụ này không rơi vào thời điểm chúng tôi quan sát, dẫn đến kết quả đạt không cao so với kết quả của Dương Thị Bình Minh thực hiện qua đánh giá của người bệnh.

Nghiên cứu cho thấy, còn đến 12% ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp thực hiện cho người bệnh ăn qua sonde dạ dày, kết quả này khá tương đồng với nghiên cứu của Trần Ngọc Trung là 12,2% [47] và nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh là 10,2% [28]. Như vậy, vẫn còn tình trạng ĐDV giao phó nhiệm vụ này cho NNNB tự thực hiện. Một nghiên cứu trước đây tại BV NĐC về khảo sát tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đặt sonde dạ dày nuôi ăn của tác giả Võ Thị Trang Đài (2010) [19], có đến 43,1% NNNB tự cho người bệnh ăn qua sonde dạ dày. So với kết quả nghiên cứu trước đây thì tỷ lệ ĐDV trực tiếp cho người bệnh ăn qua sonde dạ dày đã tăng lên rất nhiều (từ 56,9% lên 88%), nhưng vẫn cần phải duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo 100% người bệnh có chỉ định ăn qua sonde dạ dày phải do ĐDV trực tiếp thực hiện đúng theo quy định của Bộ y tế [9].

4.1.2.5. Chăm sóc phục hồi chức năng:

Biểu đồ 3.5 cho thấy, nhiệm vụ này tỷ lệ ĐDV hoàn thành nhiệm vụ chung đạt 73,7%. Trong đó, các hoạt động như: hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh tập luyện, phục hồi chức năng trong thời gian nằm viện và hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh xoay trở,

vận động phòng ngừa loét do tỳ đè đều đạt tỷ lệ hơn 76,0%. Điều này cho thấy ĐDV đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ này so với kết quả trong nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn (13,6%) và Trần Ngọc Trung (40,2%) [47], [48]. Nhưng thấp hơn so với kết quả trong nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh (81,5%) [28], tuy nhiên nghiên cứu này đánh giá qua người bệnh chứ không quan sát trực tiếp như nghiên cứu của chúng tôi, nên có thể mang tính chủ quan từ phía người bệnh.

4.1.2.6. Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật:

Phẫu thuật/thủ thuật là một phương pháp điều trị, có thể gây ra sang chấn làm ảnh hưởng nhất định tới cơ thể người bệnh. Theo nghiên cứu của Thái Hoàng Để (2010), đánh giá tâm lý người bệnh trước phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa huyện An Phú tỉnh An Giang, có đến 83,4% người bệnh lo lắng trước cuộc phẫu thuật [20]. Vì vậy, việc chuẩn bị chu đáo và ổn định tâm lý cho người bệnh góp phần quan trọng vào thành công của cuộc phẫu thuật/thủ thuật. Kết quả của biểu đồ 3.6 cho thấy, ĐDV thực hiện rất tốt nhiệm vụ CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật với mức độ hoàn thành nhiệm vụ khá cao (86,3%).

Từ một kết quả nghiên cứu trước đây của Trần Thị Tuyết Nga (2010), về khảo sát tâm lý người bệnh trước phẫu thuật tại BVNĐC cho thấy chỉ có 47,3% người bệnh được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ chuẩn bị trước phẫu thuật [33]. Nghiên cứu này đã khuyến nghị cần phải tăng cường nhắc nhở và kiểm tra giám sát, vì vậy, kết quả tỷ lệ ĐDV thực hiện hoạt động này trong nghiên cứu của chúng tôi đã tăng lên đáng kể (90,5%). Về hoạt động chuyển người bệnh đến nơi phẫu thuật/thủ thuật, bàn giao tình trạng người bệnh và HSBA thì ĐDV cũng thực hiện khá tốt (89,5%), kết quả này cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Lê Thị Kim Nhung về thực trạng bàn giao người bệnh trước phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2013, có 57% ĐDV chưa hoàn tất thông tin người bệnh trước khi chuyển người bệnh đến nơi phẫu thuật và 100% ĐDV không bàn giao về tình trạng bệnh [34]. Nhưng nghiên cứu này thực hiện đối với việc chuẩn bị và bàn giao người bệnh phẫu thuật cấp cứu, nên ĐDV chưa kịp hoàn tất các thủ tục cần thiết cho người bệnh. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề để ĐDV tại các bệnh viện khác quan tâm và khắc phục.

4.1.2.7. Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh:

Điều dưỡng là người trực tiếp dùng thuốc hoặc hướng dẫn người bệnh dùng thuốc. Sự hiểu biết và thành thạo của người điều dưỡng trong quá trình chăm sóc bằng thuốc sẽ giúp việc sử dụng thuốc cho người bệnh vừa hiệu quả vừa an toàn. Qua kết quả biểu đồ 3.7, đánh giá chung về nhiệm vụ dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh ĐDV thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này đạt tỷ lệ 76,1%. Trong đó, có 03 nhiệm vụ được ĐDV thực hiện hoàn thành đạt tỷ lệ khá cao: Phát thuốc đúng giờ và hướng dẫn người bệnh cách sử dụng thuốc (85,4%), ghi hoặc đánh dấu vào sổ thuốc đã dùng cho người bệnh (85,9%) và thực hiện công khai thuốc cho người bệnh theo quy định bệnh viện (85,4%). Đối với các nhiệm vụ này, ĐDV đã thực hiện rất nghiêm túc vì đây là các hoạt động thường quy của ĐDV khi thực hiện y lệnh dùng thuốc cho người bệnh và liên quan đến vấn đề thanh toán chi phí điều trị. Tuy nhiên, Còn đến 66,2% ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ thông báo cho người bệnh về tên thuốc, số lượng thuốc dùng và tác dụng của thuốc. Trong khi đó, ở nhiệm vụ này ĐDV tại bệnh viện Hữu Nghị đã thực hiện rất tốt (94,4%) [28]. Kết quả này cho thấy có sự hạn chế về kiến thức dùng thuốc, về trình độ nên ĐDV e dè, thiếu tự tin khi thực hiện nhiệm vụ thông báo tên thuốc và tác dụng của thuốc với người bệnh. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Nương về hiệu quả các giải pháp nâng cao kỹ năng chăm sóc bằng thuốc của điều dưỡng bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 2012, Có đến 30,9% ĐDV chưa biết tính chất dược lý của thuốc và 51,1% không giải thích, hướng dẫn người bệnh cách dùng thuốc phù hợp [35]. Việc hạn chế kiến thức về tính chất dược lý của thuốc sẽ kéo theo hạn chế trong việc hướng dẫn, giải thích tác dụng của thuốc cho người bệnh. Vì vậy, bệnh viện cần tăng cường cập nhật kiến thức về thuốc cho ĐDV bằng hình thức tập huấn dược lâm sàng và kỹ năng hướng dẫn người bệnh dùng thuốc.

Việc cho người bệnh uống thuốc ngay tại giường trước sự chứng kiến của ĐDV thì tỷ lệ ĐDV hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa cao (63,4%), nghĩa là còn đến 36,6% ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ ĐDV hoàn thành nhiệm vụ này thấp hơn rất nhiều so với kết quả trong nghiên cứu của Trần Ngọc Trung (94,8%) và nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh là 96,3% [28], [47]. Như vậy, ĐDV trong

nghiên cứu của chúng tôi chưa quan tâm đến việc cho người bệnh uống thuốc, nên còn đến 32,9% ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ theo dõi trong quá trình dùng thuốc cho người bệnh. So với Tiêu chuẩn 7 về "Dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả" được Bộ Y tế đề ra trong Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam thì ĐDV chưa thực hiện đạt tiêu chí 5 về đánh giá hiệu quả của việc dùng thuốc [10]. Đây chính là những vấn đề tồn tại mà bệnh viện cần quan tâm cải thiện sớm trong thời gian tới.

4.1.2.8. Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối/tử vong:

Trách nhiệm của người điều dưỡng là tạo sự thoải mái cho người bệnh tới mức có thể đáp ứng những nhu cầu về mặt cảm xúc của người bệnh và NNNB, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn mang tính đạo đức nghề nghiệp, việc an ủi động viên người bệnh/NNNB và tạo điều kiện để NNNB ở cạnh người bệnh là hết sức cần thiết, đảm bảo cho người bệnh và NNNB không bị đơn độc trong cơn khủng hoảng của giai đoạn này.

Kết quả nghiên cứu có 61/213 ĐDV trực tiếp CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong thì tỷ lệ ĐDV hoàn thành chung đối với nhiệm vụ này là 63,9% (biểu đồ 3.8). Trong đó, chỉ có 63,9% ĐDV thực hiện tốt nhiệm vụ động viên an ủi NNNB và 78,7% ĐDV tạo điều kiện để NNNB ở cạnh người bệnh. Còn trong nghiên cứu của Trần Công Minh thì kết quả đạt thấp hơn, chỉ có 42% NNNB được ĐDV động viên an ủi. Nhìn chung, ĐDV chưa quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Đối với nhiệm vụ thông báo và giải thích với NNNB về tình trạng của ngư ời bệnh, có 54,1% ĐDV hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ thường do bác sĩ điều trị trực tiếp thực hiện, nên có lẽ ĐDV chưa nhận thức được đây cũng là nhiệm vụ của mình. NNNB có thể hỏi rất nhiều điều và ĐDV có thể trả lời những vấn đề trong phạm vi chuyên môn được phép. Điều này cho thấy cần có sự phối hợp tốt với bác sĩ điều trị để ĐDV nhận thức đầy đủ và tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ này.

4.1.2.9. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng:

Đây là nhiệm vụ cơ bản của người điều dưỡng, việc tuân thủ và thành thạo các bước trong thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dưỡng sẽ góp phần làm tăng hiệu quả điều trị và kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện. Kết quả nghiên cứu tại biểu

đồ 3.9 cho thấy, đánh giá chung về thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng thì tỷ lệ ĐDV hoàn thành nhiệm vụ chiếm không cao (57,7%). Theo kết quả nghiên cứu của Lê Thị Bình tại 9 bệnh viện tuyến tỉnh/thành và trung ương (2013), tỷ lệ ĐDV thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chỉ đạt dưới mức trung bình ở đa số các bệnh viện. Lý giải về vấn đề này tác giả cho rằng, điều dưỡng chỉ thực hiện những bước cơ bản không thể nào thiếu được, còn toàn bộ các bước khác thì làm ẩu hoặc bỏ qua kể cả bước vô khuẩn, rửa tay trước khi thực hiện kỹ thuật. Vì sự quá tải người bệnh nên ĐDV phải làm nhanh, làm ẩu để đáp ứng với khối lượng công việc [1]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi so với Tiêu chuẩn 6 về "Tiến hành các kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình" được Bộ Y tế đề ra trong Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam thì ĐDV hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đạt trên mức trung bình nhưng vẫn còn ở tỷ lệ thấp [10]. Do vậy, cần có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo bệnh viện nhằm làm giảm áp lực công việc cho đội ngũ điều dưỡng và tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ trong thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn của ĐDV, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của ĐDV trong thực hiện CSNB.

4.1.2.10. Theo dõi và đánh giá người bệnh:

Biểu đồ 3.10 cho thấy, đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ này, tỷ lệ ĐDV hoàn thành nhiệm vụ chiếm 85,9%. So với kết quả trong nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh đạt tỷ lệ cao hơn (94%) [28]. Lý giải về sự khác biệt này, là do nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh đánh giá qua người bệnh kết hợp với quan sát ĐDV thực hiện, còn nghiên cứu của chúng tôi đánh giá nhiệm vụ này qua ghi chép của ĐDV trên HSBA, nên có thể có một số hoạt động được ĐDV thực hiện nhưng không ghi HSBA, dẫn đến kết quả đạt thấp hơn, cụ thể như: theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp trong nghiên cứu của chúng tôi ĐDV thực hiện đạt 84%, nghiên cứu của Dương Thị Bình Minh ĐDV thực hiện đạt 96,8%. Tuy nhiên, kết quả này trong nghiên cứu của chúng tôi vẫn cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Châu Thị Hoa (2010) tại Trung tâm ung bướu bệnh viện Trung ương Huế, ĐDV theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp của người bệnh chỉ đạt 66,7% [22], mặc dù đối tượng chăm sóc của ĐDV chỉ là nhóm người bệnh ung thư hạ họng – thanh quản, còn

nghiên cứu của chúng tôi thực hiện tại 10 khoa lâm sàng với nhiều loại bệnh khác nhau. So với kết quả nghiên cứu của Bùi Thị Bích Ngà (2011) tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương có tỷ lệ ĐDV thực hiện nhiệm vụ này đạt yêu cầu là 80,5% vẫn thấp hơn kết quả nghiên cứu của chúng tôi [32]. Mặc dù, nghiên cứu của Bùi Thị Bích Ngà có phạm vi bao phủ tất cả các khoa lâm sàng trong bệnh viện nhưng chỉ dừng ở mức đánh giá qua khảo sát ý kiến người bệnh chứ không thực hiện quan sát qua các bằng chứng ĐDV ghi trên HSBA như nghiên cứu của chúng tôi.

4.1.2.11. Bảo đảm người bệnh an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn:

Giữ cho người bệnh được an toàn trong quá trình điều trị và chăm sóc tại bệnh viện là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được quy định đối với ĐDV. Chính vì vậy, trong 8 Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của ĐDV thì tiêu chuẩn "Đảm bảo an toàn cho người bệnh" được đặt ở Điều đầu tiên [31]. Theo Babaie (2006), ước tính trong số từ 44.000 đến 98.000 người bệnh tử vong do sai sót chăm sóc y khoa thì có gần một nửa là phòng ngừa được trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc. Về mặt lý thuyết, nếu điều dưỡng không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chăm sóc điều dưỡng cần thiết thì có thể gây tổn hại đến người bệnh [52]. Kết quả nghiên cứu trình bày trong biểu đồ 3.11 cho thấy, tỷ lệ ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ bảo đảm người bệnh an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật đạt 89,2%. Trong đó, tỷ lệ ĐDV thực hiện an toàn trong vận chuyển người bệnh đạt 87%, nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của Cao Thị Thẩm (2007), đánh giá công tác an toàn trong y tế trước và sau tập huấn chăm sóc toàn diện tại bệnh viện Trung ương Huế, tỷ lệ ĐDV thực hiện an toàn trong vận chuyển người bệnh đạt từ 92% trước tập huấn lên 96% sau tập huấn [40]. Điều này cho thấy, BV NĐC cần tổ chức tập huấn lại cho ĐDV về các quy định an toàn người bệnh, đồng thời cũng cần thiết có một nghiên cứu đánh giá về nhận thức an toàn người bệnh của ĐDV trong các kỹ thuật CSNB để có giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn người bệnh khi đến điều trị tại bệnh viện.

4.1.2.12. Ghi chép hồ sơ bệnh án:

Chất lượng ghi chép hồ sơ của điều dưỡng có thể phản ánh tiêu chuẩn chăm sóc mà ĐDV đã thực hiện cho người bệnh, sự ghi chép thiếu thông tin hoặc thông

tin không chính xác có thể dẫn đến những nghi ngờ về chất lượng công tác chăm sóc của người điều dưỡng. Ngoài ra, ghi chép điều dưỡng còn là những thông tin liên lạc giữa điều dưỡng và bác sĩ, giữa các điều dưỡng với nhau nhằm đảm bảo những diễn biến về tình trạng người bệnh được theo dõi liên tục, đồng thời là bằng chứng xác nhận việc thực hiện y lệnh của ĐDV.

Kết quả biểu đồ 3.12 cho thấy, tỷ lệ ĐDV hoàn thành chung nhiệm vụ ghi chép HSBA đạt 86,4%, trong đó tỷ lệ ĐDV hoàn thành nhiệm vụ ghi phiếu chăm sóc điều dưỡng về thông tin người bệnh chính xác đạt 87,8%; thống nhất thông tin giữa ĐDV và bác sĩ điều trị đạt 88,3%; ghi đầy đủ, kịp thời diễn biến bệnh và các can thiệp điều dưỡng đạt 87,8%. Kết quả này cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Phan Cảnh Chương đánh giá thực trạng ghi chép HSBA của ĐDV, HSV tại bệnh viện Trung ương Huế (2012) đạt tỷ lệ lần lượt là 57%. 70% và 22% [17]. Còn so với nghiên cứu của Huỳnh Thị Mỹ Thanh tại bệnh viện An Giang (2012), các kết quả này lần lượt là 93,3%, 96,7% cao hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. Nhưng về ghi đầy đủ, kịp thời diễn biến bệnh và các can thiệp điều dưỡng (26,7%) thì thấp hơn nghiên cứu của chúng tôi (87,8%) [41]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ thực hiện ngẫu nhiên trên 30 HSBA, khác với nghiên cứu của chúng tôi thực hiện ngẫu nhiên trên 639 HSBA do 213 ĐDV tham gia nghiên cứu trực tiếp phụ trách nên có tính khách quan hơn.

Nghiên cứu tương tự của Nguyễn Thị Minh Tâm (2012), có kết quả đạt cũng thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi, với tỷ lệ lần lượt là 68,5%, 84,1% và 36,7% [38]. Tuy nhiên, nghiên cứu này được thực hiện với quy mô rộng tại 16 bệnh viện thuộc các tuyến huyện, tỉnh và trung ương, do đó việc tuân thủ quy định về ghi chép HSBA của ĐDV tại mỗi bệnh viện khác nhau, nên kết quả đánh giá chung đạt thấp. Tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm cho rằng, tồn tại lớn nhất trong ghi phiếu chăm sóc của ĐDV, HSV là tính đầy đủ và chính xác của các thông tin. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của Ngô Thị Hoa (2007), đánh giá thực trạng việc ghi phiếu chăm sóc tại Bệnh viện 175, đã chỉ ra rằng việc ghi phiếu chăm sóc không đầy đủ và thiếu chính xác là do thời điểm ghi tập trung vào cuối giờ làm việc, cách ghi chép dàn trải tốn nhiều thời gian, mỗi người bệnh được ghi phiếu chăm sóc phải

mất trung bình từ 3 - 5 phút [23]. Thật vậy, đây cũng là tình hình chung tại đa số các bệnh viện, ĐDV sau khi thực hiện xong y lệnh mới tập trung ghi HSBA, do vậy có thể ghi thiếu chính xác và sót thực hiện y lệnh. Như nghiên cứu của Trần Văn Minh (2010), đánh giá công tác điều dưỡng tại bệnh viện Vạn Ninh đã phát hiện rằng, có 11,0% HSBA không ghi y lệnh phân cấp chăm sóc, 12,5% ghi thông tin người bệnh chưa chính xác, 25,7% ghi trùng lặp thông tin, 20,6% ghi diễn biến bệnh không thống nhất với bác sĩ [29]. Bên cạnh đó, còn có tình trạng chữ viết xấu, viết nội dung không rõ ràng, không cô đọng, một số thông tin trùng lặp [38], ngoài ra, việc mất quá nhiều thời gian ghi chép hồ sơ sẽ làm ảnh hưởng công tác CSNB.

4.2. Một số yếu tố có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV

4.2.1. Các yếu tố cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB

Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩ thống kê giữa mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB với nhóm tuổi và thâm niên công tác của ĐDV ($p < 0,05$). Kết quả bảng 3.4 cho thấy ĐDV dưới 30 tuổi thì có mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ CSNB cao gần gấp 2 lần so với ĐDV lớn hơn hoặc bằng 30 tuổi; ở ĐDV có thâm niên công tác dưới 10 năm thì mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ CSNB cao gấp 2 lần so với ĐDV làm việc từ 10 năm trở lên. Như nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cũng nhận thấy rằng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa độ tuổi, thâm niên công tác, giới tính và trình độ chuyên môn với mức độ thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV [48]. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi chưa tìm thấy mối liên quan giữa giới tính và trình độ chuyên môn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB, lý giải điều này có thể do cỡ mẫu nghiên cứu của chúng tôi nhóm ĐDV nam và nhóm trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên quá nhỏ.

Nhóm tuổi và thâm niên công tác của ĐDV: Qua phân tích cho thấy nhóm tuổi và thâm niên công tác đều có liên quan có ý nghĩa thống kê đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng ($p < 0,05$) (bảng 3.5 và 3.7).

Đối với nhiệm vụ CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong, ĐDV dưới 30 tuổi có mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ cao gấp 7 lần so với ĐDV lớn hơn hoặc bằng 30 tuổi

và ĐDV có thâm niên công tác dưới 10 năm thì mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ này cũng cao gấp 5 lần so với ĐDV làm việc từ 10 năm trở lên. Điều này cho thấy ở ĐDV lớn tuổi, làm việc lâu năm thì có kinh nghiệm và tự tin hơn so với ĐDV trẻ trong việc động viên, an ủi và giải thích về tình trạng của người bệnh với NNNB, việc CSNB trong giai đoạn này cũng có kỹ năng và nhiều kinh nghiệm hơn.

Đối với nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, ĐDV dưới 30 tuổi thì mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ cao gần gấp 2 lần so với ĐDV từ 30 tuổi trở lên và ĐDV công tác dưới 10 năm có mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ này cao gần gấp 3 lần so với ĐDV làm việc từ 10 năm trở lên. Lý giải về sự khác biệt này là do ĐDV trẻ, mới vào bệnh viện làm việc, các kỹ thuật điều dưỡng thường thực hiện chưa thành thạo, sự tuân thủ các bước của quy trình kỹ thuật điều dưỡng và quy trình vô khuẩn còn hạn chế, thiếu chủ động trong công tác giải thích hướng dẫn người bệnh hợp tác trước khi thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, chính các điều này dẫn đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung đạt thấp. Do vậy, bệnh viện cần có kế hoạch đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn, tập huấn lại các kỹ thuật điều dưỡng cho đội ngũ ĐDV, đặc biệt là ĐDV trẻ tuổi mới được tuyển dụng. Đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động chăm sóc của ĐDV.

Riêng yếu tố về tuổi cũng có liên quan đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh (bảng 3.5). ĐDV dưới 30 tuổi thì mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh cao gấp 2 lần so với ĐDV có độ tuổi từ 30 trở lên, kết quả này cũng phù hợp với thực tế, ĐDV ở độ tuổi từ 30 trở lên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về thuốc hơn so với các ĐDV trẻ, nên có nhiều thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn người bệnh cách dùng và giải thích về tác dụng của thuốc.

Kết quả nghiên cứu cũng phát hiện rằng ở ĐDV có thâm niên công tác trên 10 năm lại có mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật cao gấp 3,5 lần so với ĐDV có thâm niên công tác dưới 10 năm (bảng 3.5). Theo kết quả mô tả nêu trên, ĐDV có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên chiếm tỷ lệ 25,8%, đây là nhân lực có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức chuyên môn, nhưng trong đó có một số ĐDV lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, vì vậy dễ gặp trở ngại

trong một vài kỹ năng, kỹ thuật chuyên môn khó cần phải có độ chính xác cao, đặc biệt là ở khoa có tính chất đặc thù liên quan đến phẫu thuật/thủ thuật nhiều, nên ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Theo nghiên cứu của Trần Ngọc Trung có 10% ĐDV tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho rằng lớn tuổi là một trong những yếu tố tác động và cản trở nhiều nhất đến hoạt động CSNB [47]. Do đó bệnh viện cần có chính sách phù hợp để luân chuyển điều dưỡng đã lớn tuổi, khả năng nhanh nhạy hạn chế sang làm việc ở các khoa khác hoặc bộ phận khác trong bệnh viện, tạo điều kiện để ĐDV hoàn thành nhiệm vụ.

Giới tính của ĐDV: Mặc dù chưa tìm thấy mối liên quan giữa giới tính với mức độ hoàn thành chung nhiệm vụ CSNB, nhưng qua phân tích từng nhiệm vụ kết quả cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa giới tính với một số nhiệm vụ CSNB ($p < 0,05$) (bảng 3.6).

Kết quả phát hiện rằng, ở ĐDV là nam giới thì có mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ CSNB về vệ sinh cá nhân cao gấp 2,5 lần, về chăm sóc dinh dưỡng cao gấp 2 lần, về CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật cao gấp 4,5 lần, về theo dõi và đánh giá người bệnh cao gấp 2 lần và về ghi chép HSBA cao gấp 3,5 lần so với ĐDV là nữ giới. Nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn cũng cho thấy ĐDV là nam giới có mức độ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh ít thường xuyên hơn so với nữ giới [55]. Thật vậy, đây là các hoạt động chăm sóc cần có sự chu đáo và chăm chỉ của nữ giới, vì vậy ở ĐDV nam sẽ gặp khó khăn khi thực hiện. Theo Ozdemir (2008), nghiên cứu về giới và nghề nghiệp, nhận thức của sinh viên điều dưỡng về vai trò của ĐDV nam ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả đã chỉ ra rằng nghề điều dưỡng vẫn được coi là nghề phù hợp cho phái nữ, nhưng trong một vài hoạt động CSNB vẫn cần có điều dưỡng nam hỗ trợ, đặc biệt là ở các khu vực ICU và khoa cấp cứu là nơi thích hợp cho nam giới làm việc, còn khoa Nhi là nơi làm việc thích hợp cho giới nữ hơn [61]. Phát hiện trong nghiên cứu của chúng tôi góp phần giúp các nhà quản lý điều dưỡng có kế hoạch bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và tính chất công việc chuyên môn, nhằm tạo điều kiện để ĐDV nam phát huy năng lực hoàn thành nhiệm vụ CSNB.

Trình độ chuyên môn của ĐDV: nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên quan

giữa trình độ chuyên môn với mức độ hoàn thành chung nhiệm vụ CSNB. Tuy nhiên, qua phân tích riêng từng nhiệm vụ cho thấy trình độ chuyên môn của ĐDV có mối liên quan ý nghĩa thống kê với nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh ($p < 0,05$). Đối với ĐDV có trình độ chuyên môn trung học thì mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ cao gấp 3 lần so với ĐDV có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên (bảng 3.5). Thực tế cho thấy, ở ĐDV có trình độ từ cao đẳng trở lên thì nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng truyền đạt thông tin hơn so với ĐDV có trình độ trung học, vì vậy sẽ thuận lợi hơn trong việc tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh/NNNB, kết quả này cũng phù hợp với mô tả ở phần trên cho thấy bệnh viện có ĐDV trình độ từ cao đẳng trở lên trực tiếp CSNB chiếm tỷ lệ rất thấp (8,9%), nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh được ĐDV thực hiện cũng đạt tỷ lệ thấp (20,2%). Điều này cho thấy, bệnh viện cần quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ điều dưỡng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm tăng số lượng ĐDV trực tiếp CSNB có trình độ từ cao đẳng trở lên để nâng cao chất lượng chăm sóc.

Vị trí được phân công chăm sóc: Kết quả bảng 3.4 cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa vị trí được phân công CSNB với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung. ĐDV được phân công CSNB ở buồng bệnh thường có mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ cao gần gấp 2 lần so với ĐDV CSNB ở các buồng bệnh nặng/đơn nguyên HSTC ($p < 0,05$). Phân tích từng nhiệm vụ thì xác định được ĐDV CSNB ở buồng bệnh thường có mức độ chưa hoàn thành nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK cho người bệnh cao gần gấp 3 lần so với ĐDV CSNB ở các buồng bệnh nặng/đơn nguyên HSTC (bảng 3.7). Lý giải về sự khác biệt này, vì ĐDV được phân công ở các buồng bệnh thường đa số phải phụ trách từ 8 người bệnh trở lên (tương đương từ 1 đến 2 buồng bệnh) và ĐDV không thường xuyên có mặt tại buồng bệnh ngoài những lần phải đến buồng bệnh để thực hiện y lệnh. Do đó, hoạt động tư vấn, hướng dẫn GDSK chưa được ĐDV thực hiện đầy đủ. Còn đối với ĐDV phụ trách CSNB ở buồng bệnh nặng/đơn nguyên HSTC, mỗi ĐDV trung bình phụ trách chăm sóc từ 3 đến 6 người bệnh, mọi hoạt động chăm sóc diễn ra tập trung hơn, ĐDV luôn có mặt tại buồng bệnh hoặc luôn nhìn thấy người bệnh qua

vách kính, nên các nhu cầu của người bệnh thường được đáp ứng kịp thời hơn, vì vậy, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao hơn so với ĐDV CSNB ở buồng các bệnh thường.

4.2.2. Các yếu tố tổ chức có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB

4.2.2.1. Thời gian trực tiếp CSNB có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Kết quả bảng 3.8 cho thấy, thời gian trung bình ĐDV trực tiếp CSNB vào buổi sáng có liên quan có ý nghĩa thống kê đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ ($p < 0,05$). ĐDV hoàn thành nhiệm vụ có thời gian trung bình trực tiếp CSNB (2,8 giờ) dài hơn so với thời gian trung bình trực tiếp CSNB của ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ (2,5 giờ). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của J.Needleman và các cộng sự (2002), thời gian trung bình mỗi người bệnh được điều dưỡng chăm sóc mỗi ngày dài có liên quan đến chất lượng CSNB tốt và thời gian nằm viện của người bệnh ngắn hơn [60].

So với nghiên cứu của Bùi Ngọc Tuyền tại khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 2009, thời gian ĐDV trực tiếp chăm sóc trung bình một người bệnh chăm sóc cấp 1 là 5,5giờ trong 24giờ. Nghiên cứu này tiến hành tại một khoa ở đối tượng người bệnh chăm sóc cấp 1 và tính thời gian trung bình trực tiếp chăm sóc trong 24 giờ, nên có lượng thời gian chăm sóc dài hơn[49]. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên phạm vi 10 khoa lâm sàng, ở đối tượng người bệnh chăm sóc cấp 1, 2, 3 và tính tổng thời gian trung bình ĐDV trực tiếp CSNB vào buổi sáng và buổi chiều, do vậy có lượng thời gian ngắn hơn. Thực tế cho thấy, phần lớn các hoạt động CSNB tập trung vào buổi sáng hơn là buổi chiều và buổi tối. Từ tiếp nhận người bệnh mới đến khâu thực hiện y lệnh, vì vậy buổi sáng điều dưỡng thường bỏ ra nhiều thời gian hơn so với buổi chiều để CSNB. Ngoài ra, nếu ĐDV phải CSNB chăm sóc cấp 1 thì còn mất nhiều thời gian hơn, đặc biệt là tại các đơn nguyên HSTC, hầu hết thời gian vào buổi sáng là chăm sóc trực tiếp, các hoạt động chăm sóc gián tiếp thường diễn ra vào buổi chiều. Do đó, lượng thời gian trung bình ĐDV trực tiếp CSNB vào buổi sáng dài thì mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao.

4.2.2.2 Số người bệnh trung bình trên ĐDV trực tiếp chăm sóc có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB

Qua quan sát thực tế và sử dụng số liệu thứ cấp, kết quả cho thấy tại các nhóm chuyên khoa như Cấp cứu, HSTC, Nhi, Nhiễm, trung bình 1 ĐDV trực tiếp chăm sóc từ 6 đến 7 người bệnh vào ban ngày và 8 đến 15 người bệnh vào ban đêm. Đối với khối Nội trung bình 1 ĐDV trực tiếp chăm sóc từ 9 đến 10 người bệnh vào ban ngày và từ 23 đến 24 người bệnh vào ban đêm. Kết quả này tương đồng với khảo sát của Nguyễn Bích Lưu (2011), về công tác tổ chức chăm sóc và nhân lực điều dưỡng trong một ngày làm việc từ 30 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, cũng phát hiện rằng, trung bình 1 điều dưỡng phải trực tiếp chăm sóc từ 6 đến 7 người bệnh ban ngày và tăng lên rất cao về đêm từ 23 đến 24 người bệnh, gần gấp 4 lần so với ban ngày, dẫn đến tình trạng có nhiều nhu cầu cần chăm sóc không được điều dưỡng đáp ứng đầy đủ cho người bệnh [32]. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi không quan sát các hoạt động chăm sóc vào ban đêm và cũng chưa tìm thấy sự khác biệt về mức độ hoàn thành nhiệm vụ giữa các ĐDV trực tiếp CSNB trung bình trong khoảng từ 6 - 10 người bệnh vào ban ngày tại các khoa lâm sàng nêu trên. Riêng đối với các khoa thuộc khối Ngoại thì có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa số người bệnh trung bình trên ĐDV trực tiếp chăm sóc vào ban ngày với mức độ hoàn thành nhiệm vụ ($p < 0,05$). Số người bệnh trung bình do ĐDV hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc ít hơn so với số người bệnh trung bình do ĐDV chưa hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc (bảng 3.9). Thực tế cho thấy, ĐDV phụ trách chăm sóc số người bệnh càng nhiều thì có ít thời gian tiếp xúc với người bệnh, các hoạt động chăm sóc chủ yếu thực hiện y lệnh hơn là đáp ứng các nhu cầu của người bệnh. Qua đây cho thấy bệnh viện cần xem xét lại việc bố trí nhân lực tại các chuyên khoa Nội, Ngoại, vì các khoa này 1 ĐDV phải trực tiếp chăm sóc trung bình trong khoảng từ 10 đến 13 người bệnh vào ban ngày, sẽ không đảm bảo chất lượng chăm sóc.

4.3 Hạn chế của nghiên cứu:

Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp quan sát công khai trên phạm vi rộng 10 khoa lâm sàng để đánh giá 12 nhiệm vụ CSNB với 46 tiểu mục, vì vậy có thể xảy ra sai số do: sự mất tự nhiên khi thực hiện các hoạt động chăm sóc của

ĐDV; mỗi ĐDV CSNB ở các vị trí khác nhau, nhu cầu của người bệnh khác nhau nên việc đáp ứng nhu cầu cũng khác nhau. Một số giải pháp khắc phục các hạn chế nêu trên được thực hiện như: tiến hành quan sát ngẫu nhiên không báo trước; loại trừ không đánh giá các tiểu mục ĐDV không thực hiện do người bệnh không có nhu cầu, tuy nhiên vẫn có thể bỏ sót các hoạt động mà ĐDV có thực hiện ngoài thời gian quan sát của QSV. Do đó, kết quả của nghiên cứu này chỉ mang tính khái quát nhằm đánh giá nhanh việc thực hiện 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV theo quy định của BYT, làm cơ sở để chọn lựa nhiệm vụ ưu tiên cần chấn chỉnh trong hoạt động CSNB tại BVNĐC tỉnh Bến Tre.

KẾT LUẬN

1. Thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV:

Mức độ hoàn thành chung của 12 nhiệm vụ là 60,6%, trong đó mức độ hoàn thành của từng nhiệm vụ theo thứ tự giảm dần như sau: Bảo đảm an toàn, phòng ngừa sai sót chuyên môn (89,2%); ghi chép HSBA (86,4%); CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật (86,3%); theo dõi, đánh giá người bệnh (85,9%); dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc (76,1%); chăm sóc phục hồi chức năng (73,7%); chăm sóc dinh dưỡng (71,4%); chăm sóc tinh thần (69,5%); CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong (63,9%); thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng (57,7%); chăm sóc vệ sinh cá nhân (27,2%) và tư vấn, hướng dẫn GDSK (20,2%).

2. Một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV:

Nghiên cứu đã tìm thấy các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ĐDV như: nhóm tuổi, thâm niên công tác và vị trí phân công CSNB ($p < 0,05$). Trong đó, nhóm tuổi và thâm niên công tác cùng có mối liên quan với mức độ hoàn thành của các nhiệm vụ: CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong và thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng. Nhóm tuổi còn có mối liên quan với mức độ hoàn thành nhiệm vụ dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh; thâm niên công tác có mối liên quan với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật.

Vị trí phân công CSNB có mối liên quan ý nghĩa thống kê với mức độ hoàn thành nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn GDSK ($p < 0,05$).

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB có mối liên quan ý nghĩa thống kê với thời gian trung bình ĐDV trực tiếp CSNB vào buổi sáng và số người bệnh trung bình trên ĐDV trực tiếp chăm sóc ở khối Ngoại ($p < 0,05$).

KHUYẾN NGHỊ

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi có một số khuyến nghị như sau:

1. Đối với ĐDV:

– Cần cập nhật kiến thức để tự tin khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tư vấn, hướng dẫn và GDSK cho người bệnh.

– Rèn luyện kỹ năng thực hành điều dưỡng trong CSNB.

2. Đối với bệnh viện:

– Lập kế hoạch đào tạo bằng nhiều hình thức để ĐDV cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ ĐDV trẻ, mới được tuyển dụng.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CSNB của ĐDV ở các vị trí được phân công, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ: tư vấn, hướng dẫn GDSK; chăm sóc vệ sinh cá nhân; thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng; dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh; CSNB có chỉ định phẫu thuật/thủ thuật và CSNB giai đoạn hấp hối/tử vong.

– Lưu ý phân công ĐDV phụ trách chăm sóc số người bệnh trung bình phù hợp với năng lực và tính chất công việc, để ĐDV có nhiều thời gian trực tiếp CSNB và hoàn thành nhiệm vụ.

– Hoạt động đánh giá việc thực hiện 12 nhiệm vụ CSNB của ĐDV cần thiết phải được bệnh viện lập kế hoạch triển khai hàng quý, hàng năm nhằm phát hiện để củng cố kịp thời những hạn chế trong hoạt động CSNB.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

1. Lê Thị Bình (2013), "Khảo sát về kỹ năng thực hành của điều dưỡng viên khi chăm sóc bệnh nhân và các yếu tố ảnh hưởng", *Tạp chí Y học Thực hành*, 884(10), tr. 123-128.
2. Bộ Nội vụ (2005), Quyết đinh Số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/042005 về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tá điều dưỡng, Hà Nội.
3. Bộ Y tế (1993), Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 526-BYT/QĐ ngày 10 tháng 6 năm 1993 ban hành chế độ trách nhiệm của y tá trong việc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, Hà Nội.
4. Bộ Y tế (1997), *Quy chế bệnh viện*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
5. Bộ Y tế (2004), "Điều dưỡng học và các nguyên lý cơ bản về điều dưỡng", *Tài liệu Quản lý điều dưỡng*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 345-346.
6. Bộ Y tế (2004), "Điều dưỡng học và các nguyên lý cơ bản về điều dưỡng", *Tài liệu Quản lý điều dưỡng*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 347.
7. Bộ Y tế (2004), "Điều dưỡng học và các nguyên lý cơ bản về điều dưỡng", *Tài liệu Quản lý điều dưỡng*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 344.
8. Bộ Y tế (2004), "Hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam", *Tài liệu Quản lý điều dưỡng*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 163.
9. Bộ Y tế (2011), Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 về việc Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, Hà Nội.
10. Bộ Y tế (2012), Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1352/QĐ-BYT ngày 21 tháng 4 năm 2012 của Bộ Y tế), Hà Nội.
11. Bộ Y tế (2012), Chương trình hành động Quốc gia về tăng cường dịch vụ điều dưỡng, hộ sinh giai đoạn 2012 - 2020, Hà Nội.
12. Bộ Y tế (2013), Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế), Hà Nội.

13. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (2011), *Báo cáo công tác chăm sóc toàn diện năm 2011, kế hoạch năm 2012*.
14. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (2013), *Báo cáo công tác năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014*.
15. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (2013), *Báo cáo kết quả chấm điểm xếp hạng lại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu năm 2013*.
16. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (2013), *Sơ kết kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh 9 tháng đầu năm 2013*.
17. Phan Cảnh Chương và các cộng sự (2012), Kết quả đánh giá thực trạng ghi chép biểu mẫu, hồ sơ của điều dưỡng viên, hộ sinh viên tại Bệnh viện Trung ương Huế, *Quản lý điều dưỡng về cải tiến và hướng dẫn ghi mẫu phiếu điều dưỡng ngày 16/3/2012 tại 3 đầu cầu bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Chợ Rẫy*, Bệnh viện Chợ Rẫy, tr. 73-77.
18. Cục Quản lý Khám chữa bệnh (2012), Chỉ số đánh giá thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, Hà Nội.
19. Võ Thị Trang Đài (2010), "Khảo sát tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân đặt sonde dạ dày nuôi ăn tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre", *Kỷ yếu nghiên cứu nghị khoa học kỹ thuật Ngành Y tế Bến Tre lần thứ III*, Bến Tre, tr. 243-249.
20. Thái Hoàng Để (2011), "Đánh giá tâm lý bệnh nhân trước và sau phẫu thuật tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa huyện An Phú", *Kỷ yếu Hội nghị Khoa học bệnh viện An Giang*, tỉnh An Giang, tr. 187-193.
21. *Điều dưỡng viên*, Wikipedia Bách khoa toàn thư mở, tại trang web http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%81u_d%C6%B0%E1%BB%A1ng_vi%C3%AAn, truy cập ngày 13/11/2013.
22. Châu Thị Hoa và Nguyễn Thị Diệu Trang (2010), "Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh ung thư hạ họng - thanh quản tại Trung tâm ung bướu bệnh viện Trung Ương Huế (từ 1/1/2009 - 30/6/2010)", *Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội điều dưỡng Việt*

Nam, Nhà xuất bản GTVT, Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội, tr. 183-191.

23. Ngô Thị Hoa và cộng sự (2007), "Khảo sát đánh giá thực trạng việc ghi phiếu chăm sóc tại bệnh viện 175", *Chương trình đào tạo trong nước JICA- bệnh viện Chợ Rẫy 2008: Hội thảo an toàn người bệnh trong công tác chăm sóc*, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 1-5.
24. Hội Điều dưỡng Việt Nam (2010), "Lĩnh vực 2: Chăm sóc người bệnh", *Hướng dẫn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện*, Hà Nội, tr. 23.
25. Phạm Lê Hưng (2010), "Chăm sóc răng miệng cho người bệnh hồi sức cấp cứu của điều dưỡng các bệnh viện ở Hà Nội", *Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội điều dưỡng Việt Nam*, Nhà xuất bản GTVT, Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội, tr. 172-178.
26. Nguyễn Bích Lưu (2010), *Điều dưỡng với công tác chăm sóc toàn diện tại Việt Nam*, Hội Điều dưỡng Việt Nam, truy cập ngày 14/5/2013, tại trang web www.hoidieuduong.org.vn/vi/vna/library/detail/353.
27. Nguyễn Bích Lưu và các cộng sự (2011), "Kết quả khảo sát tổ chức chăm sóc và nhân lực điều dưỡng trong 1 ngày làm việc (3/2011) từ 30 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế", *Tài liệu tập huấn triển khai Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện*, Dự án tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám, chữa bệnh, tr. 52-58.
28. Dương Thị Bình Minh (2012), *Thực trạng công tác chăm sóc điều dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị năm 2012*, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
29. Trần Văn Minh và cộng sự (2010), *Đánh giá công tác chăm sóc điều dưỡng tại bệnh viện Vạn Ninh*, Khánh Hòa.
30. Phạm Đức Mục (2010), *Bộ tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện*, Hội điều dưỡng Việt Nam.
31. Phạm Đức Mục (2012), *Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên*, Hội

Điều dưỡng Việt Nam.

32. Bùi Thị Bích Ngà (2011), *Thực trạng công tác chăm sóc của điều dưỡng qua nhận xét của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương năm 2011*, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
33. Trần Thị Tuyết Nga (2010), "Khảo sát tâm lý bệnh nhân trước phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu", *Kỷ yếu nghiên cứu khoa học kỹ thuật Ngành Y tế Bến Tre lần thứ III*, Bến Tre, tr. 280-283.
34. Lê Thị Kim Nhung và cộng sự (2013), *Thực trạng bàn giao người bệnh trước phẫu thuật cấp cứu tại khoa Gây mê Hồi sức, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức*, Hà Nội.
35. Nguyễn Thị Hồng Nương (2012), "Hiệu quả các giải pháp nâng cao kỹ năng chăm sóc bằng thuốc của điều dưỡng bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 2012", *Kỷ yếu nghiên cứu khoa học năm 2012*, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, tr. 145-152.
36. Phòng Điều dưỡng (2013), *Bảng kiểm các quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên*, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre.
37. Nguyễn Trường Sơn (2007), "Tìm hiểu cảm xúc và nhu cầu chăm sóc về mặt tinh thần của người bệnh ở bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế", *Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội điều dưỡng Việt Nam*, Nhà xuất bản GTVT, Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội, tr. 208-216.
38. Nguyễn Thị Minh Tâm và các cộng sự. (2012), Thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án của điều dưỡng viên, hộ sinh viên tại các bệnh viện năm 2012, *Quản lý điều dưỡng về cải tiến và hướng dẫn ghi mẫu phiếu điều dưỡng ngày 16/3/2012 tại 3 đầu cầu bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Chợ Rẫy*, Bệnh viện Chợ Rẫy, tr. 1-15.
39. Võ Văn Tân (2010), Liên quan giữa kiến thức và hành vi của điều dưỡng về

kiểm soát nghiễm trùng bệnh viện, *Hội nghị Khoa học Công nghệ Quân dân y Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8*, Công ty in Trung Thành, Tiền Giang, tr. 67-75.

40. Cao Thị Thẩm (2007), "Đánh giá công tác an toàn trong y tế trước và sau tập huấn chăm sóc toàn diện tại bệnh viện Trung Ương Huế", *Chương trình đào tạo trong nước JICA- bệnh viện Chợ Rẫy 2008: Hội thảo an toàn người bệnh trong công tác chăm sóc*, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 1-6.
41. Huỳnh Thị Mỹ Thanh và các cộng sự (2012), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án của điều dưỡng tại Bệnh viện An Giang, *Quản lý điều dưỡng về cải tiến và hướng dẫn ghi mẫu phiếu điều dưỡng ngày 16/3/2012 tại 3 đầu cầu bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Chợ Rẫy*, Bệnh viện Chợ Rẫy, tr. 79-87.
42. Trần Thị Thảo (2013), *Đánh giá việc thực hiện mô hình chăm sóc người bệnh theo đội tại bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí năm 2013*, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
43. Uyên Thảo (2011), *Cải thiện công tác điều dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và sự hài lòng của người bệnh*, Trang tin điện tử Truyền Thông giáo dục sức khỏe, tại trang web www.t5g.org.vn/?u=dt&id=2409, truy cập ngày 16/04/2013.
44. Trần Thị Thuận (2007), "Chương I: Những vấn đề cơ bản của nghề nghiệp điều dưỡng. Bài 1. Lịch sử ngành điều dưỡng", *Điều dưỡng cơ bản I*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 9-16.
45. Trần Thị Thuận (2007), "Y đức và nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng", *Điều dưỡng cơ bản I*, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 18-25.
46. Vũ Văn Tiến (2013), *Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người điều dưỡng*, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, khoa Điều dưỡng, tại trang web http://dieuduong.dntu.edu.vn/index.php/vi/download/BAI-GIANG-DIEU-DUONG-CO-BAN-I/BG-VAI-TRO-CHUC-NANG-NHIEM-VU-NGUOI-DIEU-DUONG/, truy cập ngày 13/11/2013.
47. Trần Ngọc Trung (2012), *Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều*

dưỡng viên tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2012, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

48. Phạm Anh Tuấn (2011), *Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí năm 2011*, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
49. Bùi Ngọc Tuyền và Vương Nhật Lệ (2011), "Thời gian trung bình chăm sóc một bệnh nhân chăm sóc cấp 1 tại khoa Bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy", *Y Học TP. Hồ Chí Minh*, 15(4), tr. 362-365.

Tiếng Anh

50. M. Adib-Hajbaghery, A. Ansari & I. Azizi-Fini (2013), "Intensive care nurses' opinions and practice for oral care of mechanically ventilated patients", *Indian J Crit Care Med*, 17(1), pg. 23-27.
51. N. Aghakhani & et al (2012), "Nurses' attitude to patient education barriers in educational hospitals of Urmia University of Medical Sciences", *Iran J Nurs Midwifery Res*, 17(1), pg. 12-15.
52. K. Babaie (2006), "Promoting patient safety: one company's example", *Case Manager*, 17(6), pg. 54-59.
53. Pascale Carayon & Ayse P. Gurses (2008), "Chapter 30. Nursing Workload and Patient Safety—A Human Factors Engineering Perspective ", *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses: Vol. 2*, Agency for Healthcare Research and Quality, US, pg. 203-210.
54. M. Farquhar, B. A. Sharp & C. M. Clancy (2007), "Patient safety in nursing practice", *AORN J*, 86(3), pg. 455-457.
55. A. P. Gurses & P. Carayon (2007), "Performance obstacles of intensive care nurses", *Nurs Res*, 56(3), pg. 185-194.
56. A. P. Gurses, P. Carayon & M. Wall (2009), "Impact of performance obstacles on intensive care nurses' workload, perceived quality and safety of care, and quality of working life", *Health Serv Res*, 44(2 Pt 1), pg. 422-443.
57. Ronda G. Hughes (2008), "Chapter 2. Nurses at the "Sharp End" of Patient Care ", *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses:*

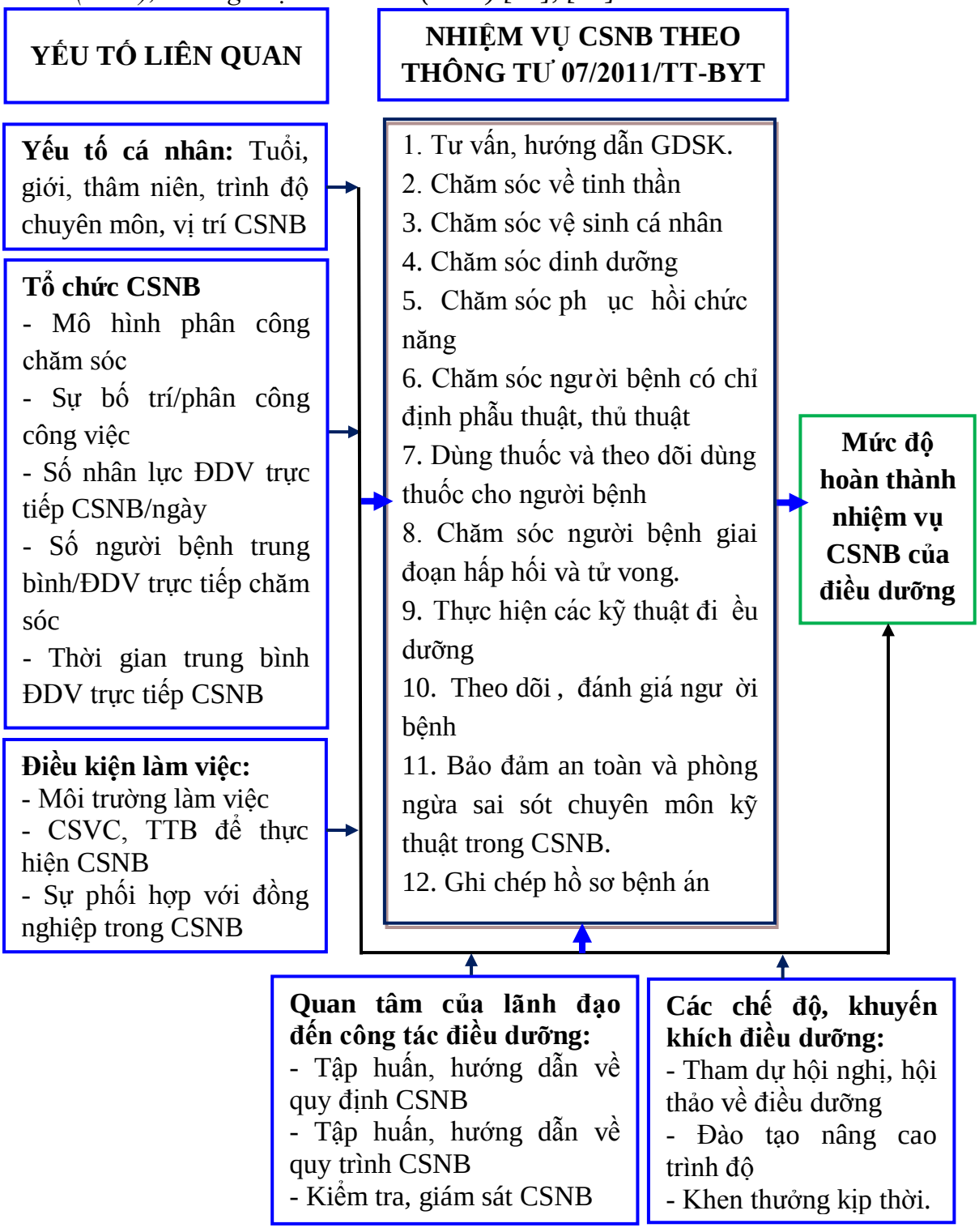
Vol. 1, Agency for Healthcare Research and Quality, US, pg. 7-25.

58. Institute of Medicine (2004), "Keeping patients safe: Transforming the work environment of nurses", *Qual Lett Healthc Lead*, 16(1), pg. 9-11.
59. Pamela H. Mitchell (2008), "Chapter 1. Defining Patient Safety and Quality Care", *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses: Vol. 1*, Agency for Healthcare Research and Quality US, pg. 1-4.
60. J. Needleman & et al (2002), "Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals", *N Engl J Med*, 346(22), pg. 1715-1722.
61. A. Ozdemir & et al (2008), "Gender and career: Female and male nursing students' perceptions of male nursing role in Turkey", *Health Science Journal® All Rights Reserved*, 2(3), pg. 153-161.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. KHUNG LÝ THUYẾT

Dựa theo chỉ số đánh giá Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về CSNB trong bệnh viện của Cục Quản lý khám, chữa bệnh [18]. Một số yếu tố liên quan được tham khảo từ khung lý thuyết của các tác giả Phạm Anh Tuấn (2011), Dương Thị Bình Minh (2012) [28], [48].



Phụ lục 2. CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH NGHĨA BIẾN

1. Các chỉ số thông tin chung của đối tượng nghiên cứu

TT	Tên biến số	Định nghĩa biến	Loại biến	Phương pháp thu thập
1	Tuổi	Là tuổi tính theo năm dương lịch (hiệu số của 2014 trừ đi năm sinh)	Rời rạc	Phát vấn
2	Giới	Nam/ Nữ	Phân loại	Phát vấn
3	Trình độ chuyên môn	Là bằng cấp chuyên môn cao nhất được căn cứ để xếp ngạch lương	Thứ bậc	Phát vấn
4	Thâm niên công tác	Là thời gian tính từ lúc bắt đầu làm việc chuyên môn cho đến nay	Liên tục	Phát vấn
5	Vị trí CSNB	Là vị trí ĐDV được phân công CSNB (Buồng bệnh thường/nặng hoặc đơn nguyên HSTC)	Phân loại	Phát vấn

2. Các chỉ số đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Định nghĩa biến		Loại biến	Phương pháp thu thập
A. Tư vấn, hướng dẫn GDSK			
A 1	ĐDV hướng dẫn người bệnh/NNNB nội quy, quy định và những điều cần thiết khi vào viện (viện phí,BHYT,…)	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
A 2	Phổ biến cho người bệnh/NNNB về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh khi nằm viện	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
A 3	ĐDV hướng dẫn người bệnh/NNNB cách tự theo dõi, chăm sóc trong quá trình điều trị	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
A 4	ĐDV hướng dẫn người bệnh/NNNB chế độ sinh hoạt trong điều trị và nằm viện	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
A 5	ĐDV hướng dẫn người bệnh/NNNB cách phòng bệnh khi ra viện	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
B. Chăm sóc về tinh thần			
B1	Giao tiếp với người bệnh/NNNB với thái độ ân cần và thông cảm	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp

Định nghĩa biến		Loại biến	Phương pháp thu thập
B2	Thể hiện lời nói, cử chỉ động viên, khuyến khích người bệnh an tâm điều trị	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
B3	Giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của người bệnh/NNNB trong quá trình điều trị	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
B4	Giữ yên tĩnh, trật tự trong buồng bệnh, tránh ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của người bệnh	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
C. Chăm sóc vệ sinh cá nhân			
C1	Thay quần áo, thay vải trải giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1.	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
C2	Vệ sinh răng miệng cho người bệnh chăm sóc cấp 1	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
C3	Tắm gội đầu cho người bệnh chăm sóc cấp 1	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
C4	Hỗ trợ người bệnh chăm sóc cấp 1 đại/tiểu tiện	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
C5	Hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh chăm sóc cấp 2, 3 trong những hoạt động vệ sinh cá nhân (thay quần áo, vệ sinh răng miệng, tắm gội,...)	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
D. Chăm sóc dinh dưỡng			
D1	Tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh về chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe và bệnh tật	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
D2	Theo dõi ghi k ết quả thực hiện chế độ ăn bệnh lý vào Phiếu chăm sóc (đối với người bệnh có chế độ ăn bệnh lý)	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
D3	Trực tiếp thực hiện cho người bệnh ăn qua ống thông (đối với người bệnh có chỉ định ăn qua ống thông)	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
E. Chăm sóc phục hồi chức năng			
E 1	Hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh tập luyện, phục hồi chức năng trong thời gian nằm viện	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
E 2	Hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh xoay trở hoặc vận động để phòng ngừa loét do tỳ đè	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp

Định nghĩa biến		Loại biến	Phương pháp thu thập
F. Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật			
F1	Hoàn thiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của phẫu thuật, thủ thuật	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
F2	Giúp đỡ, hỗ trợ người bệnh hoặc hướng dẫn NNNB chuẩn bị những điều cần thiết trước khi phẫu thuật	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
F3	Đánh giá lại DHST, tình trạng người bệnh và ghi nhận vào bảng kiểm trước khi chuyển người bệnh đến nơi phẫu thuật, thủ thuật	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
F4	Chuyển người bệnh đến nơi làm phẫu thuật, thủ thuật và bàn giao người bệnh, HSBA chu đáo	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
G. Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh			
G1	Chuẩn bị đủ và phù hợp các phương tiện cho người bệnh dùng thuốc	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
G2	Thực hiện kiểm tra thuốc, tên, tuổi người bệnh trước khi thực hiện y lệnh thuốc	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
G3	Thông báo rõ tên thuốc, số lượng thuốc, tác dụng của thuốc được sử dụng trong ngày cho người bệnh	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
G4	Phát thuốc đúng giờ, theo chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn người bệnh/NNNB cách sử dụng thuốc	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
G5	Cho người bệnh uống thuốc ngay tại giường có sự chứng kiến của ĐDV	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
G6	Theo dõi trong quá trình dùng thuốc cho người bệnh	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
G7	Ghi hoặc đánh dấu vào sổ, thuốc đã dùng cho người bệnh	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
G8	Thực hiện công khai thuốc cho người bệnh theo quy định của bệnh viện	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
H. Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối			
H1	Thông báo và giải thích với NNNB về tình trạng của người bệnh	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
H2	Tạo điều kiện để NNNB ở cạnh người bệnh	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp

Định nghĩa biến		Loại biến	Phương pháp thu thập
H3	Động viên, an ủi người bệnh và NNNB	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
I. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng			
I 1	Giải thích các can thiệp điều dưỡng cho người bệnh/NNNB hiểu và hợp tác trước khi thực hiện. (Thay băng, tiêm truyền, lấy máu xét nghiệm,…)	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
I 2	Tuân thủ các bước của quy trình điều dưỡng trong phạm vi chuyên môn	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
I 3	Thực hiện thành thạo kỹ thuật điều dưỡng	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
I 4	Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
K. Theo dõi, đánh giá người bệnh			
K1	Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tình trạng bệnh... của người bệnh	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
K2	Bàn giao tình trạng của người bệnh với ĐDV kế tiếp một cách cụ thể, đầy đủ và chính xác	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
L. Bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong CSNB			
L1	Vận chuyển người bệnh an toàn, phương tiện phù hợp và đặt người bệnh ở tư thế phù hợp	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
L2	Thực hiện biện pháp phòng ngừa người bệnh té ngã (Song chắn, dây cố định,…)	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
L3	Mang theo hộp thuốc chống sốc khi thực hiện tiêm, truyền cho người bệnh	Thứ bậc	Quan sát trực tiếp
M. Ghi chép hồ sơ bệnh án			
M1	Ghi các thông tin về người bệnh chính xác	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
M2	Thống nhất thông tin về công tác CSNB của ĐDV và của bác sĩ điều trị	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA
M3	Ghi đầy đủ, kịp thời diễn biến bệnh và các can thiệp điều dưỡng	Thứ bậc	Quan sát qua HSBA

3. Các chỉ số đánh giá về một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB của ĐDV

STT	Tên biến số	Định nghĩa biến	Loại biến	Phương pháp thu thập
N. Công tác tổ chức CSNB				
N1	Mô hình phân công chăm sóc	Là mô hình chăm sóc hiện đang áp dụng tại khoa: điều dưỡng chăm sóc chính/ chăm sóc theo nhóm/chăm sóc theo đội/chăm sóc theo công việc	Phân loại	Phát vấn
N2	Sự bố trí/phân công công việc	Là sự bố trí nhân lực ĐDV tại các vị trí CSNB phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn	Thứ bậc	Phát vấn
N3	Số nhân lực ĐDV trực tiếp CSNB	Là số ĐDV được phân công trực tiếp CSNB tại các khoa trong ngày làm việc	Rời rạc	SLTC
N4	Số người bệnh /ĐDV trực tiếp chăm sóc	Là số người bệnh trung bình được ĐDV trực tiếp chăm sóc tại các khoa trong ngày	Liên tục	Quan sát Phát vấn
N5	Số lượng thời gian ĐDV trực tiếp CSNB	Là số giờ ĐDV trực tiếp CSNB tại các khoa vào buổi sáng và buổi chiều/ngày	Liên tục	Quan sát Phát vấn
O. Điều kiện làm việc				
O1	Môi trường làm việc	Là môi trường làm việc tại khoa đảm bảo thoải mái, thông thoáng và sạch	Thứ bậc	Phát vấn
O2	Cơ sở vật chất phục vụ CSNB	Là tình trạng cơ sở vất chất tại khoa đảm bảo đáp ứng tốt công tác CSNB	Thứ bậc	Phát vấn
O3	Trang thiết bị cho công tác CSNB	Là tình trạng trang thiết bị tại khoa đảm bảo đáp ứng tốt cho công tác CSNB	Thứ bậc	Phát vấn

STT	Tên biến số	Định nghĩa biến	Loại biến	Phương pháp thu thập
O4	Sự phối hợp với đồng nghiệp trong CSNB	Là sự phối hợp giữa các ĐDV và giữa ĐDV với bác sĩ trong CSNB	Thứ bậc	Phát vấn
P. Sự quan tâm của lãnh đạo đến công tác điều dưỡng				
P1	Tập huấn các quy định về CSNB	Bệnh viện tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho ĐDV thực hiện các quy định về CSNB	Thứ bậc	Phát vấn
P2	Đào tạo lại quy trình kỹ thuật CSNB	Bệnh viện tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn cho ĐDV về các quy trình trong CSNB	Thứ bậc	Phát vấn
P3	Kiểm tra, giám sát công tác CSNB	Lãnh đạo bệnh viện/khoa thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá công tác CSNB của ĐDV	Thứ bậc	Phát vấn
Q. Các chế độ, chính sách khuyến khích điều dưỡng				
Q1	Tạo điều kiện tham dự hội nghị, hội thảo về điều dưỡng	Lãnh đạo bệnh viện/khoa tạo điều kiện để ĐDV có cơ hội tham gia Hội thảo, Hội nghị về điều dưỡng tại bệnh viện và các đơn vị bạn	Thứ bậc	Phát vấn
Q2	Đào tạo nâng cao trình độ	Lãnh đạo bệnh viện/lãnh đạo khoa tạo điều kiện cho ĐDV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn	Thứ bậc	Phát vấn
Q3	Khen thưởng	Bệnh viện có chế độ khen thưởng khi ĐDV thực hiện tốt nhiệm vụ CSNB	Thứ bậc	Phát vấn

Phụ lục 3. BẢNG KIỂM QUAN SÁT TRỰC TIẾP ĐIỀU DƯỠNG VIÊN THỰC HIỆN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG

– Họ tên điều dưỡng viên được quan sát:.....khoa:.....

– Số người bệnh mà ĐDV đang được quan sát phụ trách:.....người

– Thời gian quan sát: Bắt đầu:.....giờ.....; kết thúc:.....giờ.....

Bắt đầu:.....giờ.....;kết thúc:.....giờ.....

– Thời gian ĐDV CSNB Sáng: bắt đầu:....giờ.....; kết thúc chăm sóc:.....giờ.....

Chiều: bắt đầu:....giờ.....; kết thúc chăm sóc:.....giờ.....

	Nội dung	Mức độ đạt Lần 1					Mức độ đạt Lần 2					Mức độ đạt Lần 3				
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5
A. Tư vấn, hướng dẫn GDSK																
A1	ĐDV hướng dẫn người bệnh nội quy, quy định và những điều cần thiết khi vào viện: viện phí, BHYT	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A2	Phổ biến cho người bệnh/NNNB về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh khi nằm viện	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A3	ĐDV giải thích cho người bệnh về tác dụng, hướng dẫn cách dùng thuốc	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A4	ĐDV hướng dẫn người bệnh chế độ sinh hoạt trong điều trị và nằm viện	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A5	ĐDV hướng dẫn người bệnh cách phòng bệnh khi ra viện.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
B. Chăm sóc về tinh thần																
B1	Giao tiếp với người bệnh/NNNB với thái độ ân cần và thông cảm.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
B2	Thể hiện lời nói, cử chỉ động viên, khuyến khích người bệnh an tâm điều trị	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

	Nội dung	Mức độ đạt Lần 1					Mức độ đạt Lần 2					Mức độ đạt Lần 3				
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5
B3	Giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của người bệnh/NNNB trong quá trình điều trị.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
B4	Giữ yên tĩnh buồng bệnh, tránh ảnh hưởng đến tinh thần của người bệnh	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
C. Chăm sóc vệ sinh cá nhân																
C1	Thay quần áo, thay vải trải giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
C2	Vệ sinh răng miệng cho người bệnh chăm sóc cấp 1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
C3	Tắm gội đầu cho người bệnh chăm sóc cấp 1	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
C4	Hỗ trợ người bệnh chăm sóc cấp 1 đại/tiểu tiện	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
C5	Hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh chăm sóc cấp 2, 3 trong những hoạt động vệ sinh	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
D. Chăm sóc dinh dưỡng																
D3	Trực tiếp cho người bệnh ăn qua sonde dạ dày	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
E. Chăm sóc phục hồi chức năng																
E1	Hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh tập luyện, phục hồi chức năng trong thời gian nằm viện.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
E2	Hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh xoay trở, vận động phòng ngừa loét do tỳ đè.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
G. Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho NB																
G1	Chuẩn bị đủ và phù hợp các phương tiện cho người bệnh dùng thuốc.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
G2	Kiểm tra thuốc, tên, tuổi người bệnh, giải thích trước khi thực hiện y lệnh thuốc.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

	Nội dung	Mức độ đạt Lần 1					Mức độ đạt Lần 2					Mức độ đạt Lần 3				
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5
G3	Thông báo rõ tên thuốc, số lượng thuốc, tác dụng của thuốc được sử dụng trong ngày cho người bệnh.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
G4	Phát thuốc đúng giờ, theo chỉ định của bác sĩ, hướng dẫn người bệnh/NNNB cách sử dụng thuốc	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
G5	Cho người bệnh uống thuốc ngay tại giường có sự chứng kiến của ĐDV	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
G6	Theo dõi quá trình dùng thuốc cho người bệnh	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
G7	Ghi hoặc đánh dấu vào sổ, thuốc đã dùng	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
G8	Thực hiện công khai thuốc cho người bệnh theo quy định bệnh viện	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
H. Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối																
H1	Thông báo và giải thích với NNNB về tình trạng của người bệnh	1	2	3	**4**	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
H2	Tạo điều kiện để NNNB ở cạnh người bệnh	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
H3	Động viên, an ủi NNNB	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng																
I1	Giải thích các can thiệp điều dưỡng cho người bệnh, NNNB hiểu và hợp tác trước khi thực hiện	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I2	Tuân thủ các bước quy trình kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I3	Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I4	Thực hiện thành thạo kỹ thuật điều dưỡng	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

	Nội dung	Mức độ đạt Lần 1					Mức độ đạt Lần 2					Mức độ đạt Lần 3				
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5
L. Bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong CSNB																
L1	Vận chuyển người bệnh an toàn, phương tiện phù hợp, tư thế phù hợp	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
L2	Thực hiện biện pháp phòng ngừa người bệnh té ngã (song chắn, dây cố định,…)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
L3	Mang hộp thuốc chống sốc khi thực hiện tiêm, truyền cho người bệnh	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

*Điều tra viên đánh dấu "**X**" tương ưng đối với từng tiêu chí ĐDV thực hiện.*

Ghi chú về "Mức độ đạt":

- ***Mức 1** (M1): Không làm (không có bằng chứng thực hiện)*
- ***Mức 2** (M2): Có làm một phần (chỉ làm cho xong việc).*
- ***Mức 3** (M3): Có làm đạt trung bình (thực hiện chưa đầy đủ)*
- ***Mức 4** (M4): Có làm đạt tốt (thực hiện đầy đủ)*
- ***Mức 5** (M5): Có làm rất tốt (thực hiện đầy đủ và thường xuyên).*

*Điều tra viên xem kỹ "Bảng hướng dẫn tiêu chí đánh giá các "**Mức độ đạt**" qua quan sát trực tiếp ĐDV thực hiện CSNB" và các bảng kiểm kỹ thuật chuyên môn, để có sự đánh giá chính xác.*

Điều tra viên

Phụ lục 4. HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC "MỨC ĐỘ ĐẠT" QUA QUAN SÁT TRỰC TIẾP ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Quan sát viên (QSV) dựa vào bảng hướng dẫn này để lựa chọn "Mức độ đạt" khi quan sát trực tiếp ĐDV thực hiện CSNB. QSV phải quan sát xuyên suốt mới có thể đưa ra đánh giá "Mức độ đạt" một cách chính xác. Có một vài nhiệm vụ QSV phải dựa vào các bảng kiểm kỹ thuật chuyên môn (phụ lục 7) mới đưa ra đánh giá "Mức độ đạt" cho từng tiểu mục của nhiệm vụ đó.

TT	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
A. Tư vấn, hướng dẫn GDSK: *Người bệnh mới vào viện được hướng dẫn về nội quy, quy định của bệnh viện, các chế độ BHYT, chi phí điều trị. Hướng dẫn chế độ sinh hoạt, tự chăm sóc, cách dùng thuốc trong thời gian nằm viện và khi ra viện.*		
A1	ĐDV hướng dẫn người bệnh nội quy, quy định và những điều cần thiết khi vào viện (viện phí,BHYT,…)	**M1**: không thực hiện **M2**: chưa tự giác thực hiện *(khi người bệnh hỏi mới thực hiện)* **M3**: tự giác thực hiện nhưng chưa đầy đủ *(chỉ làm một phần đối với nhiệm vụ đó)* **M4**: thực hiện đầy đủ **M5**: như M4 và thường xuyên đối với tất cả người bệnh đang trực tiếp phụ trách
A2	Phổ biến cho người bệnh/NNNB về quyền lợi và nghĩa vụ khi nằm viện	
A3	ĐDV giải thích cho người bệnh/NNNB về tác dụng, hướng dẫn cách dùng thuốc trong điều trị	
A4	ĐDV hướng dẫn người bệnh/NNNB chế độ sinh hoạt trong điều trị và nằm viện	
A5	ĐDV hướng dẫn người bệnh/NNNB cách phòng bệnh khi ra viện.	
B. Chăm sóc về tinh thần: *ĐDV giao tiếp với người bệnh/NNNB ân cần, quan tâm. Khi người bệnh/NNNB có thắc mắc thì giải đáp kịp thời, hoặc hướng dẫn chu đáo, không đùn đẩy gây phiền hà. ĐDV luôn giữ trật tự ngăn nắp buồng bệnh do mình phụ trách, hướng dẫn người bệnh/NNNB giữ trật tự, hạn chế thăm nuôi trong giờ hành chính.*		
B1	Giao tiếp với người bệnh/NNNB với thái độ ân cần và thông cảm.	**M1**: Cáu gắt, khó chịu khi giao tiếp với người bệnh/NNNB **M2**: thái độ thiếu quan tâm *(khi người bệnh hỏi mới thực hiện)* **M3**: thực hiện nhưng chưa đầy đủ *(chỉ làm một phần)* **M4**: thực hiện đầy đủ **M5**: như M4 và thường xuyên
B2	Thể hiện lời nói, cử chỉ động viên, khuyến khích người bệnh/NNNB an tâm điều trị	
B3	Giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của người bệnh/NNNB trong quá trình điều trị.	

TT	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
B4	Giữ yên tĩnh buồng bệnh, tránh ảnh hưởng đến tinh thần của người bệnh	
C. Chăm sóc vệ sinh cá nhân: *Đối với người bệnh chăm sóc cấp I : ĐDV trực tiếp thực hiện thay quần áo, thay vải trải giường, vệ sinh răng miệng, gội tóc và hỗ trợ người bệnh khi đại tiểu tiện. Người bệnh chăm sóc cấp 2, 3 : ĐDV hướng dẫn người bệnh/NNNB thực hiện*		
C1	Thay quần áo, thay vải trải giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1	**M1**: không thực hiện **M2**: chỉ hướng dẫn **M3**: hướng dẫn, hỗ trợ nhưng chưa thường xuyên **M4**: trực tiếp thực hiện **M5**: như M4 và thường xuyên
C2	Vệ sinh răng miệng cho người bệnh chăm sóc cấp 1	
C3	Tắm gội đầu cho người bệnh chăm sóc cấp 1	
C4	Hỗ trợ người bệnh chăm sóc cấp 1 đại/tiểu tiện	
C5	Hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh chăm sóc cấp 2, 3 trong những hoạt động vệ sinh cá nhân (Thay quần áo, vệ sinh răng miệng, tắm gội,...)	**M1**: không thực hiện **M2**: chưa tự giác thực hiện **M3**: tự giác thực hiện nhưng chưa đầy đủ **M4** : thực hiện đầy đủ **M5**: như M4 và thường xuyên
D. Chăm sóc dinh dưỡng *Người bệnh nuôi ăn qua sonde dạ dày phải do ĐDV trực tiếp cho ăn, không giao cho NNNB và theo dõi tình trạng sonde mỗi ngày (sonde không bị đục, đóng cặn, tụt,…)*		
D3	ĐDV trực tiếp thực hiện cho người bệnh ăn qua sonde dạ dày	**M1**: giao phó cho NNNB **M2**: hướng dẫn NNNB làm **M3**: trực tiếp thực hiện, nhưng chưa đúng kỹ thuật/thiếu theo dõi tình trạng sonde **M4**: thực hiện đầy đủ **M5**: như M4 và thường xuyên
E. Chăm sóc phục hồi chức năng *Đối với người bệnh hạn chế vận động ĐDV phải hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh/NNNB tập luyện, xoay trở, vận động.*		
E1	Hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh tập luyện, phục hồi chức năng trong thời gian nằm viện.	**M1**: không hướng dẫn **M2**: chỉ thực hiện khi được hỏi **M3**: tự giác thực hiện nhưng chưa đầy đủ **M4**: thực hiện đầy đủ **M5**: như M4 và thường xuyên
E2	Hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh xoay trở hoặc vận động phòng ngừa loét do tỳ đè.	

TT	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
G. Dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho ngư ời bệnh		
G1	Chuẩn bị đủ và phù hợp các phương tiện cho người bệnh dùng thuốc. *(Chuẩn bị hộp chống sốc trước khi thực hiện tiêm thuốc cho người bệnh, chuẩn bị mâm tiêm/xe tiêm đúng quy định)*	**M1**: không chuẩn bị **M2**: chuẩn bị chưa đủ **M3**: chuẩn bị đủ **M4**: chuẩn bị đủ, phù hợp **M5**: như M4 và thường xuyên
G2	Thực hiện kiểm tra thuốc, tên, tuổi người bệnh, giải thích trước khi thực hiện y lệnh thuốc. • *ĐDV thực hiện 5 đúng khi dùng thuốc cho người bệnh.* • *Giải thích với người bệnh hoặc NNNB trước khi thực hiện.*	**M1**: không kiểm tra **M2**: kiểm tra chưa đầy đủ **M3**: kiểm tra đủ, thiếu giải thích trước khi thực hiện **M4**: thực hiện đầy đủ **M5**: như M4 và thường xuyên
G3	Thông báo rõ tên thuốc, số lượng thuốc, tác dụng của thuốc được sử dụng trong ngày cho người bệnh.	**M1**: không thực hiện **M2**: thực hiện chưa tự giác **M3**: tự giác thực hiện nhưng chưa đầy đủ **M4**: thực hiện đầy đủ **M5**: như M4 và thường xuyên
G4	Phát thuốc đúng giờ, theo chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn người bệnh/NNNB cách sử dụng thuốc	**M1**: phát thuốc không đúng giờ **M2**: phát thuốc cả ngày **M3**: phát thuốc đúng giờ nhưng không hướng dẫn **M4**: phát thuốc đúng giờ, hướng dẫn **M5**: như M4 và thường xuyên
G5	Cho người bệnh uống thuốc ngay tại giường có sự chứng kiến của ĐDV	**M1**: phát thuốc cả ngày, **M2**: phát thuốc cả ngày, có hướng dẫn **M3**: phát thuốc đúng giờ, để người bệnh tự uống. **M4**: phát thuốc đúng giờ và chờ người bệnh uống **M5**: như M4 và thường xuyên

TT	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
G6	Theo dõi trong quá trình dùng thu ốc cho người bệnh *(Có hỏi thăm về tiến triển của bệnh khi tiếp xúc để cho người bệnh dùng thuốc, hoặc dặn dò người bệnh một số dấu hiệu cần chú ý để báo ngay với bác sĩ/ĐDV)*	**M1**: không bằng chứng thực hiện **M2**: chưa tự giác thực hiện **M3**: tự giác thực hiện, thái độ chưa tốt. **M4**: thực hiện với thái độ ân cần. **M5**: như M4 và thường xuyên
G7	Ghi hoặc đánh dấu vào sổ, thuốc đã dùng cho người bệnh *Sau khi cho người bệnh dùng thuốc ĐDV phải đánh dấu thuốc đã dùng vào sổ thực hiện thuốc (cả thuốc tiêm truyền và thuốc uống).*	**M1**: không thực hiện **M2**: chỉ ghi, không đánh dấu sau khi đã thực hiện thuốc **M3**: chỉ ghi và đánh dấu đối với thuốc tiêm **M4**: thực hiện đầy đủ **M5**: như M4 và thường xuyên
G8	Thực hiện công khai thuốc cho người bệnh theo quy định của bệnh viện. *ĐDV phải ghi phiếu công khai thuốc và cho người bệnh/NNNB ký tên mỗi ngày.*	**M1**: không thực hiện **M2**: ghi phiếu công khai thuốc, không cho người bệnh ký tên xác nhận **M3**: cho người bệnh ký tên xác nhận, không thực hiện mỗi ngày **M4**: thực hiện đầy đủ mỗi ngày **M5**: như M4 và có giải thích
H. Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối: *Đối với người bệnh nặng, hấp hối hoặc tử vong, ĐDV phải thông báo, giải thích tình trạng của người bệnh, trấn an NNNB và giúp đỡ NNNB thực hiện các thủ tục cần thiết. Nếu người bệnh tử vong thì phải thực hiện chăm sóc tử thi và hỗ trợ NNNB đưa tử thi ra xe.*		
H1	Thông báo và giải thích với NNNB về tình trạng của người bệnh	**M1**: không thực hiện **M2**: thực hiện chưa đầy đủ **M3**: thực hiện đầy đủ **M4**: thực hiện đầy đủ, thái độ thông cảm. **M5**: như M4 và rất tốt
H2	Tạo điều kiện để NNNB ở cạnh người bệnh.	
H3	Động viên, an ủi người bệnh và NNNB	

TT	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
I. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng		
I1	Giải thích các can thiệp điều dưỡng cho người bệnh, NNNB hiểu và hợp tác trước khi thực hiện. *(Thay băng, tiêm truyền, lấy máu xét nghiệm,...)*	**M1**: không giải thích **M2**: chưa tự giác thực hiện **M3**: thực hiện, thái độ chưa tốt **M4**: thực hiện tốt, ân cần **M5**: như M4 và thường xuyên
I2	Tuân thủ các bước của quy trình kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn. *(Quan sát từ 2 đến 3 quy trình kỹ thuật mà ĐDV thực hiện)*	**M1**: không tuân thủ **M2**: thực hiện chưa đủ bước **M3**: thực hiện đầy đủ **M4**: thực hiện đầy đủ, phù hợp **M5**: như M4 và thường xuyên
I3	Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn *(Quan sát từ 2 đến 3 quy trình kỹ thuật mà ĐDV thực hiện, bao gồm việc rửa tay, phân loại rác y tế)*	
I4	Thực hiện thành thạo kỹ thuật điều dưỡng *(Quan sát từ 2 đến 3 quy trình kỹ thuật bất kỳ mà ĐDV thực hiện)*	**M1**: không đúng kỹ thuật **M2**: thực hiện chưa đủ bước **M3**: thực hiện đầy đủ **M4**: thực hiện đủ, thành thạo **M5**: như M4 và thường xuyên
L. Bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót chuyên môn kỹ thuật trong CSNB		
L1	Vận chuyển người bệnh an toàn, phương tiện phù hợp và đặt người bệnh ở tư thế phù hợp khi vận chuyển.	**M1**: không thực hiện **M2**: thực hiện một phần **M3**: thực hiện đủ, chưa an toàn **M4**: thực hiện đủ, an toàn **M5**: như M4 và thường xuyên
L2	Thực hiện biện pháp phòng ngừa người bệnh té ngã (song chắn, dây cố định,…)	
L3	Mang theo hộp thuốc chống sốc khi thực hiện tiêm, truyền cho người bệnh	**M1**: không thực hiện **M2**: thực hiện, thiếu cơ số trong hộp chống sốc **M3**: thực hiện đầy đủ **M4**: thực hiện đầy đủ, phù hợp **M5**: như M4 và thường xuyên

Ghi chú: - Mức 1 (M1) = 0 điểm - Mức 4 (M4) = 3 điểm
- Mức 2 (M2) = 1 điểm - Mức 5 (M5) = 4 điểm
- Mức 3 (M3) = 2 điểm

Phụ lục 5. BẢNG KIỂM QUAN SÁT GIÁN TIẾP ĐIỀU DƯỠNG VIÊN THỰC HIỆN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH QUA HỒ SƠ BỆNH ÁN

Điều tra viên (ĐTV) dựa vào "Bảng hướng dẫn tiêu chí đánh giá các mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ĐDV qua quan sát hồ sơ bệnh án", để lựa chọn "Mức độ đạt" ở các nhiệm vụ sau đây. ĐTV đánh dấu "X" vào các mức độ phù hợp theo hướng dẫn của bảng kiểm.

Tên điều dưỡng viên:……..**Khoa**:…….

	Nội dung	**Mức độ đạt HSBA 1:……**					**Mức độ đạt HSBA 2:…….**					**Mức độ đạt HSBA 3:…….**				
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5
D. Chăm sóc dinh dưỡng																
D1	Tư vấn, giải thích cho người bệnh về ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe và bệnh tật.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
D2	Theo dõi ghi kết quả thực hiện chế độ ăn bệnh lý vào Phiếu chăm sóc	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
F. Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật																
F1	Hoàn thiện thủ tục hành chính, kiểm tra lại công tác chuẩn bị người bệnh đảm bảo đã được thực hiện theo yêu cầu của phẫu thuật, thủ thuật.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
F2	Giúp đỡ, hỗ trợ người bệnh hoặc hướng dẫn NNNB chuẩn bị những điều cần thiết trước khi phẫu thuật	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
F3	Đánh giá DHST , tình trạng người bệnh và báo cáo cho bác sĩ nếu người bệnh có diễn biến bất thường.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
F4	Chuyển người bệnh đến nơi làm phẫu thuật, thủ thuật và bàn giao người bệnh, HSBA chu đáo.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

	Nội dung	Mức độ đạt HSBA 1:……					Mức độ đạt HSBA 2:…….					Mức độ đạt HSBA 3:…….				
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5
K. Theo dõi, đánh giá người bệnh																
K1	Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tình trạng bệnh... của người bệnh	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
K2	Bàn giao tình trạng của người bệnh với nhóm chăm sóc kế tiếp một cách cụ thể, đầy đủ và chính xác.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
M. Ghi chép hồ sơ bệnh án																
M1	Ghi các thông tin về người bệnh chính xác	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
M2	Thống nhất thông tin về công tác CSNB giữa ĐDV và bác sĩ điều trị	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
M3	Ghi đầy đủ, kịp thời diễn biến bệnh và các can thiệp điều dưỡng.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Điều tra viên

Phụ lục 6. BẢNG HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC "MỨC ĐỘ ĐẠT" VIỆC THỰC HIỆN CSNB CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN QUA HSBA

TT	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
D. Chăm sóc dinh dưỡng: *HSBA cần được ghi rõ về việc hướng dẫn người bệnh chế độ ăn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, nếu người bệnh có chỉ định ăn qua sonde dạ dày cần ghi thời gian cho ăn, số lượng, tình trạng dịch tiêu hóa trước khi cho ăn, tình trạng người bệnh trong lúc ăn và sau khi ăn.*		
D1	Tư vấn, giải thích cho người bệnh về ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe và bệnh tật. *(ĐDV ghi nhận trong HSBA về : tình trạng dinh dưỡng, hướng dẫn người bệnh chế độ ăn: cơm, cháo, súp, sữa,…)*	**M1**: không ghi nhận **M2**: có ghi một phần **M3**: ghi đầy đủ, có vài ý chưa trùng khớp với bác sĩ điều trị **M4**: ghi đầy đủ và trùng khớp với bác sĩ điều trị **M5**: như M4 và chữ viết rõ ràng
D2	Theo dõi ghi k ết quả thực hiện chế độ ăn bệnh lý vào Phiếu chăm sóc *(ĐDV có hướng dẫn và ghi rõ chế độ ăn vào phiếu chăm sóc. Người bệnh không có chỉ định ăn bệnh lý thì ĐDV vẫn ghi rõ chế độ ăn hàng ngày vào phiếu chăm sóc)*	**M1**: không thực hiện **M2**: có ghi, không thực hiện **M3**: thực hiện, không ghi **M4**: thực hiện và ghi đầy đủ **M5**:như M4 và chữ viết rõ ràng
F. Chăm sóc người bệnh có chỉ định phẫu thuật, thủ thuật: *ĐDV thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo qui định, các xét nghiệm, cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Hướng dẫn người bệnh/NNNB các chuẩn bị theo yêu cầu của cuộc phẫu thuật/thủ thuật*		
F1	Hoàn thiện thủ tục hành chính và kiểm tra lại công tác chuẩn bị ngư ời bệnh đảm bảo đã được thực hiện theo yêu cầu của phẫu thuật, thủ thuật. *(ghi nhận việc thực hiện y lệnh của bác sĩ và các thủ tục cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật)*	**M1**: không ghi nhận **M2**: có ghi một phần **M3**: ghi đầy đủ, có vài ý chưa trùng khớp với bác sĩ điều trị **M4**: ghi đầy đủ và trùng khớp với bác sĩ điều trị **M5**: như M4 và chữ viết rõ ràng
F2	Giúp đỡ, hỗ trợ người bệnh hoặc hướng dẫn NNNB chuẩn bị những điều cần thiết trước khi phẫu thuật *(Hướng dẫn về chế độ ăn, uống, vệ sinh,…)*	**M1**: không ghi nhận **M2**: có ghi một phần **M3**: ghi đầy đủ, có vài ý chưa trùng khớp với bác sĩ điều trị **M4**: ghi đầy đủ và trùng khớp **M5**: như M4 và chữ viết rõ ràng

TT	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
F3	Đánh giá lại DHST , tình trạng ngư ời bệnh và báo cáo lại cho bác sĩ điều trị nếu người bệnh có diễn biến bất thường. *(ĐDV đo lại dấu hiệu sinh tồn của người bệnh và ghi vào HSBA, kém theo bảng kiểm chuẩn bị người bệnh, trước khi chuyển làm thủ thuật hoặc phẫu thuật)*	**M1**: không ghi nhận **M2** : có ghi một phần **M3** : ghi đầy đủ trong HSBA nhưng thiếu bảng kiểm **M4** : ghi đầy đủ và có bảng kiểm kèm theo **M5**: như M4 và chữ viết rõ ràng
F4	Chuyển người bệnh đến nơi làm phẫu thuật, thủ thuật và bàn giao người bệnh, HSBA chu đáo. *(Ghi nhận các thủ tục cần phải bàn giao cho nơi tiến hành phẫu thuật/thủ thuật)*	**M1** : không ghi nhận **M2** : có ghi một phần **M3** : ghi đầy đủ, thiếu ký giao **M4** : ghi và ký bàn giao đầy đủ **M5**: như M4 và chữ viết rõ ràng
K. Theo dõi, đánh giá người bệnh : *ĐDV phải ghi nhận dấu sinh hiệu và tình trạng người bệnh mỗi ngày, diễn tiến bệnh, việc bàn giao với ĐDV chăm sóc kế tiếp bao gồm cả chế độ chăm sóc.*		
K1	Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, tình trạng bệnh... của người bệnh	**M1**: không ghi nhận **M2**: ghi thiếu thông tin **M3**: ghi thông tin đầy đủ, một vài thông tin thiếu chính xác **M4**: ghi chính xác, đầy đủ **M5**:như M4 và chữ viết rõ ràng
K2	Bàn giao tình trạng của người bệnh với nhóm chăm sóc kế tiếp một cách cụ thể, đầy đủ và chính xác.	**M1**: không ghi nhận **M2**: ghi thiếu thông tin **M3**: ghi thông tin đầy đủ, một vài thông tin thiếu chính xác **M4**: ghi chính xác, đầy đủ **M5**:như M4 và chữ viết rõ ràng
M. Ghi chép hồ sơ bệnh án		
M1	Ghi các thông tin về người bệnh chính xác *(HSBA có ghi đủ các thông tin về người bệnh, chính xác, ghi đúng cột mục, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp)*	**M1**: thiếu chính xác, thiếu thông tin **M2**: chính xác, thiếu thông tin **M3**: ghi thông tin đầy đủ, một vài thông tin thiếu chính xác **M4**: ghi chính xác, đầy đủ **M5**:như M4 và chữ viết rõ ràng

TT	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
M2	Thống nhất thông tin về công tác CSNB của ĐDV và của bác sĩ điều trị *(Các thông tin về chỉ số sinh tồn, tình trạng người bệnh, các diễn biến của người bệnh phải trùng khớp với thông tin trên tờ điều trị của bác sĩ)*	**M1**: thiếu chính xác, thiếu thông tin **M2**: ghi chính xác, nhưng thiếu thông tin **M3**: ghi đủ thông tin, một vài thông tin chưa trùng khớp với thông tin của bác sĩ điều trị **M4**: ghi trùng khớp, đầy đủ **M5**:như M4 và chữ viết rõ ràng
M3	Ghi đầy đủ, kịp thời diễn biến bệnh và các can thiệp điều dưỡng. *(Ghi đủ thông tin về các kỹ thuật đã thực hiện trên người bệnh, các diễn biến bệnh được ghi chép kịp thời ngay sau khi thực hiện CSNB, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp)*	**M1**: không ghi **M2**: ghi chưa đầy đủ **M3**: ghi đầy đủ, chưa kịp thời (làm việc khác rồi mới ghi) **M4**: ghi đầy đủ, kịp thời **M5**:như M4 và chữ viết rõ ràng

Ghi chú:

- Mức 1 (M1) = 0 điểm
- Mức 2 (M2) = 1 điểm
- Mức 3 (M3) = 2 điểm
- Mức 4 (M4) = 3 điểm
- Mức 5 (M5) = 4 điểm

Phụ lục 7. PHIẾU TỰ ĐIỀN THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG

Với mục đích tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên tại các khoa lâm sàng, để có cơ sở đề xuất các khuyến nghị nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Xin Anh/Chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau, chúng tôi xin đảm bảo rằng các thông tin do Anh/Chị cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Anh/chị đồng ý tham gia vào nghiên cứu này chứ?

Đồng ý ☐, Ký tên:……..

Từ chối ☐, xin cảm ơn.

I. Thông tin chung

1. Họ và tên: .....2. Tuổi: .....3. Giới: .....

4. Khoa:.....5. Trình độ chuyên môn (trung học/cao đẳng/đại học):……..

6. Số năm làm việc tại bệnh viện: ..... năm

7. Vị trí được phân công CSNB:

- Buồng bệnh thường □
- Buồng bệnh nặng □
- Đơn nguyên HSTC □

8. Số người bệnh được phân công chăm sóc: Ban ngày/ca trực:……người

9. Thời gian trung bình trực tiếp CSNB trong 1 buổi làm việc: Sáng…….....giờ

Chiều:……giờ

10. Mô hình phân công chăm sóc của khoa là: *(chọn một mô hình thích hợp)*

- Mô hình điều dưỡng chăm sóc chính □
- Mô hình chăm sóc theo nhóm □
- Mô hình chăm sóc theo đội □
- Mô hình chăm sóc theo công việc □

II. Thông tin về một số yếu tố liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CSNB

Xin anh/chị hãy đánh giá các yếu tố dưới đây theo mức độ từ 1→5, bằng cách khoanh tròn hoặc đánh dấu "X" vào một chữ số mà anh/chị chọn tương ứng với mỗi nội dung, trong đó:

- 1: Rất không phù hợp/Rất không tốt/Rất không quan tâm
- 2: Không phù hợp/Không tốt/Không quan tâm
- 3: Bình thường
- 4: Phù hợp/Tốt/Quan tâm
- 5: Rất phù hợp/Rất tốt/Rất quan tâm

STT	Nội dung	Các mức độ				
O	**Yếu tố công tác tổ chức CSNB**	**← Rất không phù hợp--------Rất phù hợp →**				
O 1	Điều dưỡng trưởng khoa bố trí/phân công công việc phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của anh/chị ?	1	2	3	4	5
P	**Yếu tố điều kiện làm việc**	**← Rất không tốt----------Rất tốt--- →**				
P1	Môi trường làm việc tại khoa của anh/chị thoải mái, thông thoáng và sạch?	1	2	3	4	5
P2	Cơ sở vật chất tại khoa của anh/chị có đáp ứng cho công tác CSNB?	1	2	3	4	5
P3	Trang thiết bị tại khoa của anh/chị có đáp ứng đủ cho công tác CSNB?	1	2	3	4	5
P4	Sự phối hợp giữa anh/chị với đồng nghiệp trong công tác CSNB?	1	2	3	4	5
Q	**Sự quan tâm của lãnh đạo đến công tác điều dưỡng**	**← Rất không quan tâm--------Rất quan tâm →**				
Q1	Bệnh viện có quan tâm đến việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho anh/chị thực hiện các quy định về CSNB?	1	2	3	4	5

STT	Nội dung	Các mức độ				
Q2	Bệnh viện có quan tâm tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn tại bệnh viện và tại khoa về các quy trình trong CSNB?	1	2	3	4	5
Q3	Lãnh đạo bệnh viện/khoa có quan tâm kiểm tra đánh giá công việc CSNB của anh/chị?	1	2	3	4	5
R	**Các chế độ, chính sách khuyến khích điều dưỡng**	**← Rất không quan tâm--------Rất quan tâm →**				
R1	Lãnh đạo bệnh viện/khoa có quan tâm tạo điều kiện để anh/chị tham gia các khóa đào tạo nâng cao, đào tạo tại bệnh viện và tham dự Hội thảo, Hội nghị về điều dưỡng?	1	2	3	4	5
R2	Lãnh đạo bệnh viện/lãnh đạo khoa có quan tâm và tạo điều kiện cho anh/chị được học tập nâng cao trình độ chuyên môn?	1	2	3	4	5
R3	Bệnh viện có quan tâm khen thưởng kịp thời khi điều dưỡng thực hiện tốt nhiệm vụ CSNB?	1	2	3	4	5

Xin cảm ơn Anh/Chị đã hợp tác

Phụ lục 8. CÁC BẢNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐỀN VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CSNB CỦA ĐDV

1. Mối liên quan giữa công tác tổ chức CSNB với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Công tác tổ chức CSNB		Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB		OR (95% CI)	χ^2	p
		Chưa hoàn thành	Hoàn thành			
Mô hình phân công chăm sóc	Điều dưỡng chăm sóc chính	58	80	1,37 (0,76-2,44)	1,103	0,294
	Chăm sóc nhóm	26	49			
Sự bố trí/phân công công việc	Chưa phù hợp	30	40	1,24 (0,69-2,21)	0,511	0,475
	Phù hợp	54	89			

2. Mối liên quan giữa điều kiện làm việc với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Điều kiện làm việc		Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB		OR (95% CI)	χ^2	p
		Chưa hoàn thành	Hoàn thành			
Môi trường làm việc	Chưa tốt	63	98	0,95 (0,50-1,80)	0,026	0,872
	Tốt	21	31			
CSVC phục vụ công tác CSNB	Chưa tốt	59	89	1,06 (0,53-1,93)	0,037	0,847
	Tốt	25	40			
TTB đáp ứng cho công tác CSNB	Chưa tốt	53	84	0,92 (0,52-1,62)	0,091	0,763
	Tốt	31	45			
Sự phối hợp trong CSNB của ĐDV	Chưa tốt	18	31	0,86 (0,45-1,67)	0,195	0,659
	Tốt	66	98			

3. Mối liên quan giữa sự quan tâm của lãnh đạo đến công tác điều dưỡng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Sự quan tâm của lãnh đạo đến công tác điều dưỡng		Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB		OR (95% CI)	χ^2	p
		Chưa hoàn thành	Hoàn thành			
Tập huấn quy định CSNB	Chưa quan tâm	19	34	0,82 (0,43-1,56)	0,380	0,537
	Quan tâm	65	95			
Đào tạo lại quy trình kỹ thuật CSNB	Chưa quan tâm	18	33	0,79 (0,41-1,53)	0,482	0,488
	Quan tâm	66	96			
Kiểm tra đánh giá công tác CSNB	Chưa quan tâm	20	27	1,18 (0,61-2,28)	0,245	0,620
	Quan tâm	64	102			

4. Mối liên quan giữa các chế độ, chính sách khuyến khích điều dưỡng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB của ĐDV

Các chế độ, chính sách khuyến khích điều dưỡng		Mức độ hoàn thành nhiệm vụ CSNB		OR (95% CI)	χ^2	p
		Chưa hoàn thành	Hoàn thành			
Tạo điều kiện cho ĐDV tham dự hội nghị, hội thảo về điều dưỡng	Chưa quan tâm	35	45	1,33 (0,76-2,35)	0,998	0,318
	Quan tâm	49	84			
Tạo điều kiện ĐDV học nâng cao trình độ	Chưa quan tâm	31	32	1,77 (0,98-3,22)	3,575	0,059
	Quan tâm	53	97			
Khen thưởng khi thực hiện tốt nhiệm vụ CSNB	Chưa quan tâm	34	48	1,15 (0,65-2,02)	0,229	0,632
	Quan tâm	50	81			

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA
SAU BẢO VỆ LUẬN VĂN

Họ tên học viên: **Nguyễn Thị Thùy Trâm**

Tên đề tài: **Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nguyễn Đình chiểu, tỉnh bến Tre năm 2014.**

TT	Nội dung cần chỉnh sửa theo biên bản	Nội dung đã chỉnh sửa *(mô tả chi tiết, ghi rõ số trang)*	Nội dung không chỉnh sửa
1.	Chỉnh sửa theo đúng format luận văn của trường về chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, nhận xét bảng biểu	Học viên đã chỉnh sửa lại: - Bỏ chữ viết tắt "WHO". - Trình bày lại tài liệu tham khảo theo đúng format của trường. - Viết nhận xét ngắn gọn dưới các bảng, biểu đồ.	
2.	Viết ngắn gọn lại phần tổng quan tài liệu.	Học viên đã lượt bỏ bớt các phần của tổng quan tài liệu: - Lịch sử ngành điều dưỡng (tr.4) - Các định nghĩa về điều dưỡng (tr.4) - Chức năng của người điều dưỡng (tr.5) - Thông tin chung và công tác CSNB tại BVNĐC (tr.17)	
3.	Chỉnh sửa lại tất cả các biểu đồ về tỷ lệ phần trăm. Các bảng về giá trị trung bình không hợp lý, cần chỉnh sửa.	Học viên đã chỉnh sửa lại: - Tất cả các biểu đồ về tỷ lệ phần trăm có bổ sung giá trị n cho từng tiểu mục (từ tr.29 – tr.35). - Phần phiên giải kết quả của các bảng về giá trị trung bình (tr.41 và tr.42)	
4.	Việc quan sát được tiến hành công khai tự nhiên => Nên đề cập phần hạn chế về quan sát công khai trong phần bàn luận.	Học viên đã bổ sung phần hạn chế của nghiên cứu do sử dụng phương pháp quan sát trực tiếp công khai vào phần cuối của Bàn luận (tr.60)	
5.	Phần kết luận chỉ nêu lên kết quả đạt được, bỏ phần bàn luận.	Học viên đã chỉnh sửa lại phần kết luận (tr.62)	

Xác nhận của GV hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

Lê Ngọc Quang

Học viên

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thùy Trâm